

WYZWANIA I POTRZEBY SEKTORA OPIEKUŃCZEGO W MAŁOPOLSCE



Perspektywa opiekunów oraz podmiotów realizujących opiekę



Wydawca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32

30-070 Kraków

tel. 12 422 06 36

e-mail: biuro@rops.krakow.pl

www.rops.krakow.pl

Opracowanie:

Anastazja Zakusiło

Katarzyna Porowska

Rafał Barański

Małgorzata Szlązak

Iwona Banasiewicz

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane z podaniem źródła.

Publikacja jest udostępniona na podstawie licencji CC BY 4.0.

Treść licencji dostępna pod adresem:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl>



Spis treści

Lista skrótów.....	5
Wstęp.....	6
Wnioski.....	12
Podstawowe dane.....	24
Wyniki badania	26
Zasoby opiekuńcze w Małopolsce – liczba podmiotów oraz rodzaj świadczonej opieki	26
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez OPS/CUS	27
Podmioty realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS.	32
Opieka stacjonarna w domach pomocy społecznej	33
Opiekunowie formalni w Małopolsce – podstawowe dane	36
Liczba opiekunów formalnych, forma i wymiar zatrudnienia	36
Opis społeczno-demograficzny opiekunów formalnych	44
Cudzoziemcy wśród opiekunów	47
Opiekunowie formalni o swojej pracy	50
Zadowolenie z pracy i jego wymiary	50
Środowisko pracy.....	54
Wypalenie zawodowe	55
Plany i obawy związane z zakończeniem lub zmianą pracy.....	59
Co wpływa na zadowolenie z pracy i wypalenie zawodowe?	64
Doświadczenia zawodowe opiekunów – problemy, motywacje i pozytywne aspekty pracy	70
Kompetencje i formy rozwoju opiekunów formalnych	78
Kompetencje.....	78
Szkolenia	87

Szkolenia opłacane samodzielnie	92
Najbardziej przydatne formy doskonalenia zawodowego	94
Superwizja	97
Sposoby motywowania pracowników	101
Wyzwania podmiotów świadczących opiekę	104
Wyzwania związane z konfliktem zbrojnym w Ukrainie	104
Wyzwania związane z pandemią COVID-19.....	106
Trudności w rekrutacji opiekunów do pracy	109
Metodologia badania	115
Populacja i przebieg badania	115
Badane obszary i metody badawcze	120
Analiza i wizualizacja wyników	124
Uwagi metodologiczne	126
Charakterystyka populacji a próby opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS	126
Próba opiekunów zatrudnionych u Zleceniobiorców OPS/CUS	128
Spis ilustracji	129
Wykresy	129
Rysunki.....	130
Tabele	132
Mapy.....	132
Aneks	133

Lista skrótów

ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

DPS – dom pomocy społecznej

OPS / CUS – ośrodek pomocy społecznej / centrum usług społecznych

Zleceniobiorcy – podmioty (firmy i organizacje pozarządowe) świadczące na zlecenie ośrodków pomocy społecznej / centrów usług społecznych usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, w tym specjalistyczne oraz specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – świadczenia z pomocy społecznej o charakterze niematerialnym, organizowane przez gminę, polegające na udzielaniu osobie potrzebującej pomocy w jej miejscu zamieszkania wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewnieniu opieki higienicznej, pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz – w miarę możliwości – utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmują zarówno gminne usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, jak również usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których świadczenie jest zlecane OPS/CUS przez administrację rządową.

Wstęp

Przekazujemy Państwu raport „Wyzwania i potrzeby sektora opiekuńczego w Małopolsce. Perspektywa opiekunów oraz podmiotów realizujących opiekę”, prezentujący wyniki badania przeprowadzonego w województwie małopolskim. Jest to trzecie z cyklu badań realizowanych przez ROPS w Krakowie, poświęconych dostępności i rozwojowi usług społecznych w regionie w kontekście procesu deinstytucjonalizacji.

Pierwsze opracowanie „Domy pomocy społecznej w Małopolsce wobec wyzwań deinstytucjonalizacji opieki długoterminowej”, koncentrowało się na identyfikacji barier utrudniających włączanie domów pomocy społecznej w świadczenie usług środowiskowych, analizie szans i możliwości, jakie polityka deinstytucjonalizacji stwarza dla lokalnych systemów wsparcia oraz ocenie stopnia wdrażania środowiskowych usług społecznych przez domy pomocy społecznej funkcjonujące w regionie.

Drugim raportem w cyklu były „Mieszkania wspomagane i treningowe w Małopolsce jako priorytet w rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”, które skupiało się na analizie aktualnego stanu mieszkalnictwa treningowego i wspomagane w regionie, identyfikacji barier jego rozwoju, wskazaniu problemów podmiotów je prowadzących oraz możliwych działań wspierających.

Niniejszy raport „Wyzwania i potrzeby sektora opiekuńczego w Małopolsce. Perspektywa opiekunów oraz podmiotów realizujących opiekę” powstał na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród kadry zarządzającej oraz opiekunów zatrudnionych w małopolskich domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych oraz podmiotach niepublicznych świadczących usługi opiekuńcze na zlecenie tych instytucji.

Celem opracowania jest przedstawienie aktualnej sytuacji sektora opiekuńczego w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji usług opiekuńczych, warunków pracy opiekunów formalnych, dostępności kadr, potrzeb szkoleniowych, uwarunkowań wpływających na funkcjonowanie jednostek opiekuńczych oraz wyzwań, z jakimi mierzą się instytucje realizujące wsparcie dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

W opracowaniu przedstawiono zarówno perspektywę instytucjonalną – opartą na odpowiedziach osób zarządzających badanymi podmiotami – jak i doświadczenia osób wykonujących zawód opiekuna. Analizie poddano m.in. kwestie związane z organizacją pracy, zatrudnieniem i kompetencjami kadr opiekuńczych, warunkami wykonywania pracy, poziomem satysfakcji zawodowej oraz problemem przeciążenia i wypalenia zawodowego.

Podjęcie tej tematyki jest szczególnie istotne w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństwa oraz rosnącego zapotrzebowania na opiekę. Obserwuje się dynamiczny wzrost liczby osób w najstarszych grupach wiekowych. Zwiększa się liczba osób w wieku 80 lat lub więcej – w latach 2015-2024 w kraju przybyło niemal 41 tys. osób w tym wieku, w tym 9,7 tys. w województwie małopolskim.

Wraz z wiekiem systematycznie maleje odsetek osób w pełni samodzielnych w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego¹. Jak wskazują autorzy badania „PolSenior 2”,

„(...) można wskazać na ważną cezurę, jaką stanowi 80. r.ż. Po osiągnięciu tego wieku, odsetek zdecydowanie potrzebujących pomocy istotnie wzrasta. Struktura ludności według wieku powinna być ważnym elementem procesu szacowania zapotrzebowania na różne formy wsparcia w lokalnych

¹ Gdański Uniwersytet Medyczny. *PolSenior2. Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem*. Gdańsk, 2021, s. 37, 185.

środowiskach. Wzrastająca liczba najstarszych mieszkańców wyraźnie wskazuje na potrzebę rozbudowy różnych form wsparcia, ze świadczeniami opiekuńczymi i pielęgnacyjnymi włącznie.”

Zmiany demograficzne już obecnie przekładają się na rosnącą presję na system usług społecznych i opiekuńczych. W wielu gminach obserwuje się wzrost liczby osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, przy jednoczesnych trudnościach kadrowych i organizacyjnych w zapewnieniu odpowiedniej dostępności usług opiekuńczych. Prognozy wskazują zaś na dalszy systematyczny wzrost najstarszej grupy wiekowej – w 2050 roku liczba osób w wieku 80 lat i więcej w Polsce ma wynieść blisko 3 mln, czyli o 84% więcej niż w 2024 r., z kolei w Małopolsce osiągnie poziom około 260 tys., co oznacza wzrost o 77% względem 2024 r.² Dane te wskazują na pilną konieczność umocnienia i rozbudowy systemu wsparcia opiekuńczego.

Jednym z podstawowych elementów systemu wsparcia w sektorze pomocy społecznej są usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania, a także opieka stacjonarna świadczona w domach pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pozwalają osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu pozostawać jak najdłużej w swoim środowisku. Z kolei placówki całodobowe zapewniają wsparcie osobom, których stan zdrowia lub sytuacja życiowa uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie wyłącznie przy wsparciu w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W realizację tych form opieki zaangażowanych jest wiele podmiotów – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Kluczową funkcję w systemie opieki odgrywają ośrodki pomocy społecznej (OPS) oraz centra usług społecznych (CUS), które organizują i koordynują usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania³, a także

² Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych.

³ Ustawa o pomocy społecznej, art. 17.

jednostki świadczące całodobową opiekę dla osób wymagających stałego wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności – w tym domy pomocy społecznej⁴ oraz placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku⁵.

Centralną rolę w tym systemie pełnią osoby wykonujące zawód opiekuna, bezpośrednio świadczące pomoc osobom potrzebującym wsparcia. To one wykonują wymagającą pracę polegającą m.in. na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnieniu kontaktów z otoczeniem⁶. Zawód opiekuna wiąże się z wieloma wyzwaniem, takimi jak duża odpowiedzialność oraz obciążenie fizyczne i emocjonalne. Jednocześnie zawód ten nie cieszy się znacznym uznaniem społecznym, a praca w nim jest stosunkowo nisko wynagradzana, co przekłada się na trudności z pozyskiwaniem nowych pracowników do sektora opieki⁷.

Wszystkie te czynniki podkreślają znaczenie pogłębionej diagnozy sytuacji osób wykonujących zawód opiekuna. Ten raport charakteryzuje grupę opiekunów w województwie małopolskim. Zawiera on informację o liczbie opiekunów, formie i wymiarze ich zatrudnienia, a także podstawowych cechach społeczno-demograficznych tej grupy zawodowej w Małopolsce. W dalszej części opracowania zaprezentowano również opinie opiekunów formalnych na temat różnych aspektów ich pracy, w tym zadowolenia z pracy, środowiska zawodowego oraz doświadczeń związanych z obciążeniem i wypaleniem zawodowym.

Istotnym elementem raportu jest także analiza kompetencji opiekunów formalnych oraz możliwości ich rozwoju zawodowego. W opracowaniu

⁴ Tamże, art. 54.

⁵ Tamże, art. 68.

⁶ Tamże, art. 50.

⁷ Grewiński M., Lizut J., Rabiej P. (red.), Ogólnopolska diagnoza deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski, ROPS Toruń / Uczelnia Korczaka, Elipsa, Warszawa 2024, s. 104-105.

uwzględniono m.in. ocenę posiadanych przez opiekunów umiejętności dokonaną przez osoby zarządzające podmiotami świadczącymi opiekę, jak również samych opiekunów, czy dostęp do szkoleń i superwizji. Dzięki temu możliwe jest lepsze zrozumienie potrzeb szkoleniowych tej grupy zawodowej oraz czynników wpływających na jakość świadczonej opieki.

Raport odnosi się również do szerszego kontekstu funkcjonowania systemu opieki w województwie małopolskim, w tym do zmian wywołanych przez pandemię COVID-19 oraz konflikt zbrojny w Ukrainie. Wydarzenia te wpłynęły na sposób organizacji pracy instytucji pomocowych, dostępność pracowników oraz zakres realizowanych usług. Odrębna część opracowania poświęcona została także problemowi braków kadrowych wśród opiekunów formalnych oraz trudnościom związanym z rekrutacją nowych pracowników do tego sektora. Wyniki badania wskazują, że system opieki mierzy się z problemami związanymi m.in. ze starzeniem się kadr i trudnościami w pozyskiwaniu nowych pracowników, przy jednoczesnym niewystarczającym poziomie wynagrodzeń. Jednocześnie jego istotnym zasobem pozostają wysoka motywacja opiekunów, poczucie sensu wykonywanej pracy, a także posiadane kwalifikacje i kompetencje, szczególnie widoczne wśród kadr domów pomocy społecznej.

Przedstawione w raporcie wyniki mają na celu nie tylko opisanie obecnej sytuacji w regionie, ale również wskazanie kluczowych wyzwań stojących przed sektorem opiekuńczym. Wnioski z badania mogą stanowić podstawę do dalszych działań w zakresie planowania polityki społecznej, rozwoju usług opiekuńczych oraz wsparcia kadr opiekuńczych.

Raport dostarcza wiedzy pozwalającej lepiej zrozumieć wyzwania stojące przed sektorem opiekuńczym, problemy codziennej pracy opiekunów i osób zarządzających badanymi podmiotami. Dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie informacje zgromadzone w badaniu są ważne

dla organizacji działań wspierających, stanowią także cenną wiedzę istotną w procesie rozwoju usług społecznych i ich denistytucjonalizacji.

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie użyteczne dla podmiotów odpowiedzialnych za organizację oraz realizację usług opiekuńczych lub opieki stacjonarnej, a także dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem systemu opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w województwie małopolskim i poza nim.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu – kadrze zarządzającej i pracownikom ośrodków pomocy społecznej i centrów usług społecznych oraz małopolskich domów pomocy społecznej, a także przedstawicielom podmiotów, którym małopolskie gminy zlecają realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Wioletta Wilimska

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Wnioski

Wzrost zapotrzebowania na opiekę a wyzwania kadrowe

Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze rośnie na przestrzeni minionych lat a dynamika tego procesu jest podobna zarówno w przypadku opieki instytucjonalnej, jak i świadczonej w miejscu zamieszkania. W województwie małopolskim większość – bo około 70% OPS/CUS, zapytanych w ankiecie o zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze oraz opiekę całodobową w DPS na ich terenie, wskazuje na wzrost zapotrzebowania w ciągu ostatnich 5 lat.

Jednocześnie w systemie widoczne są braki kadrowe – co trzeci Zleceniobiorca z sektora niepublicznego, co czwarty OPS/CUS i niemal co piąty DPS wskazał, iż obecna liczba osób zatrudnionych w jednostce jest niewystarczająca.

Co więcej, ponad połowa DPS, OPS/CUS oraz Zleceniobiorców doświadcza trudności podczas rekrutacji, głównie z powodu niskiego zainteresowania potencjalnych kandydatów pracą w takim charakterze ze względu na niskie wynagrodzenia. Sytuacja ta wynika w opinii badanych podmiotów głównie z niskiego wynagrodzenia i niskiego prestiżu zawodu opiekuna, a także wymagającego charakteru tej pracy.

Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie zwiększyły potrzeby opiekuńcze

Pandemia COVID-19 oraz skutki wojny w Ukrainie pogłębiły istniejące problemy systemu opieki w miejscu zamieszkania oraz opieki stacjonarnej, zwiększając zapotrzebowanie na opiekę, obciążenie pracą personelu oraz presję organizacyjną i finansową na podmioty opiekuńcze. Choć część DPS i podmiotów realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS odnotowała wzrost liczby kandydatów i pracowników pochodzenia ukraińskiego,

zjawisko to miało ograniczony charakter i nie przełożyło się na istotną poprawę sytuacji kadrowej całego sektora. Jednocześnie zarówno pandemia, jak i napływ ludności ukraińskiej ujawniły dodatkowe bariery związane m.in. z wypaleniem zawodowym opiekunów, trudnościami rekrutacyjnymi, wzrostem kosztów funkcjonowania jednostek, problemami organizacyjnymi oraz wyzwaniem komunikacyjnymi i kulturowymi. Mimo pojawienia się części pozytywnych zmian – takich jak rozwój narzędzi cyfrowych, poprawa standardów sanitarnych czy większa elastyczność organizacyjna – te kryzysy wzmocniły presję na system opieki i uwidoczniły jego ograniczoną odporność na sytuacje nadzwyczajne.

Sposoby organizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Dominującym modelem organizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania pozostaje bezpośrednie zatrudnianie opiekunów przez OPS/CUS, co wskazuje na kluczową rolę samorządowych jednostek pomocy społecznej w zapewnianiu podstawowego wsparcia opiekuńczego. W większych miastach częściej rozwijany jest model oparty na współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jednak rozwiązanie to ma ograniczony zasięg i słabiej funkcjonuje poza obszarami miejskimi. Jednocześnie system charakteryzuje się znacznie mniejszą dostępnością usług specjalistycznych – gminne usługi specjalistyczne świadczy 22% OPS/CUS, a specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 40% OPS/CUS w Małopolsce. Dane te sugerują, że obecny model organizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lepiej odpowiada na podstawowe potrzeby opiekuńcze niż na rosnące i bardziej złożone potrzeby zdrowotne oraz psychospołeczne osób wymagających wsparcia.

Mieszkańcy obszarów wiejskich mają słabszy dostęp do opieki

Podaż usług opiekuńczych i opieki stacjonarnej jest zróżnicowana terytorialnie – jest ona bardziej ograniczona na obszarach wiejskich oraz peryferyjnych. Główne

bariery wynikają z rozproszenia gospodarstw domowych oraz mniejszej obecności podmiotów świadczących opiekę stacjonarną, w tym domów pomocy społecznej, na obszarach wiejskich. W obszarze opieki w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich znacznie rzadziej niż w miastach funkcjonuje również model oparty na współpracy OPS/CUS z zewnętrznymi podmiotami niepublicznymi, co ogranicza dostęp mieszkańców obszarów wiejskich do tego rodzaju usług.

Domy pomocy społecznej to główne zaplecze kadrowe systemu opieki

Badanie pokazuje, że w województwie małopolskim DPS dysponują wyraźnie większym potencjałem kadrowym i organizacyjnym niż podmioty świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zwłaszcza pod względem stabilności oraz formy zatrudnienia, a także wykształcenia kierunkowego.

Domy pomocy społecznej są głównym zasobem opiekuńczym w ramach systemu pomocy społecznej w Małopolsce. Zatrudniają one 57% wszystkich opiekunów zidentyfikowanych w badaniu (2 297 z 4 017 osób)⁸. Opiekunowie w domach pomocy społecznej znacznie częściej pracują w pełnym wymiarze czasu pracy aniżeli opiekunowie świadczący opiekę środowiskową. Dlatego to właśnie DPS odpowiadają za największą część rzeczywistego nakładu pracy opiekuńczej w publicznym systemie wsparcia – szacunkowo około dwie trzecie całkowitego czasu pracy opiekunów przypada na domy pomocy społecznej i zatrudnioną w nich kadrę.

Specyfika pracy opiekuńczej w DPS wyraża się także sprawowaniem opieki w formule 24/7. Tymczasem usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania realizowane są co do zasady w dni powszednie. Tylko 4%

⁸ Stopa realizacji próby wyniosła dla DPS – 93%, dla OPS/CUS – 88%, dla Zleceniobiorców – 16 na 18 podmiotów.

opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS pracuje w godzinach nocnych, a 23% – w weekendy (biorąc pod uwagę wszystkie miejsca zatrudnienia).

Jednocześnie przewagi te nie oznaczają automatycznie wyższej jakości opieki we wszystkich jej wymiarach. Wyniki wskazują, że kadra DPS jest lepiej przygotowana do realizacji zadań pielęgnacyjno-opiekuńczych niż do działań ukierunkowanych na ocenę funkcjonowania mieszkańców, planowanie wsparcia i wzmacnianie samodzielności. Oznacza to, że DPS pełnią obecnie kluczową rolę w systemie opieki długoterminowej, ale ich model pracy nie odpowiada w pełni celom deinstytucjonalizacji rozumianej jako rozwój wsparcia zorientowanego na autonomię i funkcjonowanie w społeczności. Z kolei opieka środowiskowa, choć uznawana za bardziej zgodną z tym kierunkiem, pozostaje niedostatecznie rozwinięta pod względem zasobów kadrowych, organizacji czasu pracy i dostępności wsparcia. W konsekwencji głównym problemem systemowym w województwie małopolskim jest strukturalny deficyt kadr opiekuńczych oraz nieadekwatne warunki pracy i płacy w całym sektorze.

Silna feminizacja zawodu opiekuna oraz starzenie się kadr opiekuńczych

Zawód opiekuna w systemie pomocy społecznej w województwie małopolskim jest niemal całkowicie zdominowany przez kobiety. Udział mężczyzn w tej profesji pozostaje marginalny, mimo że praca ta bywa wymagająca fizycznie i wiąże się m.in. z koniecznością wspierania osób o ograniczonej mobilności czy radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami. Struktura płci kadr opiekuńczych wskazuje na utrwalony społeczny podział ról w obszarze świadczenia opieki.

Kolejnym wyzwaniem jest wysoki udział osób w zaawansowanym wieku wśród kadr opiekuńczych. Niemal połowa badanych opiekunów (48%) miała powyżej 50 lat, czyli była w wieku okołoemerytalnym, bądź też osiągnęła już wiek emerytalny. Dane te pokazują, że duża grupa spośród obecnie zatrudnionych opiekunów będzie w najbliższych latach odchodzić na emeryturę, a trudności jakie –

już obecnie – identyfikuje się na etapie rekrutacji do pracy opiekuńczej, będą dalej się pogłębiać.

Niewielka, lecz rosnąca rola cudzoziemców w systemie opieki

Cudzoziemcy nadal odgrywają marginalną rolę wśród kadr opiekuńczych w Małopolsce, jednak w ostatnich latach widoczny jest stopniowy wzrost ich znaczenia, szczególnie w przypadku osób pochodzących z Ukrainy. Zatrudnianie opiekunów cudzoziemskich koncentruje się głównie w DPS oraz w podmiotach realizujących usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS, podczas gdy w samych OPS/CUS zjawisko to pozostaje sporadyczne. Mimo niemal czterokrotnego wzrostu liczby opiekunów z Ukrainy od 2019 r., cudzoziemcy stanowili jedynie 3,5% wszystkich opiekunów zatrudnionych w badanych jednostkach, co wskazuje, że ich obecność częściowo łagodzi problemy kadrowe, ale nie stanowi rozwiązania deficytu personelu opiekuńczego.

Wysoka samoocena kompetencji opiekunów a braki kompetencyjne

Opiekunowie wysoko oceniają własne kompetencje zawodowe, szczególnie w zakresie codziennej opieki, pielęgnacji i wspierania osób niesamodzielnych, co wskazuje na duże znaczenie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu pracy. Jednocześnie perspektywa kadry zarządzającej oraz analiza kwalifikacji formalnych ujawniają istotne deficyty kompetencyjne w systemie opieki. Stosunkowo niewielka część opiekunów posiada kierunkowe wykształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu (11% opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców OPS/CUS, 27% opiekunów w OPS/CUS oraz 55% opiekunów w DPS). Co więcej, nawet formalne przygotowanie nie zawsze odpowiada rzeczywistym wymaganiom pracy opiekuńczej.

Największe potrzeby rozwojowe dotyczą kompetencji związanych z podstawową znajomością odpowiednich przepisów prawnych, ocenianiem stanu klienta i planowaniem pomocy, skuteczną komunikacją, aktywizowaniem klientów do samodzielności, a także radzeniem sobie przez opiekunów ze stresem i trudnymi sytuacjami w pracy. Wyniki sugerują, że obecny system przygotowania kadr opiekuńczych w dużej mierze opiera się na uczeniu poprzez praktykę zawodową, przy niewystarczającym wsparciu w zakresie systemowego kształcenia i doskonalenia kompetencji.

Szkolenia i kursy są najczęściej wskazywaną formą rozwoju zawodowego

Najbardziej przydatną formą podnoszenia kompetencji w opinii opiekunów formalnych w województwie małopolskim są kursy i szkolenia. Wskazywała je zdecydowana większość respondentów we wszystkich badanych grupach. Inne formy rozwoju, takie jak studia czy superwizja, były wybierane zdecydowanie rzadziej. Wyniki te sugerują, że krótsze, praktyczne formy doskonalenia zawodowego są postrzegane przez opiekunów w Małopolsce jako najbardziej adekwatne do specyfiki ich pracy.

Wśród potencjalnych tematów szkoleń i kursów za najważniejsze opiekunowie uznali zagadnienia związane z profilaktyką stresu i wypalenia zawodowego, bezpieczeństwem osobistym pracownika, metodami i standardami opieki nad osobami niesamodzielnymi, bezpieczeństwem klienta i pierwszą pomocą, a także komunikacją i opieką nad osobami z demencją. Ten ostatni obszar nabiera w ostatnich czasach szczególnego znaczenia z uwagi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz wzrost liczby osób dotkniętych chorobami otępiennymi.

Superwizja jest rzadko wykorzystywaną formą wsparcia zawodowego

Wyniki badania wskazują na bardzo ograniczone wykorzystanie superwizji w pracy opiekunów w województwie małopolskim. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zdecydowana większość opiekunów pracujących w DPS (84%) oraz w podmiotach realizujących usługi na zlecenie OPS/CUS (72%), a także niemal wszyscy opiekunowie świadczący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania zatrudnieni w OPS/CUS (99%) nie uczestniczyli w spotkaniach superwizyjnych. Uzyskane wyniki są spójne z deklaracjami przedstawicieli badanych instytucji w Małopolsce, co wskazuje, że superwizja pozostaje wciąż rzadko stosowanym elementem systemu wsparcia zawodowego opiekunów w systemie pomocy społecznej.

Niski poziom wynagrodzeń i ograniczona stabilność zatrudnienia

W województwie małopolskim kadra zatrudniona w DPS najczęściej pracuje na podstawie umów o pracę, z reguły na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu. Dla porównania znacznie mniejszy odsetek kadr opiekuńczych angażowanych przez OPS/CUS jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W przypadku podmiotów realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS odsetek pracujących na umowy o pracę jest jeszcze niższy. Podmioty realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS funkcjonują w warunkach konkurencyjności oraz presji kosztowej. Konieczność konkurencyjności cen z innymi podmiotami może przekładać się na ograniczone możliwości oferowania stabilnych form zatrudnienia oraz wyższych wynagrodzeń. W wielu przypadkach do czasu pracy nie wlicza się czasu dojazdu do podopiecznych. W rezultacie praca w tym sektorze bywa traktowana jako zajęcie dodatkowe, często wykonywane przez osoby będące już na emeryturze.

Praca opiekuna wiąże się często z relatywnie niskimi zarobkami w porównaniu z poziomem odpowiedzialności oraz obciążenia fizycznego i emocjonalnego. Najmniejsze zadowolenie z poziomu zarobków w Małopolsce deklarują opiekunowie zatrudnieni w DPS – aż 4 na 10 opiekunów uważa własne wynagrodzenie za zbyt niskie. W części podmiotów w Małopolsce znaczący udział mają również niestabilne formy zatrudnienia, w szczególności umowy cywilnoprawne. W szczególności, na umowę zlecenie pracuje 52% opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS oraz aż 92% opiekunów zatrudnionych w podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS. Czynniki te mogą wpływać na rotację pracowników oraz ograniczać zainteresowanie pracą w sektorze opiekuńczym w województwie małopolskim.

Obciążenie pracą oraz niepokryte koszty wśród wyzwań opiekunów

W Małopolsce w porównaniu do opieki środowiskowej, opiece sprawowanej w DPS częściej towarzyszy poczucie dużej ilości pracy, duża skala napięć i stresu, niskie, subiektywnie odczuwane, uznanie społeczne, poczucie niedocenienia z tytułu wykonywanej pracy i obniżona satysfakcja z niej. Kadra DPS częściej niż opiekunowie pracujący w środowisku czuje się emocjonalnie wyczerpana, wskazuje na nadmiar obowiązków, cechuje się poczuciem zbyt uciążliwej i niebezpiecznej pracy, ma często poczucie niesprawiedliwego traktowania przez innych w miejscu pracy, skarży się na kolizję pracy z życiem prywatnym i nadmiar obowiązków. Pomimo tego kadra DPS deklaruje stosunkowo wysoki, podobny względem opiekunów pracujących w środowisku, poziom poczucia sensu wykonywanej pracy oraz dumę z rodzaju wykonywanych zadań i miejsca zatrudnienia. Rzadko też wskazuje na zamiar zmiany pracy.

Opiekunowie pracujący w OPS/CUS i DPS w Małopolsce mierzą się z różnymi wyzwaniami związanymi ze specyfiką ich pracy. W przypadku opiekunów realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach OPS/CUS

istotną kwestią jest organizacja pracy, w tym konieczność dojazdów do podopiecznych, które nie zawsze są wliczane do czasu pracy, a także niewystarczające rekompensaty kosztów transportu przez pracodawców. Kolejnym wyzwaniem jest charakter relacji z osobami korzystającymi z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – często oparty na dużym zaufaniu i osobistym zaangażowaniu opiekuna. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w których opiekunowie pozostają w kontakcie z podopiecznymi także poza formalnymi godzinami pracy, co sprawia, że rzeczywisty czas poświęcany pracy bywa większy niż deklarowany. Z kolei pracownicy domów pomocy społecznej wskazują na wysokie obciążenie pracą, wynikające m.in. z intensywności opieki nad mieszkańcami wymagającymi stałego wsparcia – nawet połowa opiekunów w DPS deklaruje wysoki poziom napięć i stresu w związku z pracą. Dodatkowym wyzwaniem są trudne sytuacje w relacjach z mieszkańcami, w tym przypadki agresji lub innych zachowań problemowych, co przekłada się na dość niską ocenę poziomu bezpieczeństwa w pracy – niemal 4 na 10 opiekunów w DPS nie było z niego zadowolonych. W praktyce pojawiają się również problemy dotyczące zachowania równowagi między prawami mieszkańców a bezpieczeństwem i komfortem pracy personelu. Dodatkowo, dla części pracowników trudność stanowi system zmianowy, obejmujący pracę w weekendy i w godzinach nocnych, który bywa trudny do pogodzenia z obowiązkami rodzinnymi.

Wysoka ocena relacji w pracy, niskie zadowolenie z wynagrodzenia

Oceny opiekunów pokazują, że najwyżej ocenianymi aspektami pracy są relacje interpersonalne – zarówno stosunki między kierownictwem a pracownikami, jak i relacje między współpracownikami oraz względnie dobra organizacja codziennej pracy. Szczególnie wysokie oceny tych obszarów widoczne były wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze

na zlecenie OPS/CUS. Najniżej oceniano za to poziom wynagrodzeń, możliwości awansu i rozwoju, poziom napięć i stresu w pracy oraz uznanie społeczne zawodu. Szczególnie niskie oceny pracy zauważono wśród opiekunów w DPS, gdzie bardziej wykwalifikowana i doświadczona kadra częściej odczuwała przeciążenie, stres oraz niedopasowanie warunków pracy do swoich kompetencji i oczekiwań. Wyniki sugerują, że główne problemy pracy opiekuńczej mają charakter systemowy, a utrzymanie stabilnych kadr opiekuńczych może być coraz trudniejsze bez poprawy prestiżu zawodu, warunków pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Wypalenie zawodowe to kluczowy czynnik wpływający na ocenę pracy

W województwie małopolskim poziom wypalenia zawodowego jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących sposób postrzegania pracy przez pracowników oraz ich skłonność do rozważania zmiany zatrudnienia. Długotrwałe funkcjonowanie przez opiekunów (szczególnie tych pracujących w domach pomocy społecznej) w obciążającym fizycznie i psychicznie środowisku sprzyja pogłębieniu się stresu i wypalenia zawodowego na przestrzeni lat pracy. Istotną rolę ochronną w tym procesie odgrywają czynniki związane z relacjami w miejscu pracy, w szczególności atmosfera w pracy oraz możliwość polegania na wsparciu współpracowników w razie potrzeby. Wyniki te sugerują, że wzmacnianie pozytywnych relacji, współpracy i wzajemnego wspierania się w zespole może stanowić ważny element działań ograniczających wypalenie zawodowe oraz sprzyjających stabilności zatrudnienia.

Dodatkowe sposoby motywowania pracowników są rzadko stosowane

Nie wszystkie badane podmioty w województwie małopolskim stosują dodatkowe narzędzia motywowania pracowników. Najczęściej wskazywanymi

formami był elastyczny czas pracy – szczególnie w OPS/CUS oraz w podmiotach realizujących usługi na ich zlecenie – oraz dofinansowanie wypoczynku, częściej występujące w DPS. W wielu przypadkach były to jednak rozwiązania wynikające z charakteru pracy opiekuńczej lub z przepisów regulujących zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Wyniki badania sugerują, że kwestie związane z systemowym motywowaniem pracowników są w praktyce stosunkowo słabo rozwinięte zarówno w podmiotach realizujących opiekę środowiskową, jak i w instytucjach zapewniających opiekę stacjonarną.

Plany zakończenia pracy są głównie związane z przejściem na emeryturę

Większość opiekunów raczej nie obawia się utraty pracy, a także nie planuje jej zmiany, co może świadczyć o wysokiej stabilności zatrudnienia w sektorze opieki. Jednocześnie wyniki sugerują, że stabilność ta nie wynika wyłącznie z satysfakcji zawodowej, lecz także po części ze struktury wieku, ograniczonej mobilności oraz postrzeganych możliwości na rynku pracy. Szczególnie istotną rolę odgrywa duży udział opiekunów w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym, szczególnie w podmiotach realizujących usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS. Podczas gdy osobom w wieku 50-59 lat może zależeć na utrzymaniu stabilnego zatrudnienia w okresie okołoemerytalnym, dla osób w wieku emerytalnym praca opiekuńcza często może stanowić jedynie dodatkowe źródło dochodu. Niezależnie od indywidualnych decyzji, niewielka chęć w zakresie zmiany lub zakończenia pracy jest związana z tym, że osoby należące do starszych grup wiekowych rzadko postrzegają jako możliwe znalezienie innej pracy co najmniej tak samo dobrej jak obecna. Potencjalne odejścia z pracy częściej wiążą się zatem z przejściem na emeryturę, zakończeniem aktywności zawodowej lub wygaśnięciem umów niż z chęcią zmiany zawodu.

Jednocześnie opiekunowie – również ci stosunkowo nisko oceniający własną pracę – relatywnie rzadko deklarowali zamiar odejścia, co może świadczyć

o przywiązaniu do wykonywanej pracy bądź ograniczonej dostępności alternatyw zawodowych. Wyniki sugerują więc, że jednym z głównych wyzwań systemu opieki będzie w najbliższych latach nie tyle odpływ pracowników do innych branż, ile stopniowe wycofywanie się starzejących się kadr z rynku pracy przy niewystarczającym napływie nowych osób do zawodu.

System opieki opiera się w dużym stopniu na wewnętrznej motywacji opiekunów

Badanie pokazuje, że kluczowym czynnikiem podtrzymującym zaangażowanie opiekunów jest silna motywacja wewnętrzna oparta na poczuciu sensu pracy, relacjach z podopiecznymi oraz przekonaniu o społecznej wartości wykonywanego zawodu. Satysfakcja płynąca z pomagania innym, wdzięczność podopiecznych oraz dobra atmosfera i wsparcie ze strony przełożonych pełnią istotną funkcję ochronną wobec przeciążenia i ryzyka wypalenia zawodowego. Jednocześnie wyniki wskazują, że odporność systemu opieki w dużym stopniu opiera się na indywidualnym zaangażowaniu pracowników, mimo utrzymujących się problemów systemowych, takich jak niskie wynagrodzenia, wysokie obciążenie pracą czy niepewność zatrudnienia. W perspektywie jednak może być trudne długofalowe utrzymanie motywacji i stabilności kadr opiekuńczych bez poprawy warunków pracy i większego instytucjonalnego wsparcia.

Podstawowe dane



93% opiekunów to kobiety



49 lat to średni wiek opiekunów



37% opiekunów posiada wykształcenie kierunkowe w zawodzie opiekuna



31% opiekunów w DPS pracuje powyżej 40 godzin tygodniowo



20% OPS/CUS zleca wykonywanie usług opiekuńczych podmiotom zewnętrznym



87% OPS/CUS zatrudnia opiekunów do wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania



18 podmiotów w Małopolsce wykonuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS



57% wszystkich opiekunów zatrudniają DPS



33% opiekunów jest zadowolonych z wysokości swojego wynagrodzenia



75% opiekunów dobrze ocenia środowisko społeczne w pracy



38% opiekunów chciałoby wziąć udział w szkoleniach w zakresie profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego

- 
37% opiekunów chciałoby wziąć udział w szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa osobistego pracownika
- 
55% podmiotów organizowało szkolenia dla opiekunów w ostatnich 12 miesiącach
- 
14% opiekunów wzięło udział w superwizji w ostatnich 12 miesiącach
- 
13 mieszkańców przypada średnio na jednego opiekuna w DPS na zmianie dziennej
- 
28 mieszkańców przypada średnio na jednego opiekuna w DPS na zmianie nocnej
- 
16% podmiotów zatrudnia opiekunów pochodzenia innego niż polskie
- 
18% podmiotów odnotowało wzrost liczby kandydatów na opiekunów pochodzenia ukraińskiego od wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie
- 
19% OPS/CUS odnotowało wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz opiekę w DPS na swoim terenie od wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie
- 
60% podmiotów odnotowało większy poziom stresu i wypalenia zawodowego opiekunów w związku z pandemią COVID-19
- 
67% podmiotów w ostatnich 12 miesiącach poszukiwało osoby na stanowisko opiekuna
- 
60% podmiotów poszukujących pracowników na stanowisko opiekuna w ostatnich 12 miesiącach napotkało trudności w znalezieniu odpowiedniej osoby

Wyniki badania

Zasoby opiekuńcze w Małopolsce – liczba podmiotów oraz rodzaj świadczonej opieki⁹

W momencie realizacji badania w Małopolsce funkcjonowały 183 jednostki odpowiedzialne za realizację zadań gminy z obszaru pomocy społecznej (w tym 166 OPS oraz 17 CUS)¹⁰ – po jednej w każdej gminie. Zadaniem tych jednostek jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na rzecz mieszkańców gminy, w tym specjalistycznych, ale również dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co jest zadaniem zleconym gminom z zakresu administracji rządowej. Z kolei jeżeli chodzi o opiekę stacjonarną, na terenie województwa małopolskiego w momencie realizacji badania funkcjonowało 90 domów pomocy społecznej przeznaczonych dla różnych grup mieszkańców.

Odpowiedzi na pytania ankiety pokazują, że większość małopolskich OPS/CUS zatrudniało opiekunów do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie gminy. Część OPS/CUS z kolei zlecało wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (lub jakąś ich część) podmiotom zewnętrznym – organizacjom pozarządowym oraz firmom prywatnym. Wreszcie, część OPS/CUS realizowało usługi opiekuńcze w inny sposób – przykładowo, w ramach porozumienia z inną jednostką samorządową lub poprzez odrębną jednostkę organizacyjną gminy. W zakresie zlecenia wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, według stanu na początek 2025 r.

⁹ W tej publikacji badaniem objęto: ośrodki pomocy społecznej (OPS), centra usług społecznych (CUS), podmioty realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS oraz domy pomocy społecznej. W badaniu nie uwzględniono placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

¹⁰ Stan na 11.05.2026 r.

małopolskie OPS/CUS wykazały współpracę w tym zakresie z 22 podmiotami świadczącymi opiekę w miejscu zamieszkania¹¹.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez OPS/CUS

Przeważająca część OPS/CUS w Małopolsce, które udzieliły odpowiedzi na pytania ankiety, realizowała usługi opiekuńcze przynajmniej jednego rodzaju – dotyczyło to 152 ze 160, czyli 95% podmiotów¹², które wzięły udział w badaniu. 8 OPS/CUS (5% ośrodków biorących udział w badaniu) nie realizowało usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Dominujący sposób organizowania i świadczenia usług opiekuńczych przez małopolskie OPS/CUS polega na bezpośredniej ich realizacji przez osoby zatrudniane w tych podmiotach. Wśród 160 OPS/CUS, które wzięły udział w badaniu łącznie 139 podmiotów zatrudniało opiekunów do realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W szczególności:

- 115 (72%) realizowało usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (w tym specjalistyczne oraz specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi) wyłącznie zatrudniając opiekunów;
- 24 OPS/CUS (15%) realizowało usługi opiekuńcze zarówno za pomocą własnej kadry, jak również w inny sposób, w tym 19 – zlecając realizację

¹¹ Źródło: ROPS w Krakowie – rozeznanie wśród gmin w Małopolsce przed rozpoczęciem badania, którego wyniki przedstawia ta publikacja. Dane według stanu na styczeń 2025 r. Uwaga: część podmiotów świadczyła usługi dla więcej niż jednej gminy, w związku z czym liczba gmin zlecających wykonywanie usług w miejscu zamieszkania podmiotom zewnętrznym była większa niż liczba takich podmiotów.

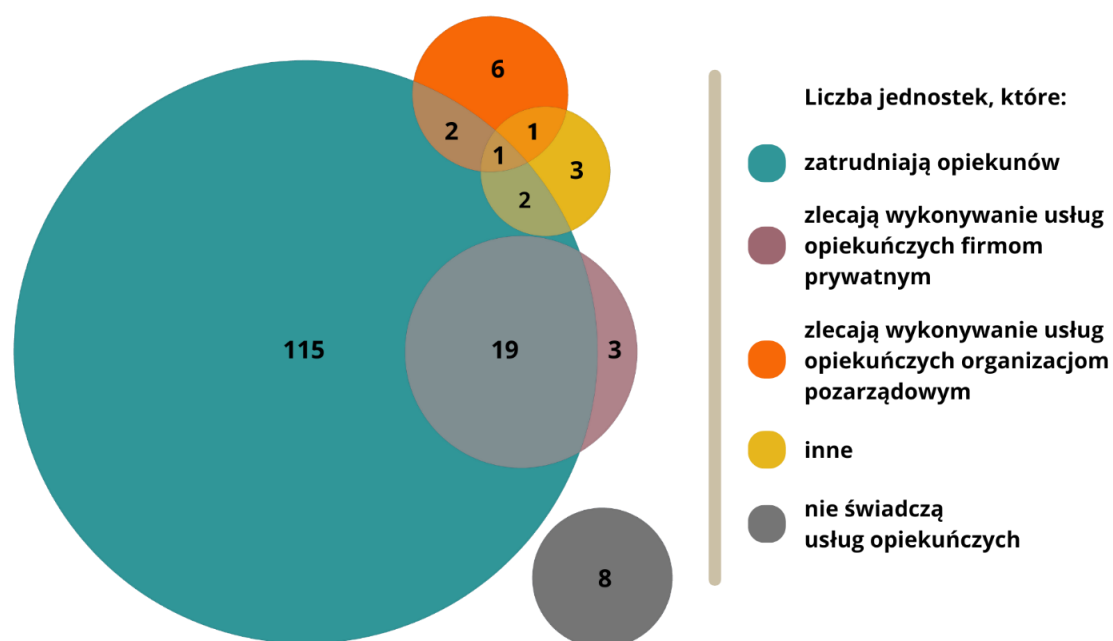
¹² Wśród 160 OPS/CUS, które wzięły udział w badaniu, były jednostki zarówno realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – zatrudniając opiekunów, zlecając realizację innym podmiotom lub w inny sposób – jak również nie realizujące usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na moment badania.

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania firmom komercyjnym, 3 – zlecając ją organizacjom pozarządowym, a 3 – jeszcze inaczej.¹³

Z kolei 13 OPS/CUS (8%) realizowało usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania nie zatrudniając własnych opiekunów, w tym:

- 3 z nich zlecały wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania firmom komercyjnym;
- 6 zlecało ich wykonywanie organizacjom pozarządowym;
- 3 realizowały je w inny sposób;
- jeden OPS realizował usługi opiekuńcze zarówno zlecając ich wykonywanie organizacji pozarządowej, jak i w inny sposób.

Wykres 1. Sposoby realizacji usług opiekuńczych przez OPS/CUS



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS) = 160.

Małopolskie OPS/CUS najczęściej świadczyły usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania zatrudniając opiekunów w jednostce – jak wspomniano wyżej, dotyczyło to 87% OPS/CUS, które wzięły udział w badaniu – przy czym najczęściej

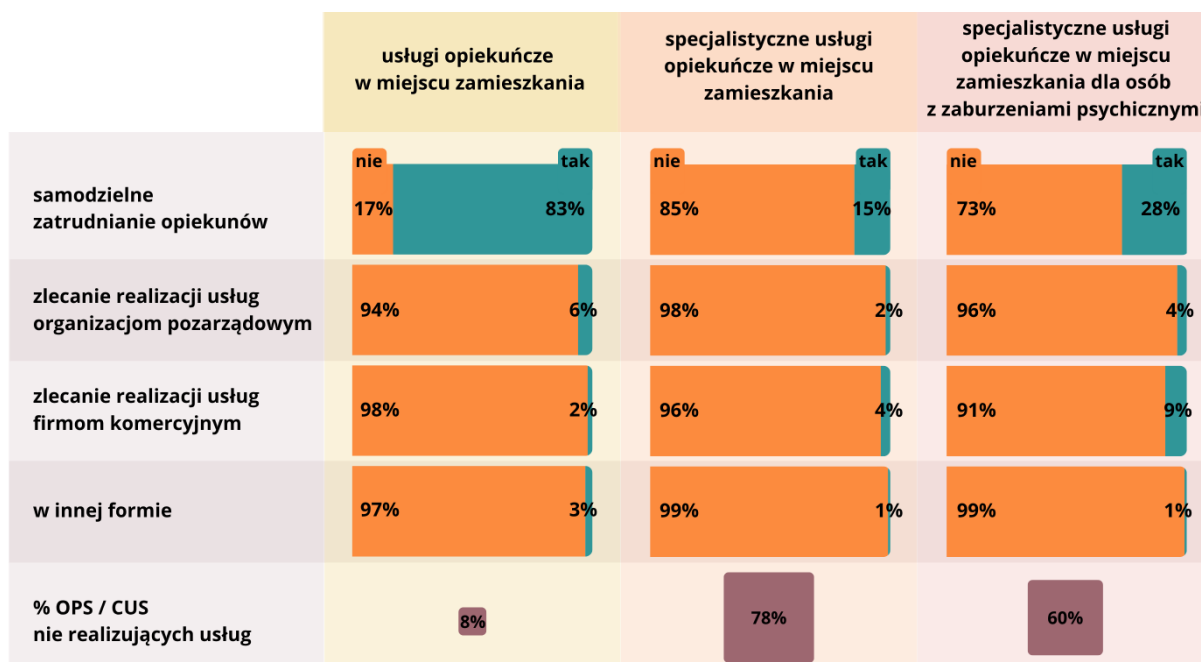
¹³ W tym jeden podmiot realizował usługi opiekuńcze zarówno zatrudniając opiekunów, jak również zlecając ich wykonywanie organizacjom pozarządowym i realizując je w inny sposób (w ramach porozumienia z DPS).

były w tej formie realizowane usługi opiekuńcze inne niż specjalistyczne lub specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ogółem 92% OPS/CUS świadczyło na terenie własnej gminy gminne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania inne niż specjalistyczne, w tym w 9 na 10 przypadków – zatrudniając opiekunów w ośrodku. Mniej niż 1 na 10 OPS/CUS zlecał świadczenie tego rodzaju usług opiekuńczych podmiotom zewnętrznym.

Jedynie 22% OPS/CUS świadczyło specjalistyczne usługi opiekuńcze będące zadaniem własnym gminy, w tym najczęściej zatrudniając opiekunów w jednostce (ok. 2 na 3 OPS/CUS), ale również częściej niż w przypadku usług „zwykłych” zlecając je podmiotom zewnętrznym (ok. 1 na 3 OPS/CUS).

Wykres 2. Sposoby realizacji przez OPS/CUS gminnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS) = 160.

40% OPS/CUS świadczyło specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi będące zadaniem zleconym gminom z zakresu administracji rządowej. Również tego rodzaju usługi najczęściej zapewniano

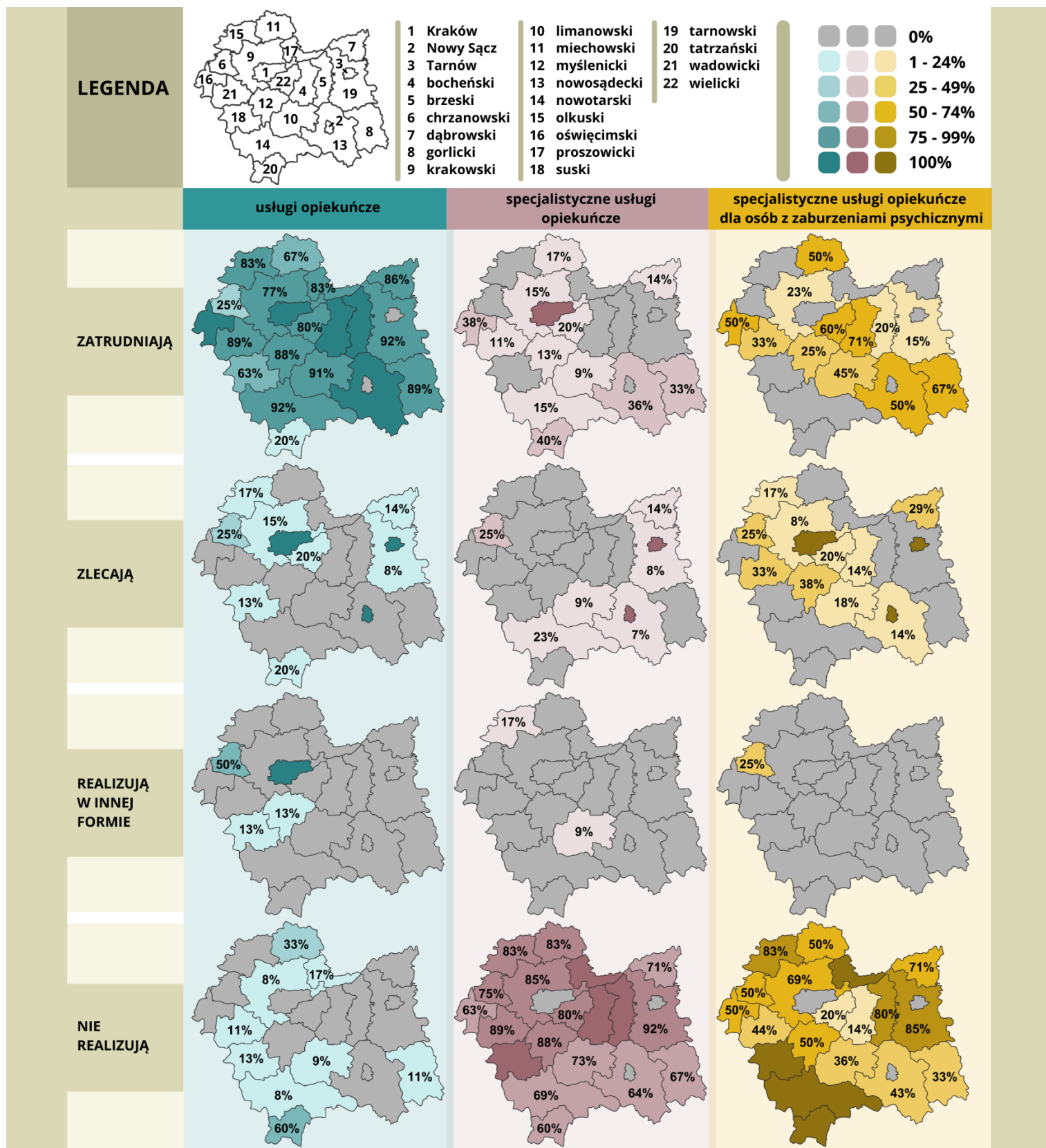
zatrudniając opiekunów w ośrodku (ok. 2 na 3 OPS/CUS), a w drugiej kolejności – zlecając to zadanie podmiotom zewnętrznym (ok. 1 na 3 OPS/CUS).

We wszystkich powiatach co najmniej jedna gmina (łącznie 133 w regionie) zatrudniała opiekunów do realizacji „zwykłych” gminnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – z wyjątkiem miast na prawach powiatu Tarnów i Nowy Sącz, którzy nie zatrudniali opiekunów, lecz w całości zlecały wykonywanie tego rodzaju usług podmiotom niepublicznym. Z kolei miasto Kraków realizowało tego rodzaju usługi opiekuńcze zarówno zatrudniając opiekunów w ośrodku pomocy społecznej, jak również zlecając to zadanie organizacjom pozarządowym. Oprócz Krakowa jedynie 4 gminy w 3 powiatach zlecały realizację gminnych usług opiekuńczych innym niż specjalistycznym podmiotom zewnętrznym. W jeszcze pięciu gminach usługi te były realizowane w jeszcze inny sposób – między innymi przez odrębną gminną jednostkę organizacyjną bądź w ramach współpracy z DPS, centrum integracji społecznej lub podmiotem ekonomii społecznej.

Znacznie częściej podmiotom zewnętrznym zlecana była realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będących zadaniem gminnym. 8 gmin w 6 powiatach, a także dwa miasta na prawach powiatu – Tarnów i Nowy Sącz – realizują tego rodzaju usługi opiekuńcze w ramach zleceń podmiotom niepublicznym. Z kolei 23 gminy w 12 powiatach oraz miasto Kraków zatrudniały opiekunów w ośrodku do realizacji tego zadania. Dwie gminy realizowały tego rodzaju usługi w jeszcze inny sposób – w ramach projektów unijnych oraz umowy o świadczenie usług.

Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 17 gmin w 10 powiatach, a także wszystkie miasta na prawach powiatu zlecały świadczenie tych usług podmiotom niepublicznym. Z kolei 44 gminy w 12 powiatach zatrudniały opiekunów w OPS/CUS do realizacji tych rodzaju usług. Jedynie jedna gmina realizowała je w inny sposób – poprzez odrębną gminną jednostkę organizacyjną.

**Infografika 1. Formy realizacji środowiskowych usług opiekuńczych
(w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przez OPS/CUS w Małopolsce**



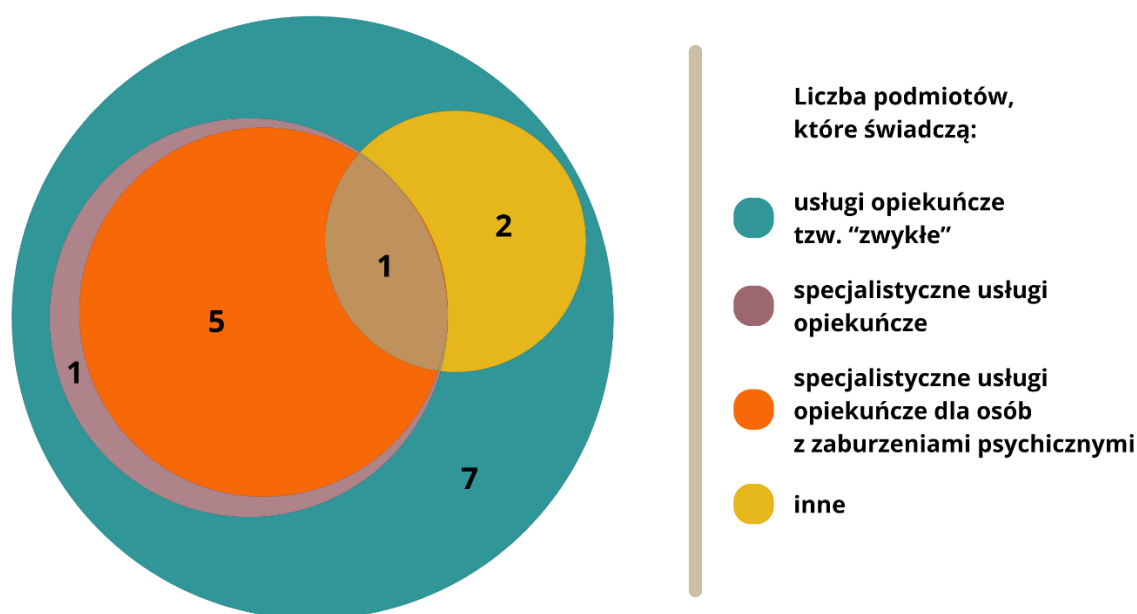
Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS) = 160.

Podmioty realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS

Wśród 16 podmiotów¹⁴ realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie małopolskich gmin, które wzięły udział w badaniu, wszystkie świadczyły „zwykłe” usługi opiekuńcze, w tym 6 podmiotów świadczyło również specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 z nich świadczyło zarówno specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wśród 16 zbadanych podmiotów 3 świadczyło również innego rodzaju usługi¹⁵ – w tym 2 podmioty świadczyły usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, 1 – opiekę wytchnieniową, a 1 – usługi pielęgnacyjne¹⁶.

Wykres 3. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz inne usługi świadczone przez podmioty działające na zlecenie OPS/CUS



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (Zleceńbiorky) = 16.

¹⁴ W tym filie podmiotu zlokalizowane w różnych miejscowościach są liczone jako osobne podmioty.

¹⁵ Usługi te mogą być świadczone na zlecenie tych samych, jak również innych gmin, a także innych podmiotów i osób fizycznych.

¹⁶ Na podstawie rodzaju usług wskazanych w odpowiedzi otwartej nie było możliwe ustalenie dokładnego zakresu i charakteru tego rodzaju usług.

Opieka stacjonarna w domach pomocy społecznej

Na dzień 18 lutego 2026 roku w województwie małopolskim funkcjonowało 90 domów pomocy społecznej. Najwięcej DPS było zlokalizowanych w Krakowie (14), a także w powiatach krakowskim (10) oraz tarnowskim (8). Najmniej domów pomocy społecznej – tylko jedna placówka – było w powiatach bocheńskim, chrzanowskim oraz olkuskim.

Mapa 1. Liczba domów pomocy społecznej w Małopolsce według powiatów



Źródło: Opracowanie – ROPS w Krakowie na podstawie Rejestru domów pomocy społecznej, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (stan na 18.02.2026).

Najwięcej domów pomocy społecznej było przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych (33) osób przewlekle psychicznie chorych (28), a w dalszej kolejności – dla osób w podeszłym wieku (23) oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (23, w tym wyłącznie dla dorosłych – 14, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci – 6, a wyłącznie dla dzieci – 3). Najmniej domów pomocy społecznej było przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną (3) oraz osób uzależnionych od alkoholu (1).

Infografika 2. Liczba DPS w Małopolsce według rodzaju grupy docelowej mieszkańców

LEGENDA



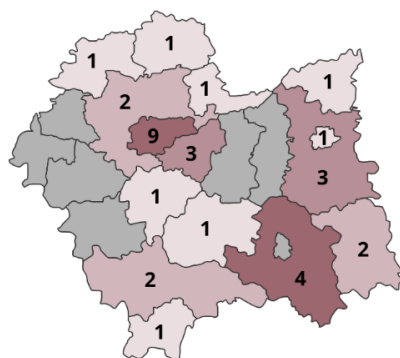
1 Kraków
2 Nowy Sącz
3 Tarnów
4 bocheński
5 brzeski
6 chrzanowski
7 dąbrowski
8 gorlicki
9 krakowski

10 limanowski
11 miechowski
12 myślenicki
13 nowosądecki
14 nowotarski
15 olkuski
16 oświęcimski
17 proszowicki
18 suski

19 tarnowski
20 tatrzański
21 wadowicki
22 wielicki

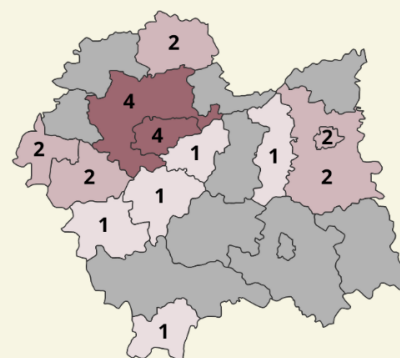
brak
1
2
3
4+

osoby przewlekle
somatycznie chore



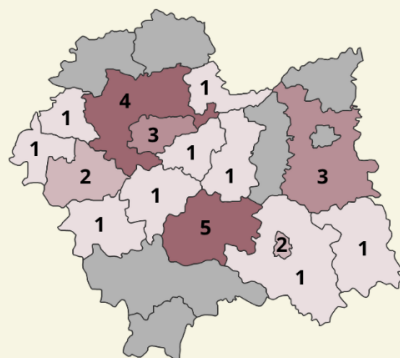
Liczba
DPS 33

osoby
niepełnosprawne
intelektualnie



Liczba
DPS 23

osoby przewlekle
psychicznie chore



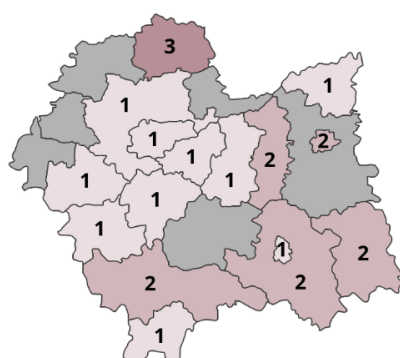
Liczba
DPS 28

osoby
niepełnosprawne
fizycznie



Liczba
DPS 3

osoby
w podeszłym wieku



Liczba
DPS 23

osoby uzależnione
od alkoholu



Liczba
DPS 1

Źródło: Opracowanie – ROPS w Krakowie na podstawie Rejestru domów pomocy społecznej, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (stan na 18.02.2026).

Biorąc pod uwagę rozmieszczenie domów pomocy społecznej na mapie Małopolski, najwięcej domów pomocy społecznej dla:

- osób przewlekle somatycznie chorych było w Krakowie (9) oraz w powiecie nowosądeckim (4)
- osób przewlekle psychicznie chorych – w powiatach limanowskim (5) i krakowskim (4)
- osób w podeszłym wieku – w powiecie miechowskim (3)
- osób z niepełnosprawnością intelektualną – w Krakowie (4) oraz powiecie krakowskim (4).

Małopolskie domy pomocy społecznej były najczęściej prowadzone przez powiaty (36 placówek, czyli 40% wszystkich DPS), podmioty niepubliczne (35 placówek, 39% wszystkich DPS - w tym 15 domów było prowadzonych przez podmioty kościelne) oraz miasta na prawach powiatu (17 placówek, 19% wszystkich DPS). Jedynie 3 domy pomocy społecznej były prowadzone inne podmioty, w tym 2 – przez gminy, a jeden – przez podmiot prywatny.

Opiekunowie formalni w Małopolsce – podstawowe dane

Liczba opiekunów formalnych, forma i wymiar zatrudnienia

Małopolskie podmioty świadczące różnego rodzaju opiekę, które wzięły udział w badaniu, zatrudniały łącznie 4 017 opiekunów, w tym DPS zatrudniały 2 297 opiekunów, OPS/CUS – 788 opiekunów, a podmioty, którym OPS/CUS zlecały realizację usług opiekuńczych – 932 opiekunów.¹⁷

W Małopolsce opieka w miejscu zamieszkania organizowana przez OPS/CUS miała inną charakterystykę niż ta świadczona w DPS pod względem sposobu organizacji pracy – w tym form zatrudnienia oraz godzinowego wymiaru pracy opiekunów. W odpowiedziach osób zarządzających OPS/CUS, które zatrudniały opiekunów, najczęstszą formą zatrudnienia była umowa zlecenia – na podstawie takiej umowy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w małopolskich gminach świadczyło 52% opiekunów zatrudnionych w tych jednostkach. Nieco rzadziej opiekunów środowiskowych w OPS/CUS zatrudniano na umowę o pracę (45%), a sporadycznie (4%) – w ramach innego rodzaju umowy. W deklaracjach podmiotów większość opiekunów wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w OPS/CUS pracowało mniej niż 40 godzin tygodniowo (57% zatrudnionych opiekunów). Ponad jedna trzecia opiekunów (37%) pracowała mniej niż 20 godzin tygodniowo, 12% – w wymiarze od 20 do 30 godzin, a 8% pracowało w innym wymiarze czasu pracy (często w zależności od zapotrzebowania). W wymiarze 40 godzin w tygodniu pracowało 43% opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS.

¹⁷ Dane pozyskane podczas pierwszego etapu badania wśród podmiotów. Rzeczywista liczba opiekunów formalnych była większa ze względu na to, że nie od wszystkich jednostek uzyskano zwrot ankiet.

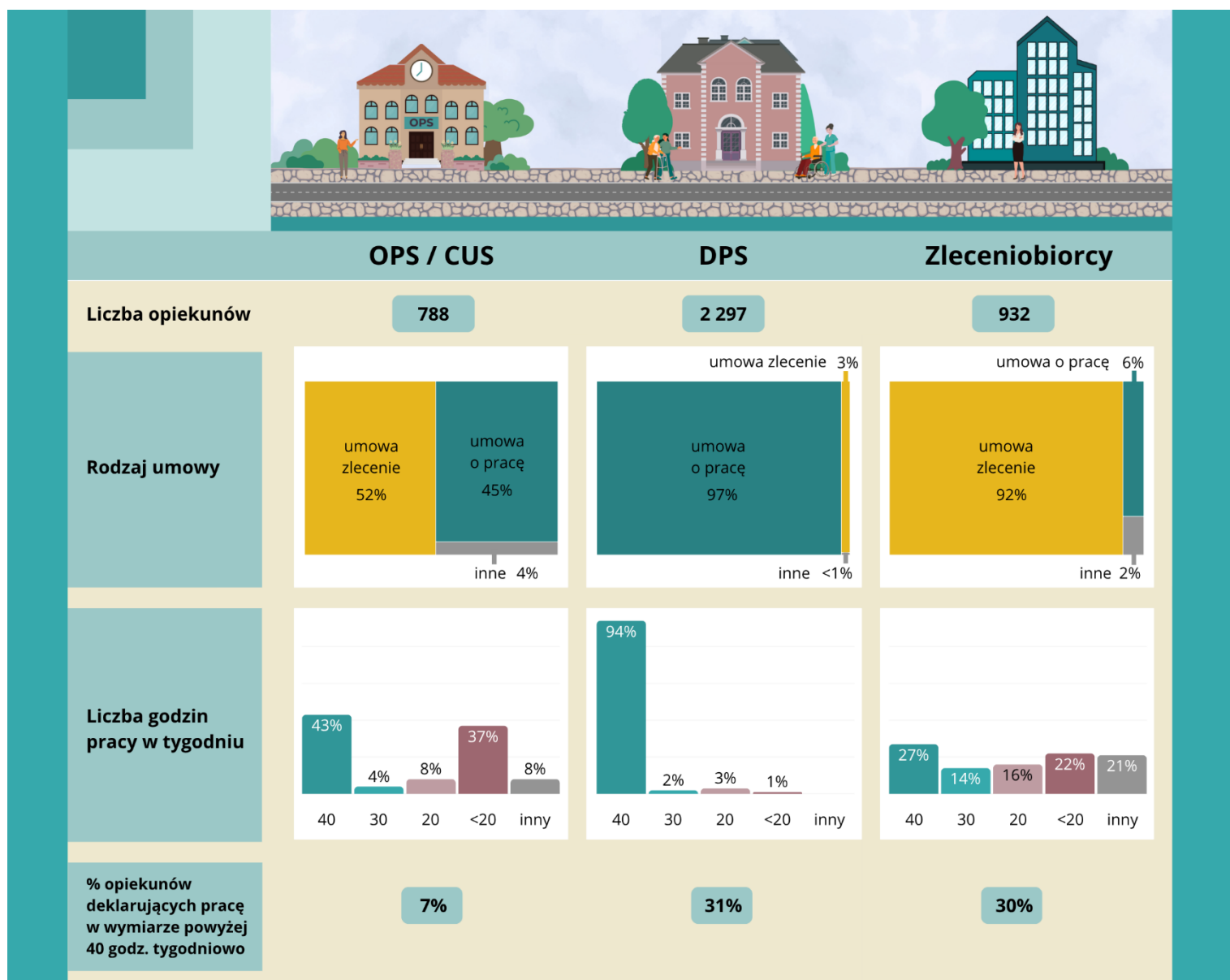
W odróżnieniu od kadry opiekuńczej w OPS/CUS, zdecydowana większość opiekunów zatrudnionych w DPS (97%) było zatrudnionych na umowę o pracę, zdecydowanie mniej na umowę zlecenie (3%), a tylko 1 opiekun był zatrudniony w ramach innego rodzaju umowy. Zdecydowana większość opiekunów w DPS pracowała w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli 40 godzin tygodniowo (94%).

W odpowiedziach 16 Zleceniobiorców biorących udział w badaniu, większość opiekunów wykonujących usługi opiekuńcze w tych podmiotach pracowała na umowę zlecenie (92%), niewielu na umowę o pracę (6%), a 15 opiekunów było zatrudnionych w ramach innego rodzaju umowy. Co czwarty opiekun zatrudniany w tych podmiotach pracował w wymiarze 40 godzin tygodniowo, a co piąty (22%) – w wymiarze mniejszym niż 20 godzin tygodniowo lub w innym wymiarze godzin. 16% opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców pracowało 20 godzin, a 14% – 30 godzin w ciągu tygodnia.

Pytanie dotyczące wymiaru pracy zadano również opiekunom zatrudnionym w badanych jednostkach. W odpowiedziach opiekunów (dotyczących liczby godzin pracy we wszystkich miejscach zatrudnienia) 7% opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, 31% opiekunów zatrudnionych w DPS oraz 30% opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców pracowało ponad 40 godzin w tygodniu. Dane te sugerują, że kadra opiekuńcza w Małopolsce zatrudniona w DPS i przez Zleceniobiorców często wypracowuje nadgodziny w ramach umowy, bądź też wykonuje pracę w ramach dodatkowych form zatrudnienia, pracując łącznie powyżej 40 godzin tygodniowo.

Przeważająca większość DPS w Małopolsce (85%) stosowała dwuzmianowy tryb pracy opiekunów, w tym najczęściej pierwsza zmiana obejmowała godziny od 7 do 19, a druga – od 19 do 7. Wśród pozostałych DPS po 6% stosowało tryb pracy 3-zmianowy oraz mieszany, w pojedynczych jednostkach opiekunowie pracowali w trybie równoważnym lub jednozmianowym.

Infografika 3. Rodzaj umowy oraz wymiar czasu pracy opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS (% opiekunów)



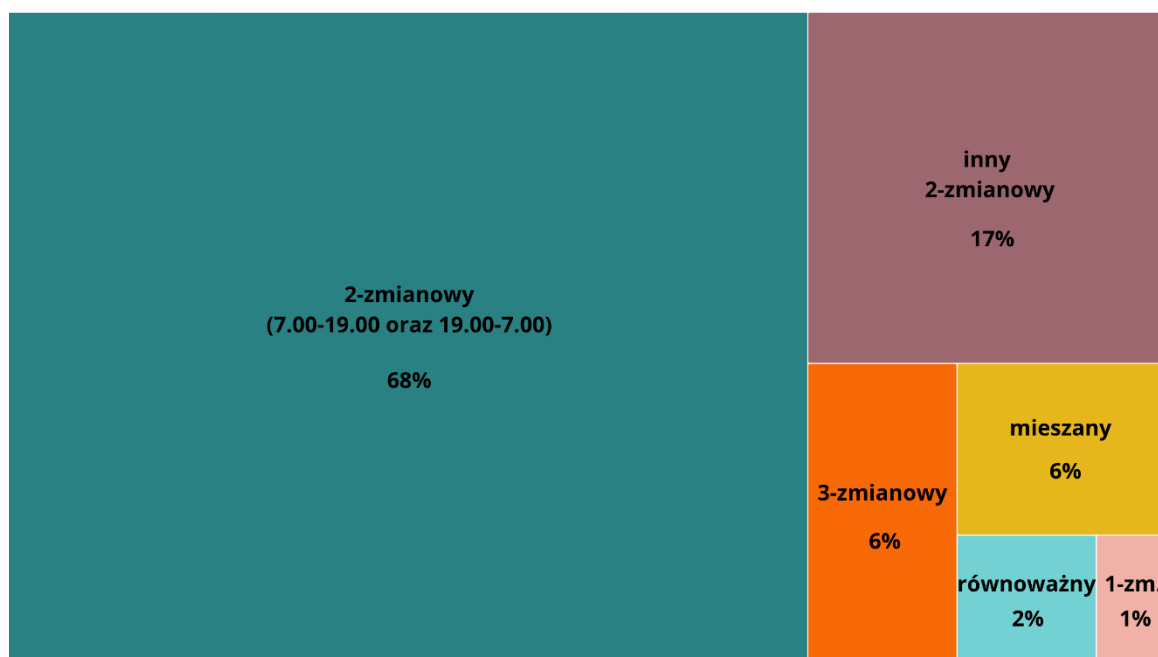
Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zleceniobiorcy) = 16; Dane dot. odsetka opiekunów deklarujących pracę w wymiarze powyżej 40 godz. tygodniowo: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

Od 41% DPS stosujących dwuzmianowy tryb pracy pozyskano odpowiedzi dotyczące przeciętnej liczby opiekunów na jednej zmianie. W przeważającej większości z nich na zmianie dziennej (czyli od 6-7 rano do 18-19 wieczorem) pracowało około dwa razy więcej opiekunów (średnio 7, od 2 do 40 osób),

aniżeli podczas zmiany nocnej (średnio 3, od 1 do 10 osób), co jest związane z wykonywaniem większości codziennych zabiegów opiekuńczo-pielęgnacyjnych w ciągu dnia.

Przeliczając liczbę mieszkańców przypadających na jednego opiekuna (szacowaną na podstawie liczby miejsc w DPS) w większości przypadków na zmianie dziennej na jednego opiekuna przypadało od 6 do 15 mieszkańców (średnio 13), a na zmianie nocnej – od 15 do 45 mieszkańców (średnio 28).

Wykres 4. Tryb pracy opiekunów zatrudnionych w DPS



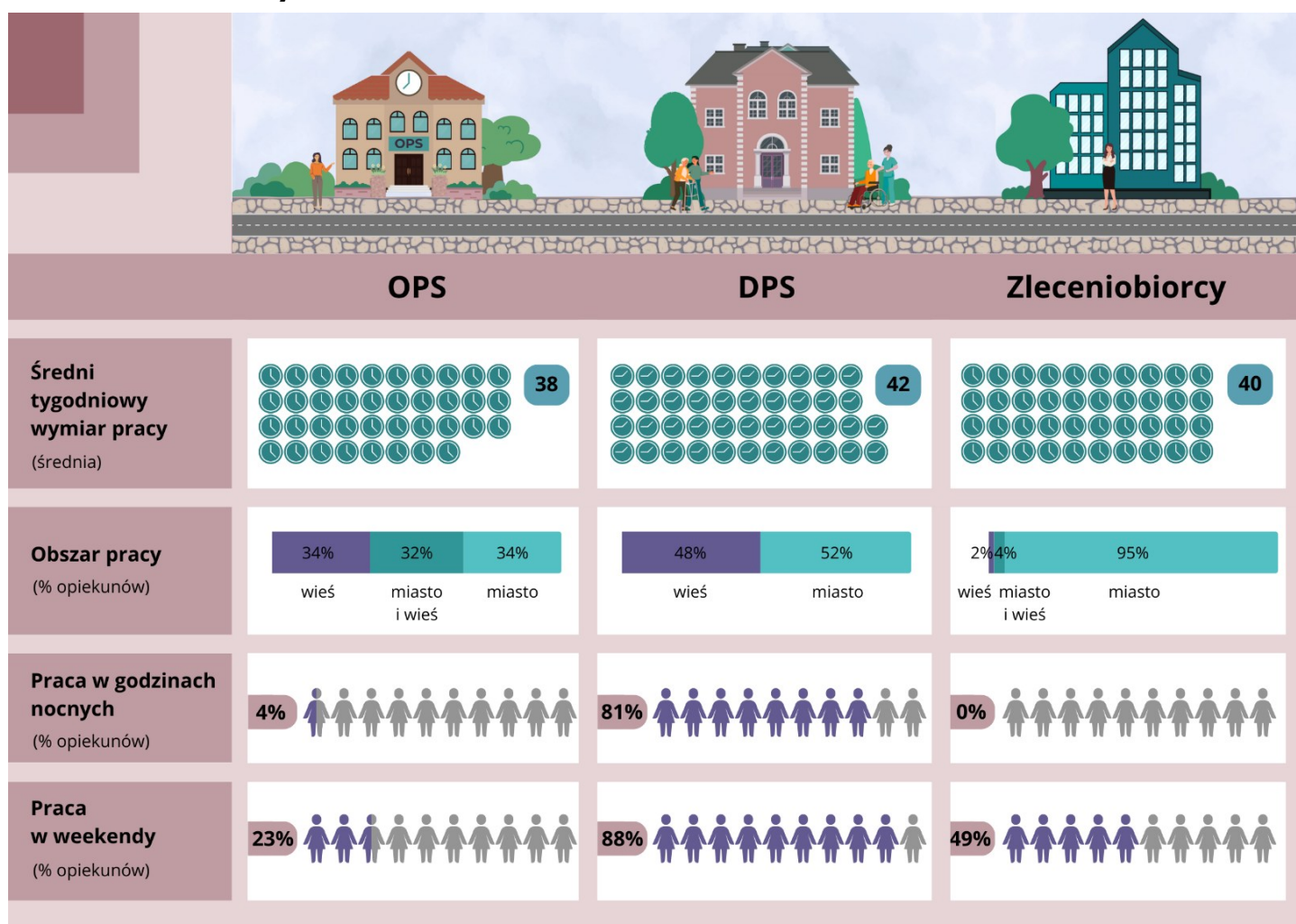
Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (DPS) = 84.

W Małopolsce średni tygodniowy wymiar pracy był zbliżony we wszystkich rodzajach zatrudnienia i wynosił odpowiednio 38 godzin wśród opiekunów w OPS/CUS, 42 godziny wśród opiekunów pracujących w DPS oraz 40 godzin wśród opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców.

Różnice widoczne były natomiast w zakresie wykonywania pracy na obszarze miasta lub wsi. Wśród opiekunów realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania zatrudnionych w OPS/CUS 34% opiekunów pracowało na wsi, 34% w mieście, a 32% zarówno w mieście, jak i na wsi. W przypadku opiekunów

pracujących w DPS nieco więcej opiekunów pracowało w podmiotach położonych w miastach (52%) niż tych zlokalizowanych na wsi (48%). Z kolei wśród opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców OPS/CUS, zdecydowana większość wykonywała pracę w miastach (95%), a jedynie niewielki odsetek na wsi (2%) lub zarówno w mieście, jak i na wsi (4%).

Infografika 4. Cechy pracy opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS – tygodniowy wymiar, obszar pracy, praca w nocy i w weekendy¹⁸



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

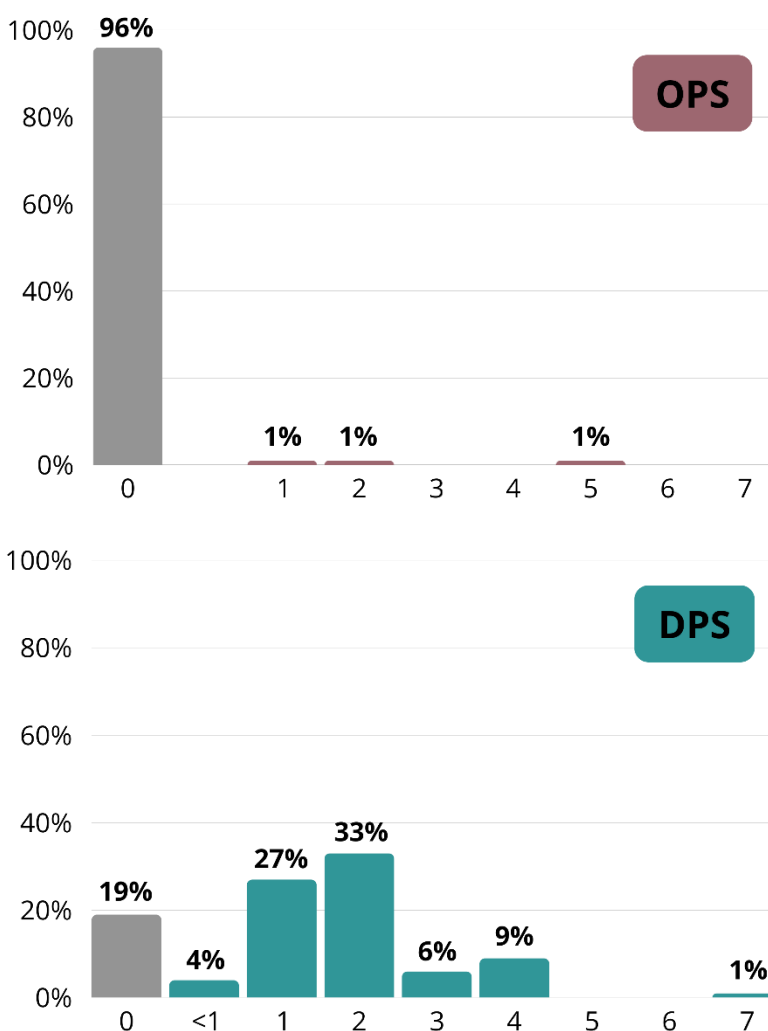
¹⁸ Odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w godzinach nocnych oraz w weekendy mogły dotyczyć również prac wykonywanych poza zatrudnieniem w podmiotach, które były przedmiotem zainteresowania w tym badaniu, jak również tych świadczonych bezpośrednio na rzecz rodzin oraz osób potrzebujących wsparcia.

Znaczne różnice dotyczyły także pracy w godzinach nocnych oraz w weekendy. Praca nocna była powszechna wśród opiekunów pracujących w DPS (81%), natomiast wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS lub podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS praca w godzinach nocnych była wykonywana bardzo sporadycznie (4%).

Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku pracy w weekendy – wykonywało ją 88% opiekunów zatrudnionych w DPS, 49% opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców oraz 23% opiekunów w OPS/CUS. Oznacza to, że dostęp do usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania mieszkańcy mieli raczej w tygodniu, a w weekendy dostęp do nich był ograniczony – szczególnie, że praca

w weekendy deklarowana przez opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w części przypadków jest wykonywana w ramach dodatkowego zatrudnienia lub nieformalnie.

Wykres 5. Liczba dni pracy w godzinach nocnych w tygodniu wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS i DPS



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS) = 83, N (DPS) = 119.

Większość opiekunów w województwie małopolskim zatrudnionych w OPS/CUS (96%), nie pracowało w godzinach nocnych. Jedynie pojedynczy opiekunowie wykonywali pracę w godzinach nocnych (3%), przy czym warto zaznaczyć, że w części przypadków jest to związane ze świadczeniem nieformalnej opieki poza pracą w OPS/CUS.

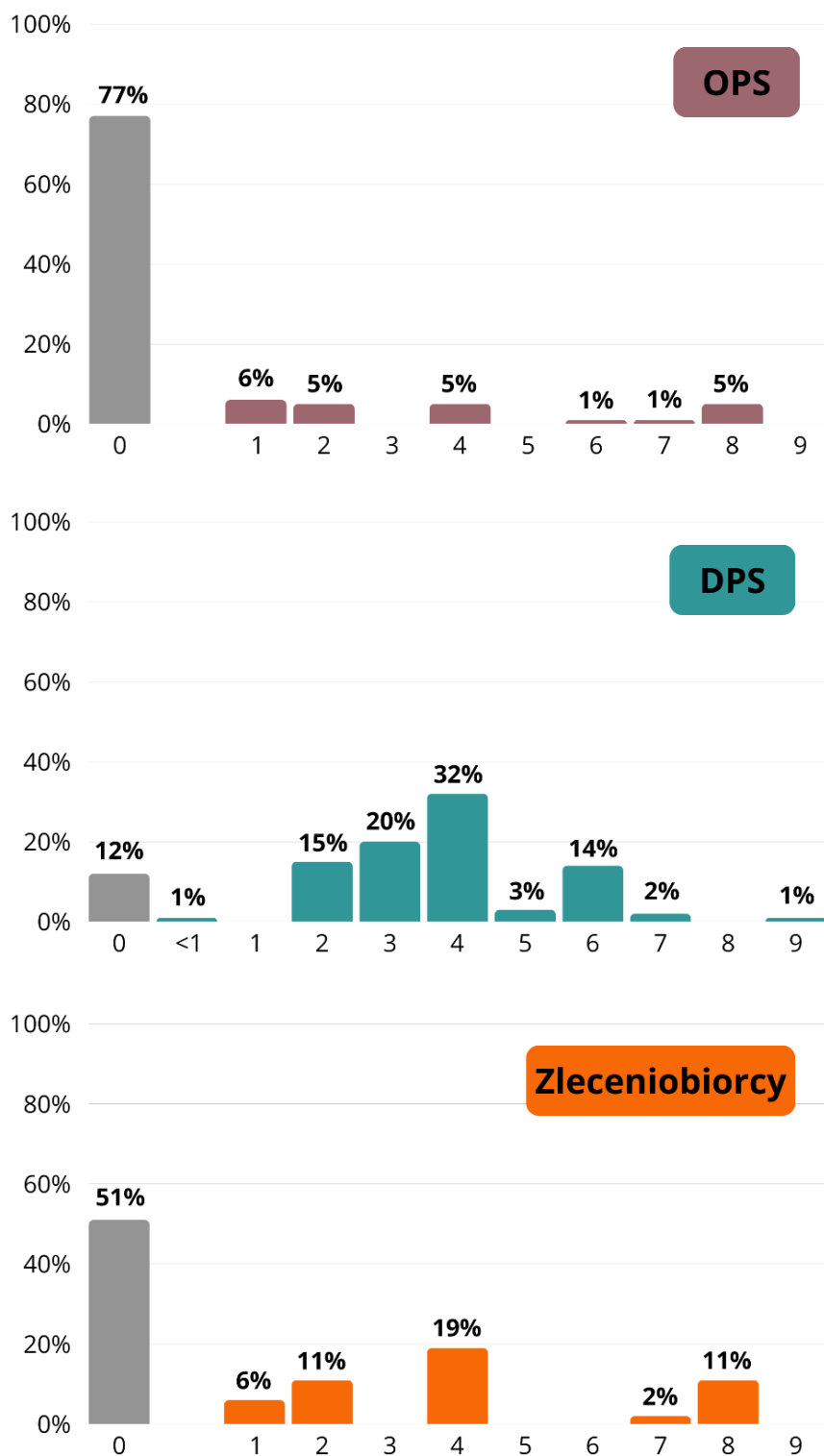
Wśród opiekunów zatrudnionych w DPS najwięcej (33%) pracowało w godzinach nocnych dwa razy w tygodniu, 27% raz w tygodniu, a 15% – od 3 lub 4 razy w tygodniu. Bardzo rzadko opiekunowie w DPS (1%) pracowali w godzinach nocnych siedem dni w tygodniu¹⁹. Jednocześnie co piąty opiekun z DPS (19%) nie pracował w godzinach nocnych, a 4% wykonywało taką pracę sporadycznie, na przykład raz na dwa tygodnie.

W Małopolsce większość opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS (77%), nie pracowało w weekendy. Co dziesiąty opiekun wykonywał pracę w sobotę lub niedzielę 1–2 razy w miesiącu, a co dwudziesty – cztery razy w miesiącu. 7% badanych opiekunów w OPS/CUS pracowało w większość sobót i niedziel w miesiącu. Podobnie jak w przypadku pracy w godzinach nocnych, w części przypadków praca w weekendy była związana z dodatkowym zatrudnieniem – na przykład w ramach projektu „Małopolski Tele-Anioł”, bądź pracą nieformalną.

Ponad połowa opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców (51%), nie pracowała w weekendy. Co piąty badany opiekun (19%) zatrudniony w tych podmiotach wykonywał pracę w sobotę lub niedzielę cztery razy w miesiącu, a 17% 1–2 razy w miesiącu. Natomiast 13% pracowało w większość sobót i niedziel w miesiącu.

¹⁹ Warto zauważyć, że choć stała praca przez 7 dni w tygodniu w godzinach nocnych nie jest dopuszczana w polskim systemie prawnym, opiekunowie odpowiadali na pytanie w odniesieniu do wszystkich miejsc pracy w ramach umów u różnych pracodawców, w tym potencjalnie również pracy wykonywanej nieformalnie.

Wykres 6. Liczba dni pracy w weekendy w miesiącu wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

Z kolei aż 7 na 8 opiekunów pracujących w DPS (88%) pracowało w weekendy. Najwięcej (32%) opiekunów w DPS pracowało przez cztery dni weekendowe w miesiącu, 20% – przez trzy dni, a 15% – przez dwa dni w miesiącu. Natomiast co piąty opiekun w DPS (20%) pracował w większość sobót i niedziel w miesiącu. Jedynie niewielki odsetek opiekunów w DPS pracował w weekendy sporadycznie (1%), na przykład jeden raz w ciągu dwóch miesięcy.

Opis społeczno-demograficzny opiekunów formalnych

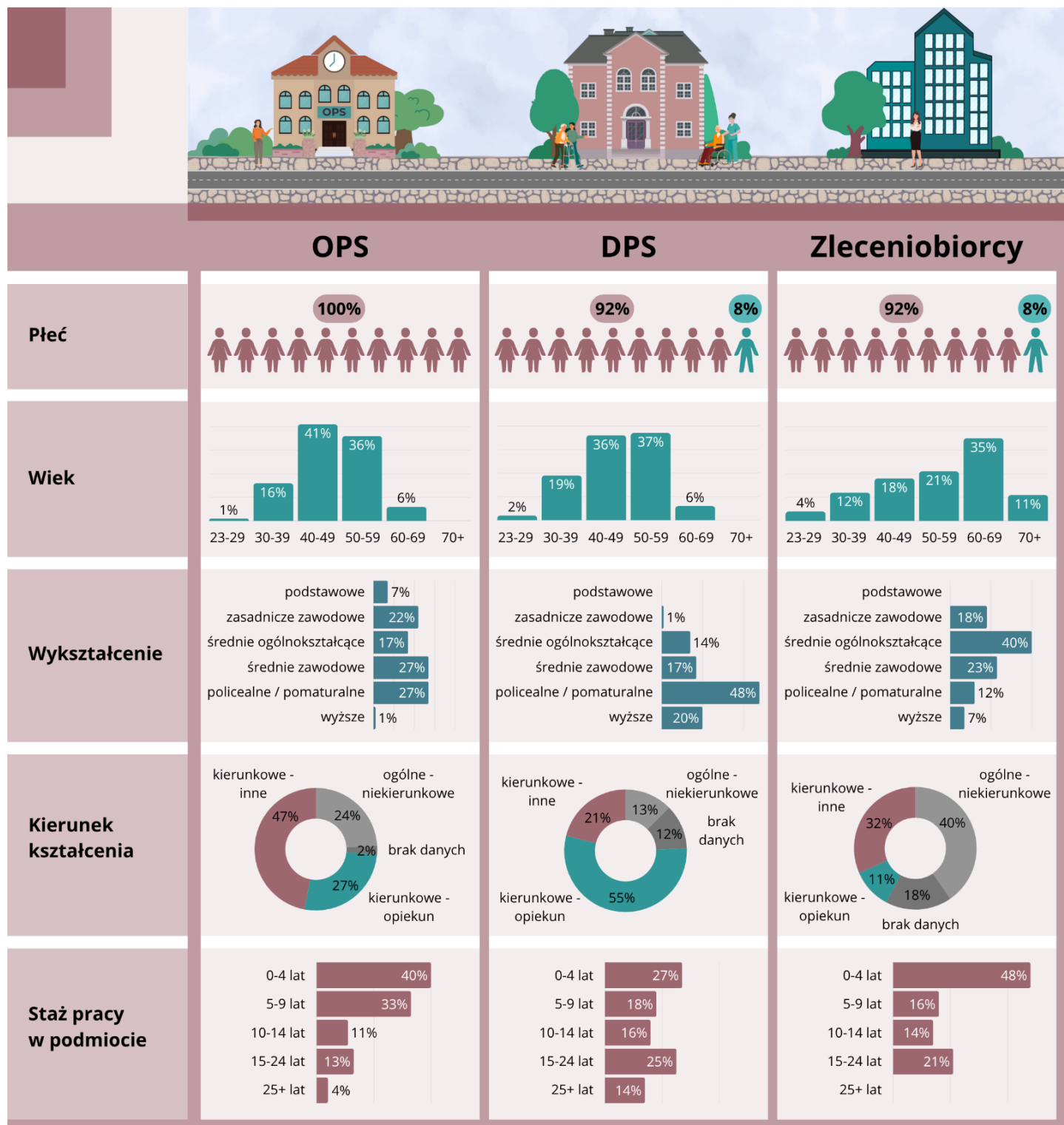
W Małopolsce w sektorze usług opiekuńczych pracowały najczęściej kobiety w wieku 40 lat i więcej – stanowiły one aż 81% opiekunów świadczących opiekę w miejscu zamieszkania oraz opiekę w DPS w regionie. W wieku co najmniej 50 lat była niemal połowa (48%) opiekunów zatrudnionych w badanych jednostkach, co wskazuje na perspektywę potencjalnej dezaktywacji zawodowej znacznej części zasobów kadr opiekuńczych w regionie.

Większość opiekunów w Małopolsce posiadało wykształcenie policealne lub pomaturalne (36%), średnie zawodowe (22%), czy też średnie (19%). Wśród wszystkich opiekunów 37% posiadało wykształcenie związane ze świadczeniem opieki osobom niesamodzielnym. Średnia liczba lat stażu w podmiocie wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców wyniosła 10 lat, a mediana – 8 (co oznacza, że połowa opiekunów miała staż pracy w jednostce wynoszący do 8 lat, a połowa – staż przekraczający tę granicę).

Charakterystyka społeczno-demograficzna badanych opiekunów w województwie małopolskim różniła się w zależności od miejsca zatrudnienia. We wszystkich analizowanych grupach zdecydowaną większość stanowiły kobiety. W OPS/CUS wszystkie badane osoby były kobietami (100%), a wśród opiekunów w DPS i zatrudnionych przez Zleceniobiorców, kobiety stanowiły 92%, a mężczyźni 8%.

Wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS dominowały osoby w wieku 40-49 lat (41%) oraz 50-59 lat (36%). Wśród opiekunów w DPS z kolei najwięcej było osób w wieku 50-59 lat (37%), a następnie 40-49 lat (36%). Natomiast najstarsi przeciętnie byli opiekunowie zatrudnieni przez Zleceniobiorców – wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 60-69 lat (35%), a następnie osoby w wieku 50-59 lat (21%), 40-49 lat (18%) oraz 70+ (11%).

Infografika 5. Charakterystyka społeczno-demograficzna opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach, którym OPS/CUS zlecają wykonywanie środowiskowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceńbiorycy) = 60.

Kadra opiekuńcza DPS, w porównaniu do opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS oraz przez Zleceniobiorców charakteryzowała się wyższym poziomem wykształcenia, a także znacznie częściej miała wykształcenie kierunkowo zbieżne z opieką. Opiekunowie w DPS najczęściej mieli wykształcenie policealne lub pomaturalne (48%) oraz wyższe (20%). Z kolei wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS dominowały osoby z wykształceniem średnim zawodowym oraz policealnym lub pomaturalnym (po 27%). Z kolei opiekunowie zatrudnieni przez Zleceniobiorców najczęściej posiadali wykształcenie średnie ogólnokształcące (40%) oraz średnie zawodowe (23%).

W odniesieniu do kierunku posiadanego wykształcenia, wśród opiekunów pracujących w DPS 55% posiadało wykształcenie kierunkowe związane z zawodem opiekuna, w OPS/CUS – 27%, a wśród opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców OPS/CUS dominowały inne kierunki kształcenia – jedynie 11% posiadało wykształcenie w zawodzie opiekuna, przy czym należy zwrócić uwagę na duży udział osób, które nie udzieliły informacji o swoim kierunku wykształcenia w tej grupie opiekunów (18%).

W Małopolsce opiekunowie posiadający wykształcenie kierunkowe w zawodzie niezwiązanym z opieką najczęściej (80%) posiadali wykształcenie techniczne związane z produkcją lub usługami innymi niż społeczne (np. technik ekonomista, rolnik, sprzedawca, kucharz, fryzjer, handlowiec). Jedynie 2 na 10 osób z wykształceniem kierunkowym innym niż związane z opieką posiadało wykształcenie na kierunku społecznym (pedagogika, socjologia, resocjalizacja, socjoterapia, zarządzanie, praca socjalna itd.), a tylko jedna na 10 – wykształcenie w zawodzie medycznym (pielęgniarstwo, ratownictwo, fizjoterapia). Warto zaznaczyć, że opiekunowie z wykształceniem kierunkowym innym niż opiekun zatrudnieni w DPS najczęściej posiadali wykształcenie na kierunku społecznym, a opiekunowie zatrudnieni w OPS/CUS lub przez Zleceniobiorców – wykształcenie techniczne lub związane z usługami innymi niż społeczne.

Analiza stażu pracy w podmiocie wskazuje, że wśród opiekunów realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zarówno tych zatrudnionych w OPS/CUS, jak i przez Zleceniobiorców, najczęściej były osoby z krótszym stażem pracy w danym podmiocie, wynoszącym do 4 lat (odpowiednio 40% i 48%). Wśród opiekunów zatrudnionych w DPS staż pracy w podmiocie był bardziej zróżnicowany. Choć największy odsetek stanowiły osoby, które pracowały w jednostce do czterech lat (27% opiekunów), to znaczna część opiekunów miała długi staż pracy – aż 25% było zatrudnionych w jednostce od 15 do 24 lat, a 14% powyżej 25 lat.

Jak zatem widzimy, kadra opiekuńcza DPS, w porównaniu do opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS oraz przez Zleceniobiorców, charakteryzowała się dłuższym stażem pracy oraz przeciętnie wyższym poziomem wykształcenia, w tym znacznie częściej miała wykształcenie związane z opieką. Biorąc pod uwagę również, że opiekunowie w DPS stawowią większość kadry opiekuńczej w województwie, znacznie częściej mają stabilne zatrudnienie na umowę o pracę oraz częściej wykonują pracę w pełnym wymiarze godzin – w tym w godzinach nocnych oraz w weekendy – można powiedzieć, że to właśnie kadra DPS jest kluczowym zasobem opiekuńczym w regionie.

Cudzoziemcy wśród opiekunów

Zatrudnianie cudzoziemców było dość rzadko spotykane wśród małopolskich podmiotów realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz opiekę w DPS – opiekunów pochodzenia innego niż polskie zatrudniały jedynie 4 na 139 OPS/CUS zatrudniających opiekunów (niecałe 3%), 27 na 84 DPS (32%) oraz 7 na 13 Zleceniobiorców²⁰. Liczba cudzoziemskich opiekunów w systemie

²⁰ W przypadku jednego podmiotu posiadającego dwie filie pozyskano takie informacje dla wszystkich filii łącznie, w związku z czym ogólna liczba podmiotów będących Zleceniobiorcami w tym przypadku wynosi 13.

ogółem wyniosła 141 osób, co stanowi jedynie 3,5% wszystkich opiekunów zatrudnianych przez badane jednostki.

Najwięcej opiekunów pochodzenia innego niż polskie było zatrudnionych w DPS – 92 osoby, 41 osób zatrudniali Zleceniobiorcy, z kolei w badanych OPS/CUS do wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zatrudniano jedynie 8 cudzoziemców.

Przeważająca część podmiotów zatrudniających cudzoziemców do świadczenia opieki, od których pozyskano informacje o ich narodowości – 27 podmiotów na 33, czyli 82% wskazało, iż zatrudnia wyłącznie osoby z Ukrainy (64 opiekunów). Co ósmy podmiot (4 na 33) zatrudniał zarówno osoby z Ukrainy (21 opiekunów), jak i z Białorusi (4 opiekunów), a jedynie 2 podmioty nie zatrudniały w ogóle opiekunów pochodzenia ukraińskiego – w jednym z nich na stanowisku opiekuna pracowała osoba pochodzenia białoruskiego, a w drugim – rosyjskiego.

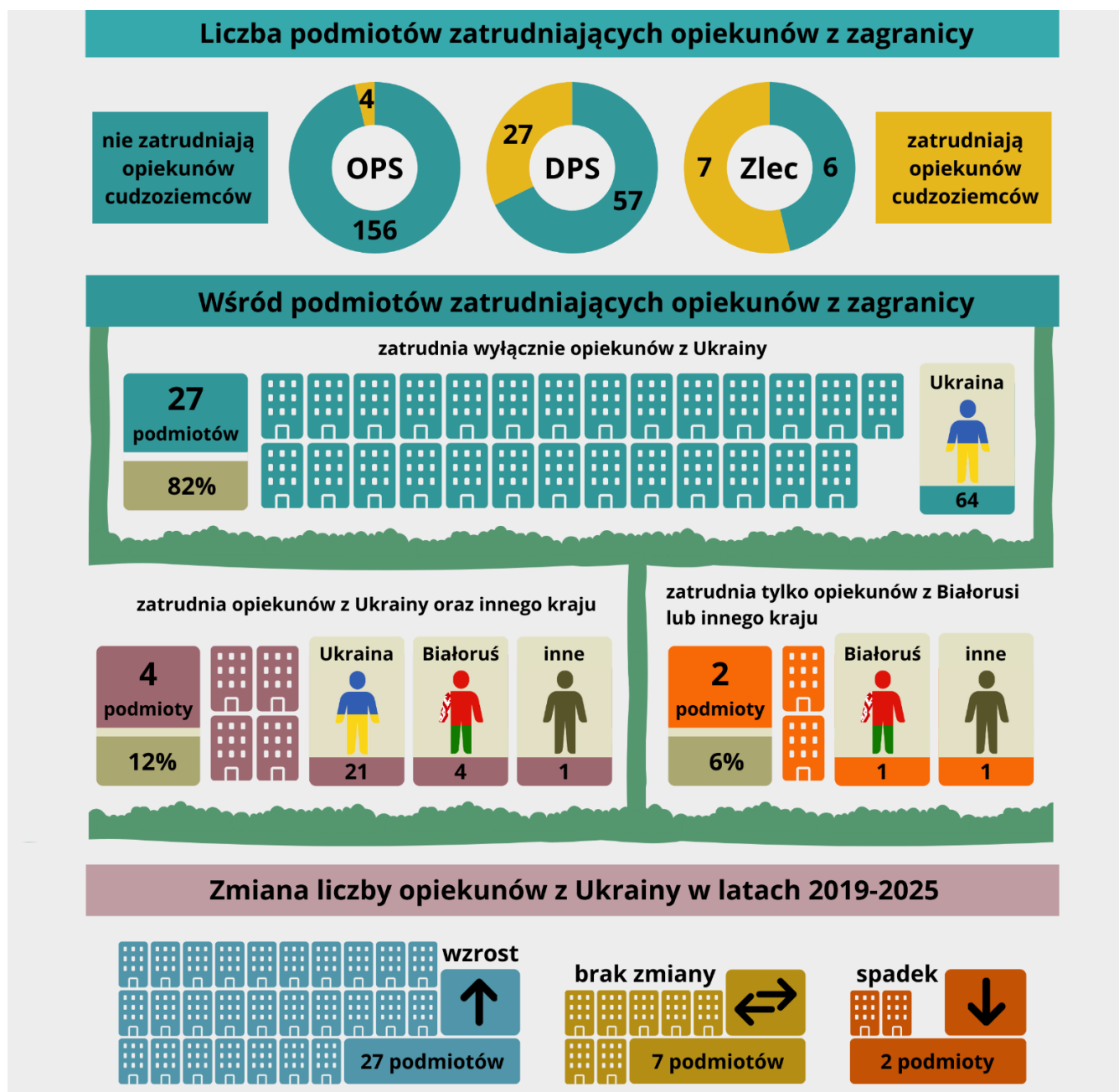
Narodowość opiekunów formalnych pochodzenia innego niż polskie została wskazana w przypadku 93 osób (66% opiekunów pochodzenia innego niż polskie). W odniesieniu 48 osób (34% cudzoziemców wykonujących zawód opiekuna) narodowość nie została zaś wskazana przez badane podmioty, w tym 5 podmiotów nie określiło narodowości żadnego z zatrudnianych opiekunów pochodzenia niepolskiego, a jeden podmiot nie określił narodowości jednego z 13 zatrudnianych opiekunów.

W 27 podmiotach zatrudniających opiekunów pochodzenia innego niż polskie w latach 2019-2025 wzrosła liczba opiekunów z Ukrainy. W 7 podmiotach liczba opiekunów pochodzenia ukraińskiego pozostała taka sama, a spadła jedynie w 2 podmiotach.

Dane te wskazują na coraz częstsze zatrudnianie opiekunów pochodzenia innego niż polskie – a w szczególności osób z Ukrainy – do prac opiekuńczych w województwie małopolskim, choć trzeba zaznaczyć, że skala tego zjawiska jest

nadal niewielka. Biorąc pod uwagę odpowiedzi podmiotów, które udzieliły informacji o narodowości opiekunów formalnych pochodzenia innego niż polskie, liczba opiekunów z Ukrainy zatrudnionych w od 2019 roku we wszystkich badanych jednostkach wzrosła niemal czterokrotnie (z 23 do 87), w tym w DPS – z 7 do 48 osób, wśród Zleceniobiorców – z 15 do 37, a w OPS/CUS – z 1 do 2.

Infografika 6. Podmioty zatrudniające opiekunów pochodzenia innego niż polskie oraz liczba opiekunów według narodowości (liczba podmiotów)



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zleceniobiorcy) = 16.

Opiekunowie formalni o swojej pracy

Zadowolenie z pracy i jego wymiary

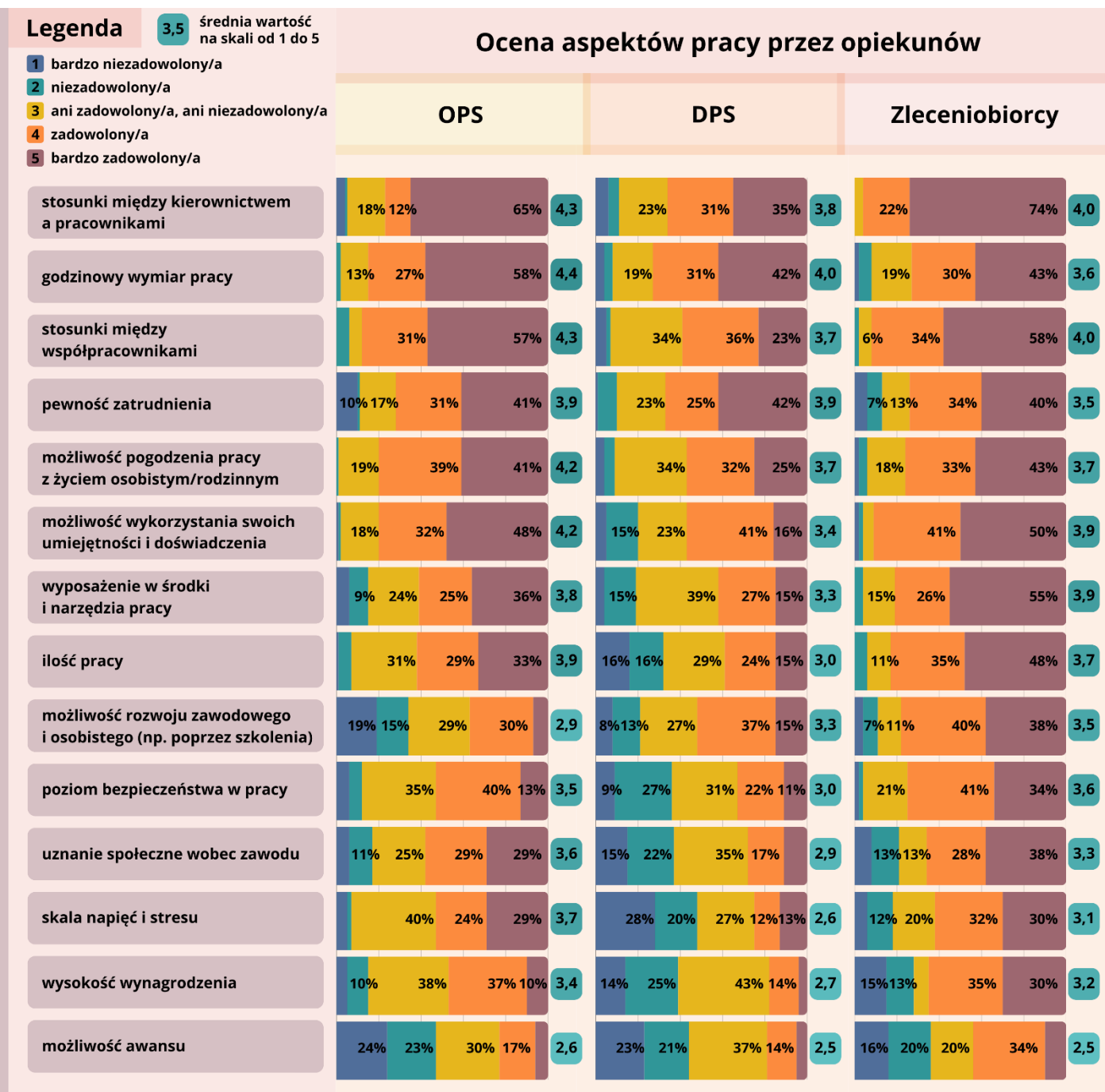
Pytanie dotyczące oceny poszczególnych aspektów pracy w zawodzie opiekuna zadano osobom zatrudnionym na stanowisku opiekuna w małopolskich DPS, OPS/CUS oraz przez Zleceniobiorców.

Oceny aspektów pracy wśród opiekunów różniły się w zależności od formy zatrudnienia, choć w większości obszarów dominowały odpowiedzi pozytywne (zadowolenie lub duże zadowolenie).

Najwyżej oceniane były relacje interpersonalne. Stosunki z przełożonymi i współpracownikami należały do najmocniejszych aspektów pracy zarówno wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS (średnia ocena ok. 4,3 na 5) lub przez Zleceniobiorców OPS/CUS (średnia ocena ok. 4,0 na 5), jak też wśród opiekunów pracujących w DPS (średnia ocena ok. 3,8 na 5).

Równie dobrze oceniane były warunki organizacyjne, takie jak godzinowy wymiar pracy oraz możliwość pogodzenia pracy z życiem prywatnym, w tym szczególnie przez opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS (średnia powyżej 4,0 na 5), co może w dużej części przypadków być związane z zatrudnieniem w niepełnym wymiarze godzin (poniżej 40 godzin w tygodniu).

Infografika 7. Ocena różnych aspektów pracy przez opiekunów zatrudnionych w małopolskich OPS/CUS, DPS oraz podmiotach, którym OPS/CUS zlecają wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceńbiorky) = 60.

Największe różnice między grupami widoczne były w zakresie:

- **możliwości wykorzystania kompetencji** - bardzo wysokie oceny wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS (4,2) oraz u Zleceniobiorców (3,9), niższe wśród opiekunów zatrudnionych w DPS (3,4).
Wynik ten jest o tyle interesujący, że kadra DPS pozytywnie wyróżnia się na tle kadr opiekuńczych pracujących w regionie w ramach systemu pomocy społecznej. Ponad połowa opiekunów pracujących w DPS miała wykształcenie o profilu opiekuńczym (55% w stosunku do 27% kadry angażowanej przez OPS/CUS i tylko 11% pracowników Zleceniobiorców). Pracownicy ci mieli także wyższy poziom wykształcenia, bo aż 68% posiadało wykształcenie pomaturalne lub wyższe, w sytuacji, gdy wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS odsetek ten wyniósł 28%. Cechował ją wyższy poziom kwalifikacji formalnych oraz dłuższy staż pracy w obszarze opieki, co wiąże się z większym doświadczeniem, a także dłuższy staż w podmiocie – ponad połowa opiekunów zatrudnionych w DPS (55%) pracowała minimum 10 lat, podczas gdy wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS było to 28%, a u Zleceniobiorców 35%.
Może to wskazywać na zjawisko niedopasowania między poziomem kompetencji a możliwościami ich wykorzystania w środowisku pracy. Osoby o wyższych kwalifikacjach mogą bowiem bardziej krytycznie oceniać warunki pracy, zwłaszcza gdy nie pozwalają one na pełne wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności.
- **wyposażenia w środki i narzędzia pracy** - najslabiej oceniane przez opiekunów zatrudnionych w DPS (ok. 3,3), lepiej wśród opiekunów realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zatrudnionych w OPS/CUS (3,8) oraz przez Zleceniobiorców OPS/CUS (3,9). Jednocześnie to właśnie DPS dysponują zazwyczaj bardziej rozbudowanym wyposażeniem w porównaniu do kadr pracujących w środowisku. Może to

wskazywać, że ocena wyposażenia nie była oparta wyłącznie na jego dostępności, lecz również wynikała z dopasowania do rzeczywistych potrzeb pracy oraz intensywności jego wykorzystania. W warunkach opieki stacjonarnej, przy większym obciążeniu pracą i bardziej złożonych potrzebach podopiecznych, dostępne zasoby – mimo, że są bardziej rozbudowane niż w przypadku opieki świadczonej w miejscu zamieszkania – mogą być postrzegane jako niewystarczające.

- **ilości pracy** (najmniej zadowoleni z ilości pracy byli opiekunowie pracujący w DPS – 3,0). Wynik ten znajduje uzasadnienie w specyfice pracy w DPS, która wiąże się z większym obciążeniem obowiązkami oraz koniecznością świadczenia pracy w trybie zmianowym, obejmującym również godziny nocne oraz dni wolne od pracy, w tym weekendy.

Najniżej oceniane aspekty dotyczyły szeroko rozumianych możliwości rozwoju i gratyfikacji, w tym:

- **możliwości awansu** (2,5-2,6),
- **wynagrodzenia** (najniżej wśród opiekunów zatrudnionych w DPS – średnia ocena wyniosła 2,7 na 5). Kadra DPS charakteryzuje się najwyższym poziomem wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, a jednocześnie wykonuje pracę o wysokim stopniu obciążenia, związaną z opieką stacjonarną. W takiej sytuacji wyższe kwalifikacje oraz intensywność pracy mogą w naturalny sposób przekładać się na większe oczekiwania płacowe.

Wyniki wskazują, że relatywnie wyższy poziom stresu odczuwali opiekunowie pracujący w DPS (2,6). W tej grupie również nisko oceniane było uznanie społeczne wobec zawodu (2,9).

Niskie oceny wynagrodzenia, możliwości awansu i uznania społecznego były spójne we wszystkich badanych grupach opiekunów – choć to szczególnie opiekunowie z DPS najrzadziej czuli się traktowani z uznaniem przez środowisko

społeczne – co sugeruje, że są to wyzwania systemowe, a nie specyficzne dla jednego typu instytucji.

Oceny pracy opiekunów formalnych w województwie małopolskim były zatem najwyższe w obszarze relacji i organizacji pracy, a najniższe w zakresie wynagrodzenia i możliwości rozwoju. Najtrudniejsze warunki pracy deklarowali opiekunowie w DPS, szczególnie w kontekście obciążenia i stresu. Z kolei opiekunowie wykonujący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zatrudnieni przez Zleceniobiorców, mimo relatywnie dobrych ocen relacji i możliwości wykorzystania kompetencji, niżej oceniali pewność zatrudnienia oraz część warunków pracy.

Środowisko pracy

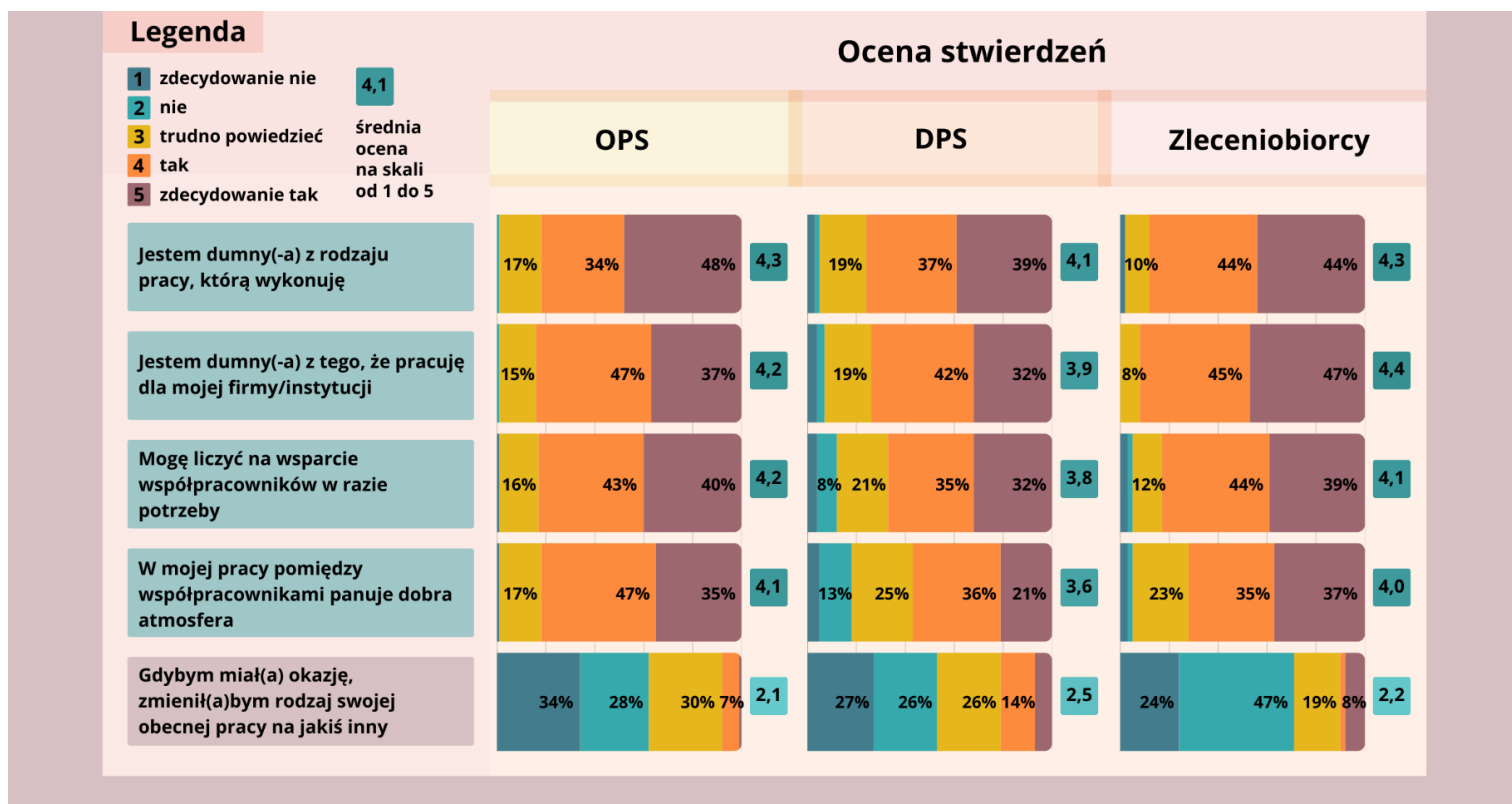
We wszystkich grupach badanych w województwie małopolskim dominował pozytywny stosunek do wykonywanej pracy oraz relatywnie wysokie poczucie dumy związanej z wykonywanym zawodem. Najwyżej oceniane były stwierdzenia dotyczące dumy z wykonywanej pracy, we wszystkich rodzajach podmiotów średnia ocena opiekunów formalnych wyniosła powyżej 4,0 na 5.

Wysoko oceniane było także wsparcie współpracowników oraz atmosfera w pracy. Najlepiej oceniali je opiekunowie zatrudnieni w OPS/CUS (średnia ocena na poziomie 4,1-4,2), nieco słabiej opiekunowie zatrudnieni u Zleceniobiorców (średnia ocen na skali od 1 do 5 wyniosła 4,0-4,1) oraz opiekunowie zatrudnieni w DPS (średnia ocen na skali od 1 do 5 wyniosła 3,6-3,8).

Większość opiekunów nie chciałaby zmienić swojej pracy, nawet gdyby miało taką okazję. We wszystkich grupach średnie wartości były niskie (średnia ocen około 2,2 na skali od 1 do 5), co oznacza, że większość badanych raczej nie rozważała zmiany zawodu. Najniższa skłonność do zmiany występowała wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS (średnia ocen 2,1 na skali od 1 do 5).

Wyniki wskazują na stosunkowo wysoki poziom identyfikacji zawodowej wśród opiekunów, którzy wskazywali na wysoki poziom dumy z wykonywanej pracy niezależnie od formy zatrudnienia i rzadko rozważali zmianę miejsca zatrudnienia.

Infografika 8. Ocena różnych stwierdzeń dotyczących pracy przez opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

Wypalenie zawodowe

Opiekunom zadano również pytania dotyczące ich doświadczeń związanych z obciążeniem psychofizycznym i ryzykiem wypalenia zawodowego. Analizie poddano zarówno pozytywne aspekty pracy, takie jak poczucie sensu, satysfakcja zawodowa i motywacja do wykonywania obowiązków, jak również czynniki mogące sprzyjać przeciążeniu i pogorszeniu dobrostanu pracowników, m.in.

emocjonalne wyczerpanie, nadmiar obowiązków, konflikt między pracą a życiem prywatnym czy poczucie niedoceny.

Spośród analizowanych aspektów pracy opiekunów w Małopolsce najwyższe oceny dotyczyły sensu wykonywanej pracy, satysfakcji zawodowej oraz motywacji. Najniżej natomiast oceniane były aspekty związane z uciążliwością pracy, nadmiarem obowiązków, kolizją z życiem prywatnym oraz poczuciem niesprawiedliwego traktowania.

Opiekunowie najwyżej oceniali poczucie sensu wykonywanej pracy. Satysfakcja z wykonywanej pracy oraz motywacja i zapał do pracy również osiągały stosunkowo wysokie wartości we wszystkich analizowanych grupach.

Wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, najwyższe wyniki w tych trzech obszarach odnotowano w grupie wiekowej 40-59 lat. W przypadku opiekunów w DPS największe poczucie sensu pracy oraz najwyższą satysfakcję deklarowały osoby w wieku 40-59 lat, natomiast najwyższy poziom motywacji odnotowano w grupie 40-49 lat. Z kolei wśród opiekunów zatrudnionych u Zleceniobiorców, najwyższe wartości w tych trzech obszarach wskazywali opiekunowie w wieku 60-69 lat.

Większe zróżnicowanie widoczne było w obszarze dotyczącym poczucia doceny wykonywanej pracy przez innych. Najniższe wartości odnotowano wśród opiekunów zatrudnionych w DPS (średnia 3,0). Wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS i przez Zleceniobiorców OPS/CUS wskaźniki były wyższe (średnie ocen odpowiednio 3,8 i 4,1), co sugeruje bardziej pozytywne doświadczenia w tym zakresie w tych dwóch grupach.

W zakresie negatywnych doświadczeń zawodowych wyraźnie wyróżnia się grupa opiekunów zatrudnionych w DPS. To właśnie w tej grupie najczęściej wskazywano na emocjonalne wyczerpanie związane z pracą (3,5) oraz przychodzenie do pracy mimo choroby lub złego samopoczucia (3,4), co może być związane ze specyfiką

pracy w DPS, w tym z koniecznością zapewnienia nieprzerwanej opieki osobom niesamodzielnym. Na stosunkowo wysokim poziomie utrzymywały się również wskazania dotyczące uciążliwości lub niebezpiecznego charakteru pracy (3,3) oraz nadmiaru obowiązków zawodowych (3,3). Niższe, choć nadal zauważalne wartości dotyczyły konfliktu między wymaganiami pracy a życiem prywatnym (2,5) oraz poczucia niesprawiedliwego traktowania w pracy (2,6).

W grupie opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS poziom deklarowanych trudności był wyraźnie niższy, co można wiązać ze specyfiką tej formy pracy, która ma co do zasady mniej specjalistyczny charakter wsparcia. Najwyższe średnie wartości dotyczyły emocjonalnego wyczerpania (3,1) oraz przychodzenia do pracy mimo złego samopoczucia (3,0). Pozostałe doświadczenia osiągały wartości poniżej poziomu 3, co wskazuje na umiarkowaną lub raczej sporadyczną częstotliwość ich występowania. Dotyczy to uciążliwości pracy (2,8), nadmiaru obowiązków (2,6), konfliktu praca – życie prywatne (2,2) oraz poczucia niesprawiedliwego traktowania (1,9).

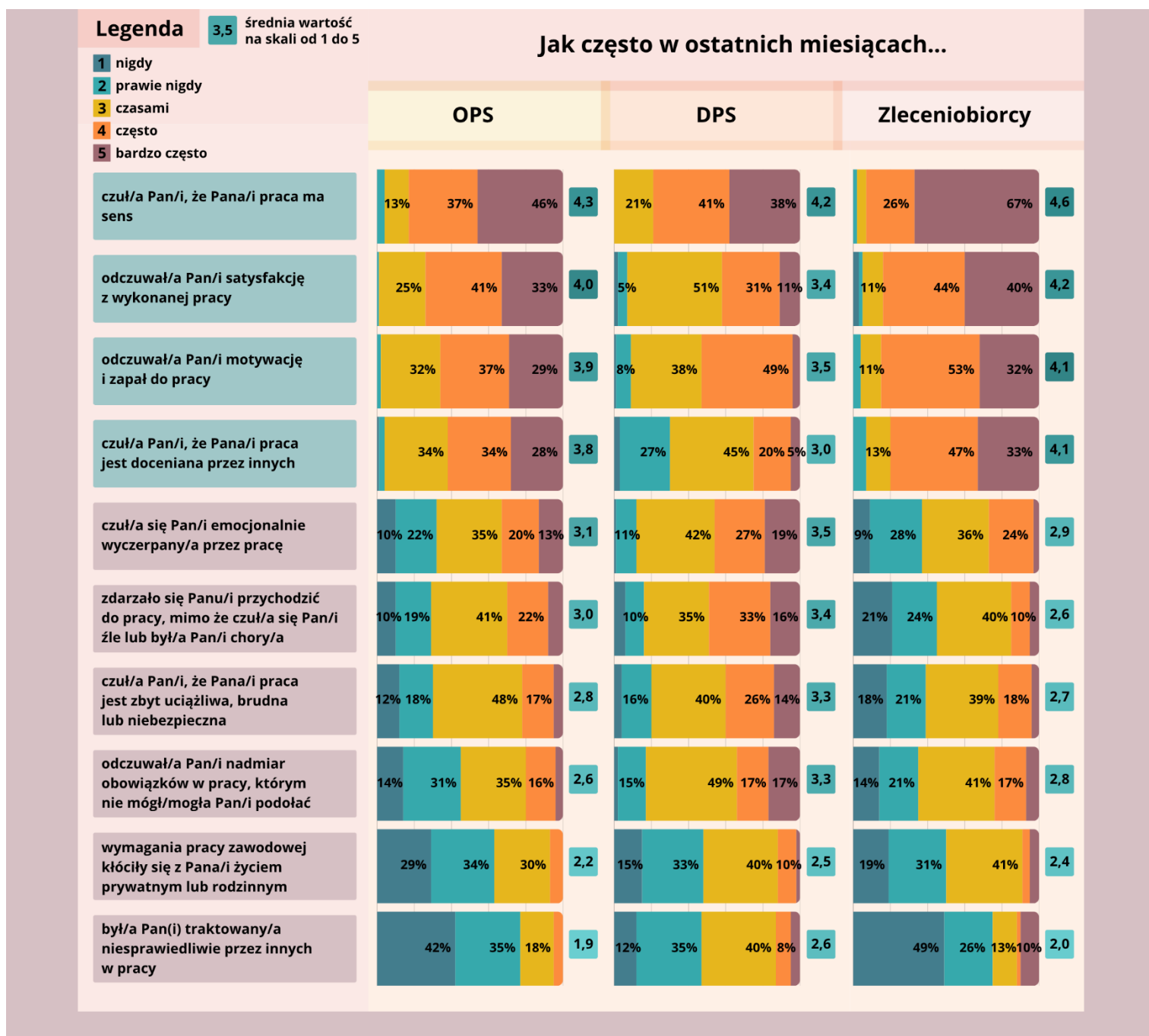
Najniższe wartości średnie w zakresie analizowanych trudności odnotowano w grupie opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców. Doświadczenia takie jak emocjonalne wyczerpanie (2,9), przychodzenie do pracy mimo złego samopoczucia (2,6) oraz uciążliwość pracy (2,7) występowały wśród nich rzadziej niż w pozostałych grupach. Najrzadziej opiekunowie zatrudnieni w tego rodzaju podmiotach deklarowali poczucie niesprawiedliwego traktowania w pracy (2,0).

Najwyższy poziom obciążeń zawodowych deklarowali opiekunowie zatrudnieni w DPS. Niższy poziom zaobserwowano wśród opiekunów pracujących w OPS/CUS, natomiast opiekunowie zatrudnieni przez Zleceniobiorców relatywnie rzadziej wskazywali na występowanie tego rodzaju obciążeń.

Wyniki wskazują na charakterystyczne współwystępowanie wysokiego poczucia sensu pracy z jednoczesnym obciążeniem psychicznym i organizacyjnym,

szczególnie wśród opiekunów zatrudnionych w DPS. Może to oznaczać, że praca opiekuńcza była postrzegana jako wartościowa i ważna społecznie, lecz jednocześnie bardzo wymagająca.

Infografika 9. Ocena częstości występowania szeregu sytuacji związanych z pracą przez opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz u Zleceniobiorców



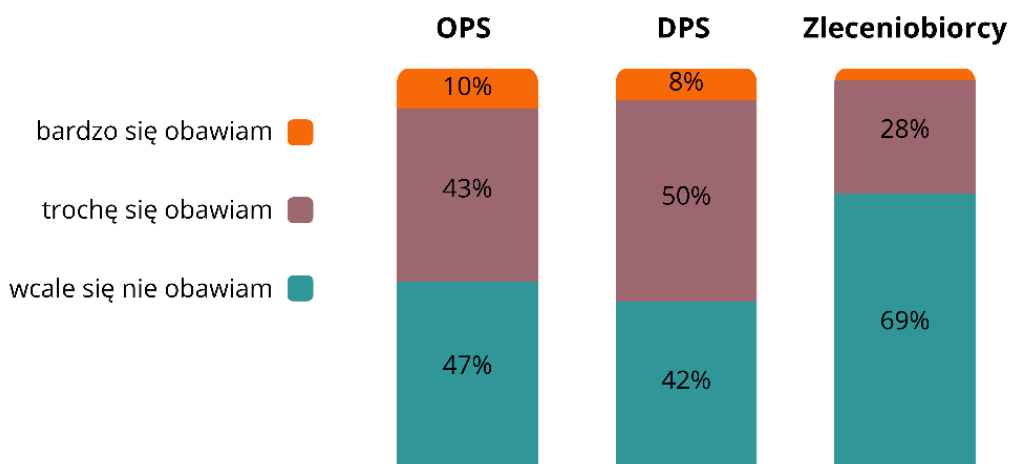
Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

Plany i obawy związane z zakończeniem lub zmianą pracy

Większość opiekunów w województwie małopolskim nie obawiała się utraty pracy. Wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, 47% badanych wcale nie obawiało się utraty pracy, a 43% trochę się tego obawiało; jedynie 10% deklarowało silne obawy. Umiarkowany niepokój najczęściej występował wśród osób w wieku 30–59 lat, natomiast silne obawy pojawiały się zdecydowanie rzadziej i dotyczyły najczęściej grupy wiekowej 40-59 lat.

W przypadku opiekunów zatrudnionych w DPS połowa badanych nieco obawiała się utraty pracy, 42% w ogóle się tego nie obawiało, a 8% bardzo się obawiało utraty pracy. Najwyższy poziom niepokoju występował w grupie opiekunów w wieku 30–59 lat.

Wykres 7. Stopień obaw przed utratą pracy wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców



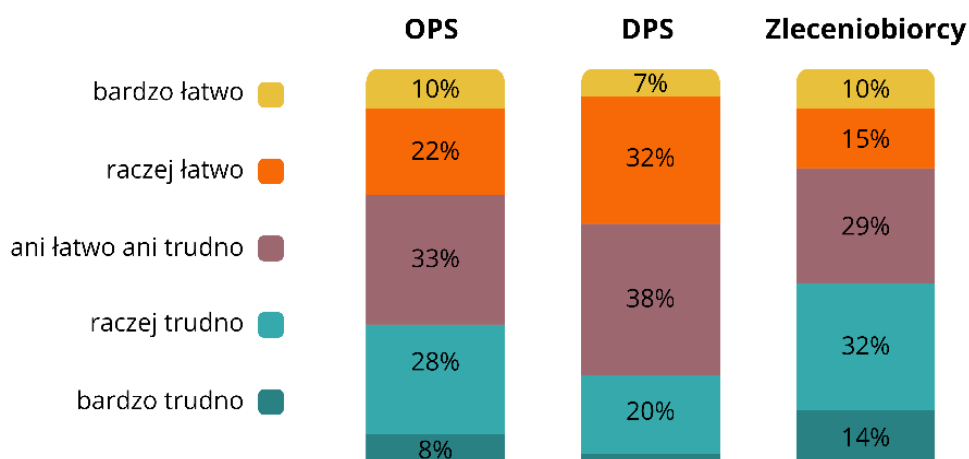
Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

Najniższy poziom obaw przed utratą pracy występował wśród opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców OPS/CUS: 69% z nich wcale nie obawiało się utraty pracy, 28% deklarowało niewielkie obawy, a jedynie 3% bardzo obawiało się utraty pracy. Warto przy tym zauważyć, że niski poziom obaw związanych z potencjalną utratą pracy wydaje się powiązany z faktem, że znaczną

część tej grupy opiekunów stanowiły osoby w wieku powyżej 60 lat, które wykazywały najniższy poziom tego rodzaju obaw (80% z nich wcale nie obawiało się utraty pracy). Prawdopodobne jest, że dla większości z tych osób z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego praca jest dodatkowym, a nie podstawowym źródłem dochodu, przy czym część z nich może planować zakończenie pracy w nieodległej perspektywie. Z kolei największy poziom umiarkowanego niepokoju występował wśród osób w wieku okołoemerytalnym, czyli 50–59 lat.

Rozkład odpowiedzi dotyczących oceny łatwości znalezienia nowej pracy, co najmniej tak samo dobrej jak obecna, wśród opiekunów realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zatrudnionych w OPS/CUS, był stosunkowo równomierny. Największa grupa badanych uważała, że znalezienie takiej pracy byłoby raczej trudne lub bardzo trudne (36%), byli to w większości opiekunowie w wieku 40-59 lat. Jednocześnie co trzeci opiekun (33%) oceniał, że nie byłoby to ani łatwe, ani trudne. Niewiele mniej respondentów (32%) wskazało natomiast, że znalezienie pracy równie dobrej jak obecna byłoby raczej łatwe bądź bardzo łatwe.

Wykres 8. Ocena łatwości znalezienia nowej pracy, co najmniej tak samo dobrej jak obecna, wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców

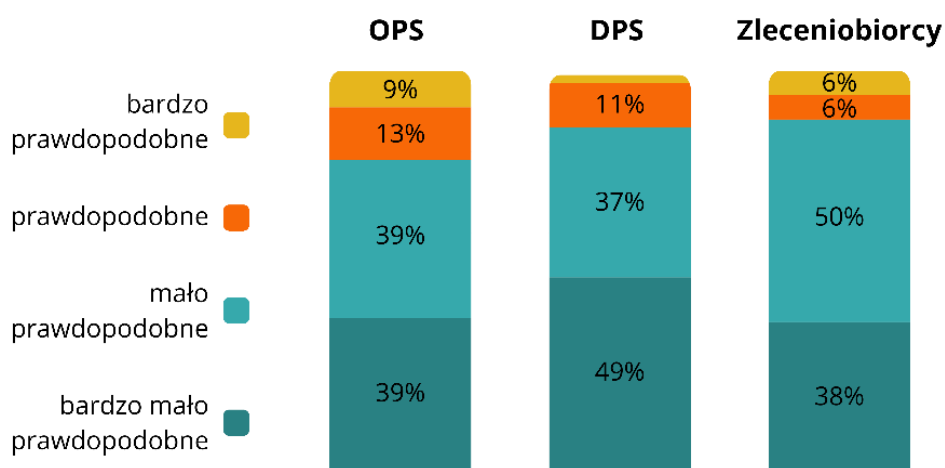


Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

Wśród opiekunów zatrudnionych w DPS 39% oceniło, że znalezienie pracy co najmniej tak samo dobrej jak obecna byłoby raczej lub bardzo łatwe, a 38% – że nie byłoby to ani łatwe, ani trudne. Mniej respondentów (23%) wskazało natomiast, że znalezienie pracy równie dobrej jak obecna byłoby raczej lub bardzo trudne, były to osoby głównie w wieku 40-59 lat.

Prawie połowa opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców (46%), oceniło, że znalezienie pracy tak samo dobrej jak obecna byłoby raczej lub bardzo trudne, byli to opiekunowie w wieku 50 lat i więcej. Co czwarty opiekun (25%) wskazywał natomiast, że znalezienie pracy równie dobrej jak obecna byłoby raczej lub bardzo łatwe, a 29% opiekunów uważało, że nie byłoby to ani łatwe, ani trudne.

Wykres 9. Ocena prawdopodobieństwa zakończenia pracy w obecnym miejscu zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

We wszystkich analizowanych grupach większość opiekunów w województwie małopolskim oceniała prawdopodobieństwo zakończenia pracy w obecnym miejscu zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy jako mało lub bardzo mało. Odsetek takich wskazań wyniósł 78% wśród opiekunów realizujących usługi

opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zatrudnionych w OPS/CUS, 86% wśród opiekunów zatrudnionych w DPS oraz 88% wśród opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców. Jednocześnie odpowiednio 22%, 14% i 12% badanych za prawdopodobne lub bardzo prawdopodobne uznało zakończenie pracy w obecnym miejscu zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Warto zauważyć, że opiekunowie zatrudnieni w DPS, którzy na ogół niżej oceniali różne aspekty pracy niż pracownicy OPS/CUS, rzadziej aniżeli opiekunowie środowiskowi deklarowali możliwość zakończenia lub zmiany tej pracy, mimo że nie postrzegali takiej zmiany jako trudnej.

Respondenci, którzy wskazali, że zmiana pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest prawdopodobna lub bardzo prawdopodobna, zostali zapytani o jej możliwe przyczyny.

Wykres 10. Najbardziej prawdopodobny powód zakończenia pracy w obecnym miejscu zatrudnienia w najbliższych 12 miesiącach wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS (liczba opiekunów)

		OPS	DPS	Zleceniobiorcy
ZMIANA PRACY	rozpoczęcie pracy w innym miejscu na podobnym stanowisku	1	14	1
	rozpoczęcie pracy w innym zawodzie	1	3	
	założenie własnej działalności		2	1
REZYGNACJA Z PRACY	przejście na emeryturę	1	8	
	rezygnacja z pracy zawodowej			4
ZAKOŃCZENIE UMOWY LUB JEJ ROZWIĄZANIE PRZEZ PRACODAWCĘ		4	6	

Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 8, N (DPS) = 31, N (Zleceniobiorcy) = 6.

Odpowiedzi większości opiekunów we wszystkich typach podmiotów opiekuńczych w Małopolsce wskazują na brak planów związanych ze zmianą zawodu, jednak dosyć duża była liczba opiekunów wskazujących na prawdopodobne zakończenie pracy w podmiocie ze względu na wiek, czy też wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy przez pracodawcę.

Wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS najczęściej wskazywanym powodem było zakończenie umowy lub jej rozwiązanie przez pracodawcę (4 z 8 wskazań). Opiekunowie zatrudnieni w DPS najczęściej jako powód wskazywali rozpoczęcie pracy w innym miejscu na podobnym stanowisku (14 z 31). Może to częściowo odzwierciedlać obserwowane w skali kraju zjawisko odpływu kadr z domów pomocy społecznej do podmiotów leczniczych, związane w dużej mierze z bardziej konkurencyjnymi warunkami zatrudnienia i wynagrodzeniami w sektorze ochrony zdrowia, na co zwracała uwagę m.in. Najwyższa Izba Kontroli²¹.

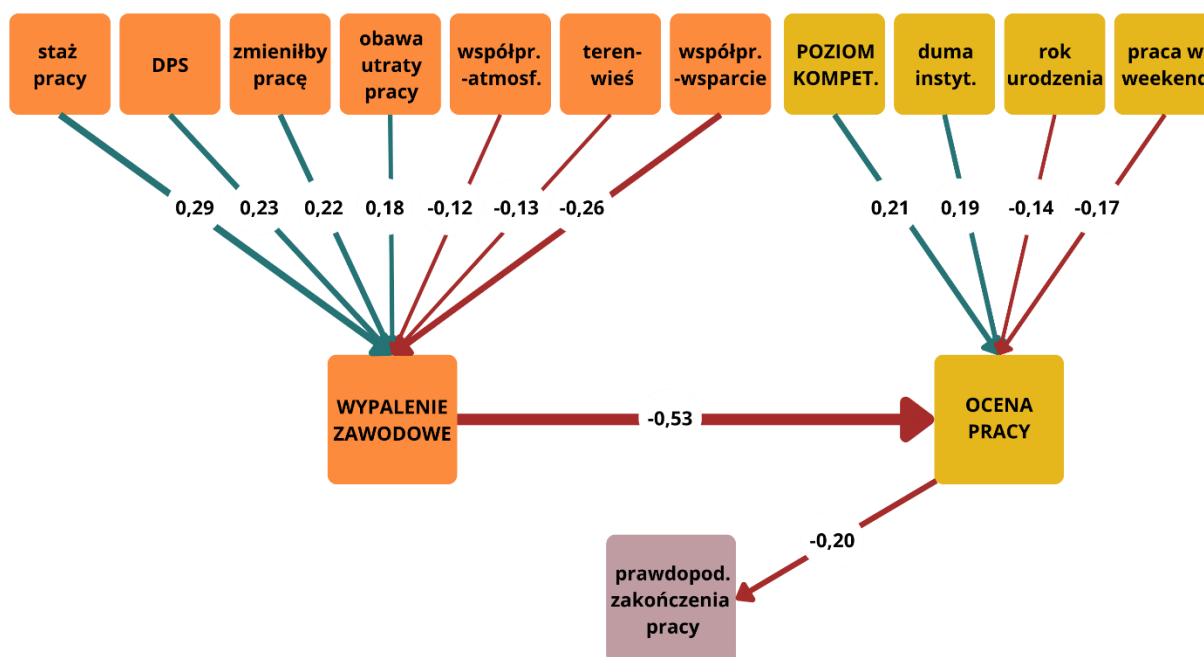
Nieco rzadziej jako powód prawdopodobnego zakończenia pracy opiekunowie wymieniali przejście na emeryturę (8 z 31) oraz zakończenie umowy lub jej rozwiązanie przez pracodawcę (6 z 31). Z kolei opiekunowie zatrudnieni przez Zleceniobiorców, najczęściej wskazywali na rezygnację z pracy zawodowej (4 z 6). Warto zauważyć, że wszystkie osoby zatrudnione przez Zleceniobiorców, które wskazywały na prawdopodobne zakończenie pracy w obecnym miejscu zatrudnienia, były w wieku emerytalnym (najmłodsza z nich miała 65 lat).

²¹ Najwyższa Izba Kontroli, *Przestrzeganie praw mieszkańców domów pomocy społecznej przeznaczonych dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych. Informacja o wynikach kontroli*, nr ewid. P/24/061, Warszawa 2024.

Co wpływa na zadowolenie z pracy i wypalenie zawodowe?

W celu zbadania zależności pomiędzy cechami pracy, wypaleniem zawodowym, oceną pracy oraz prawdopodobieństwem zmiany pracy zastosowano model równań strukturalnych (SEM), którego graficzną reprezentacją jest Rysunek 1.

Rysunek 1. Schemat modelu SEM określającego czynniki wpływające na ocenę pracy przez opiekunów formalnych oraz poziom wypalenia zawodowego



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N = 263.

Wszystkie zmienne w modelu są zmiennymi obserwowalnymi. Wielkimi literami oznaczono zmienne, które są indeksami wyliczonymi na podstawie innych zmiennych ankiety. Schemat przedstawia standaryzowane współczynniki β .

Schemat ten przedstawia zależności między wypaleniem zawodowym, oceną pracy oraz prawdopodobieństwem jej zakończenia, a także zestawem predyktorów organizacyjnych i indywidualnych²². Współczynniki na strzałkach są

²² Na wizualizacjach wielkimi literami są oznaczone wskaźniki obliczone w oparciu o inne zmienne. Zmienne „OCENA PRACY” oraz „POZIOM KOMPETENCJI” są obliczone jako średnie z zestawów pytań dotyczących odpowiednio różnych aspektów pracy (Infografika 8) oraz samooceny poziomu kompetencji przez opiekunów (Infografika 10). Zmienna „WYPALENIE ZAWODOWE” została obliczona jako średnia 10 pytań dotyczących tego,

standaryzowanymi współczynnikami regresji (β). Oznacza to, że pokazują one siłę i kierunek zależności między zmiennymi, wyrażonej w jednostkach odchyłeń standardowych. Wartości dodatnie wskazują na wzrost jednej zmiennej wraz ze wzrostem drugiej, natomiast wartości ujemne oznaczają zależność odwrotną. Dopasowanie modelu równań strukturalnych do danych jest dobre²³.

Tabela 1. Współczynniki modelu SEM określającego czynniki wpływające na ocenę pracy przez opiekunów oraz poziom wypalenia zawodowego

	Współ- czynnik β	Błąd stand.	Wartość z	p (poziom istotności)	Współ- czynnik β
WYPALENIE ZAWODOWE ~					
staż pracy	0,022	0,004	5,691	0,000	0,293
obawa utraty pracy	0,238	0,059	4,021	0,000	0,185
współprac. - dobra atmosfera	-0,078	0,040	-1,968	0,049	-0,120
współprac. - może liczyć na wsparcie	-0,173	0,034	-5,105	0,000	-0,258
gdyby miał okazję zmienićby pracę	0,129	0,028	4,658	0,000	0,222
pracuje na terenie wsi	-0,181	0,067	-2,712	0,007	-0,135
opiekun w DPS	0,298	0,072	4,160	0,000	0,230
OCENA PRACY ~					
WYPALENIE ZAWODOWE	-0,581	0,051	-11,328	0,000	-0,529
dumny z pracy w tej instytucji	0,156	0,042	3,688	0,000	0,185
rok urodzenia	-0,010	0,003	-3,319	0,001	-0,138
pracuje w weekendy	-0,050	0,012	-4,079	0,000	-0,171
SAMOOCENA KOMPETENCJI	0,243	0,060	4,075	0,000	0,207
prawdopodobieństwo zakończenia pracy ~					
OCENA PRACY	-0,233	0,077	-3,038	0,002	-0,196

Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N = 263.

Wielkimi literami oznaczono zmienne, które są indeksami wyliczonymi na podstawie innych zmiennych ankiety.

jak często występują poszczególne sytuacje w pracy, przedstawione na Infografice 8 (skale odwrócone w przypadku pytań wskazujących na brak wypalenia zawodowego).

²³ Estymator: ML, metoda optymalizacji: NLMINB, liczba parametrów modelu: 16, liczba obserwacji: 262. Wartości skorygowane miar jakości modelu: Comparative Fit Index (CFI) = 0,978, Tucker-Lewis Index (TLI) = 0,966. Wskaźnik RMSEA – wartość skorygowana = 0,037 (90% przedział ufności – dolna granica: 0,000, górna granica: 0,066), wartość p dla H_0 : RMSEA $\leq$ 0,05 = 0,735.

Analiza współczynników regresji wskazuje, że wszystkie uwzględnione w modelu zależności były istotne statystycznie ($p < 0,05$). Tabela 1 przedstawia wartości miar efektów – współczynników regresji (b), które informują o tym, o ile jednostek zmieni się wartość zmiennej zależnej przy wzroście zmiennej niezależnej o jedną jednostkę, przy założeniu stałości pozostałych zmiennych w modelu.

W przeciwieństwie do współczynników standaryzowanych (β), pozwalają one interpretować wielkość efektów w oryginalnych jednostkach pomiaru analizowanych zmiennych. Z kolei standaryzowane współczynniki regresji (β) pozwalają porównać względną siłę poszczególnych zależności w modelu, gdyż są wyrażone w jednostkach odchylenia standardowego – im większa wartość bezwzględna współczynnika β , tym silniejszy związek między zmiennymi.

Wyniki modelu równań strukturalnych wskazują, że wypalenie zawodowe było wyjaśniane przez zestaw czynników związanych z doświadczeniem zawodowym, warunkami pracy oraz współpracą w miejscu pracy.

Wśród predyktorów wypalenia zawodowego były:

- **staż pracy** ($\beta = 0,29$) – dłuższy staż wiązał się z wyższym poziomem wypalenia
- **wsparcie współpracowników** ($\beta = -0,26$) – osoby, które wskazywały, że mogą liczyć na wsparcie współpracowników w razie potrzeby, miały niższy poziom wypalenia zawodowego
- **praca w DPS** ($\beta = 0,23$) – opiekunowie zatrudnieni w DPS mieli wyższy poziom wypalenia zawodowego
- **otwartość na inne możliwości zawodowe** ($\beta = 0,22$) – osoby, które wskazywały, że zmieniłyby obecną pracę na inną, gdyby przytrafiła się taka okazja, mieli wyższy poziom wypalenia zawodowego
- **obawa utraty pracy** ($\beta = 0,18$) – poczucie niepewności zatrudnienia wiązało się z większym wypaleniem zawodowym

- **praca na terenie wsi** ($\beta = -0,13$) – opiekunowie wykonujący pracę na terenach wiejskich mieli przeciętnie niższy poziom wypalenia zawodowego, aniżeli ci pracujący w miastach, czy też zarówno w mieście, jak i na wsi
- **atmosfera w pracy** ($\beta = -0,12$) – dobra atmosfera w pracy obniżała poziom wypalenia zawodowego.

Zatem wśród najsilniejszych predyktorów wypalenia opiekunów w województwie małopolskim był staż pracy ($\beta = 0,29$), co oznacza, że osoby z dłuższym doświadczeniem zawodowym pracujący w tych samych warunkach deklarowały przeciętnie wyższy poziom wypalenia. Wskazuje to, że długotrwałe funkcjonowanie w wymagającym środowisku pracy może sprzyjać stopniowemu narastaniu objawów wypalenia. Co więcej, bardziej wypaleniu zawodowemu sprzyjała praca w DPS oraz na terenach miejskich, co może być związane z większym nakładem pracy oraz skupieniem w miastach osób wymagających większego wsparcia ze względu na stan zdrowia. Wyniki te sugerują, że zarówno specyfika miejsca pracy, jak i poczucie niepewności zatrudnienia mogą zwiększać poziom wypalenia zawodowego.

Z kolei czynniki związane z relacjami interpersonalnymi w miejscu pracy okazały się czynnikami ochronnymi. Lepsza atmosfera w pracy ($\beta = -0,12$) oraz większa pewność wsparcia ze strony współpracowników ($\beta = -0,26$) wiązały się z niższym poziomem wypalenia zawodowego. Szczególnie silny był wpływ wsparcia współpracowników, co wskazuje, że relacje w zespole pełnią rolę ochronną i mogą redukować lub wręcz neutralizować stres zawodowy wśród pracowników.

Centralną zależnością w modelu był związek pomiędzy wypaleniem zawodowym a oceną pracy. **Wypalenie zawodowe** było silnym negatywnym predyktorem oceny pracy ($\beta = -0,53$). Oznacza to, że wzrost poziomu wypalenia o jedno odchylenie standardowe wiązał się przeciętnie ze spadkiem oceny pracy o ponad

pół odchylenia standardowego. Był to najsilniejszy efekt w modelu, co sugeruje, że wypalenie zawodowe odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu ogólnej oceny pracy.

Wśród innych czynników wpływających na ocenę pracy były:

- **poziom kompetencji** ($\beta = 0,21$) – pracownicy lepiej oceniający własne kompetencje na ogół również lepiej oceniali swoje warunki pracy
- **identyfikacja z miejscem pracy** ($\beta = 0,19$) – poczucie dumy związane z pracą w instytucji wiązało się z lepszą oceną warunków pracy
- **pracą w weekendy** ($\beta = -0,17$) – praca w weekendy obniża satysfakcję z pracy
- **rok urodzenia** ($\beta = -0,14$) – osoby ze starszych roczników nieco gorzej oceniają warunki pracy

Najbardziej na ocenę pracy wpływały zatem samoocena poziomu własnych kompetencji ($\beta = 0,21$) oraz identyfikacja z instytucją ($\beta = 0,19$). Oznacza to, że osoby oceniające swoje kompetencje jako wyższe oraz odczuwające większą identyfikację z instytucją częściej pozytywnie oceniały swoje warunki pracy. Negatywnie z oceną warunków pracy powiązane były natomiast rok urodzenia ($\beta = -0,14$) oraz praca w weekendy ($\beta = -0,17$). W praktyce oznacza to, że osoby z wcześniejszych roczników oraz osoby pracujące w weekendy miały tendencję do nieco gorszej oceny swoich warunków pracy.

Ocena pracy była z kolei istotnym predyktorem prawdopodobieństwa zmiany pracy ($\beta = -0,20$). Wynik ten wskazuje, że im bardziej pozytywna była ocena pracy, tym mniejsze prawdopodobieństwo deklarowania prawdopodobieństwa jej zakończenia. Choć efekt ten był umiarkowany, potwierdza on znaczenie satysfakcji z pracy dla stabilności zatrudnienia.

Struktura modelu pozwala również na identyfikację efektów pośrednich –

zależności, w których jedna zmienna wpływa na inną poprzez zmienną pośredniczącą. Najważniejszy efekt pośredni w modelu przebiega następująco:

predyktory wypalenia → wypalenie → ocena pracy

Ponieważ wypalenie silnie obniżało ocenę warunków pracy ($\beta = -0,53$), czynniki zwiększające wypalenie będą pośrednio obniżały ocenę pracy, natomiast czynniki zmniejszające wypalenie będą pośrednio ją poprawiały.

Przykładowo, na ocenę pracy pośrednio wpływały:

- **staż pracy** – dłuższy staż pracy pośrednio wiązał się z niższą oceną pracy poprzez zwiększenie poziomu wypalenia.

$$\beta = 0,29 \times -0,53 \approx -0,15$$

- **wsparcie współpracowników** – wsparcie w zespole pośrednio poprawiało ocenę pracy, gdyż zmniejszało poziom wypalenia

$$\beta = -0,26 \times -0,53 \approx 0,14$$

Z kolei na prawdopodobieństwo zakończenia pracy pośrednio wpływało wypalenie zawodowe. Oznacza to, że wyższy poziom wypalenia pośrednio zwiększał prawdopodobieństwo zmiany pracy, ponieważ obniżał ocenę pracy.

wypalenie → ocena pracy → zmiana pracy

$$\beta = -0,53 \times -0,20 \approx -0,11$$

Wyniki modelu opracowanego na podstawie przeprowadzonych badań wskazują, że wypalenie zawodowe pełniło centralną rolę w analizowanej strukturze zależności. Było ono powiązane zarówno z cechami pracy, jak i relacjami w zespole, a jednocześnie silnie wpływało na sposób, w jaki pracownicy oceniali swoją pracę.

Najważniejszym czynnikiem ochronnym okazało się wsparcie współpracowników, które zmniejszało poziom wypalenia i pośrednio poprawiało ocenę pracy. Z kolei dłuższy staż pracy oraz niepewność zatrudnienia sprzyjały wzrostowi wypalenia.

Wypalenie zawodowe obniżało ocenę pracy, co wiązało się z większym prawdopodobieństwem deklarowania chęci zmiany pracy. Wyniki te sugerują, że działania organizacyjne ukierunkowane na ograniczanie wypalenia – zwłaszcza poprzez wzmacnianie wsparcia w zespole – mogą przyczyniać się zarówno do poprawy oceny pracy, jak i do zmniejszenia rotacji pracowników.

Doświadczenia zawodowe opiekunów – problemy, motywacje i pozytywne aspekty pracy

Opiekunowie udzielający odpowiedzi na pytania ankiety mogli również uzupełnić ją o wolną wypowiedź dotyczącą własnej pracy. Analiza tych wypowiedzi pozwala uchwycić nie tylko strukturalne problemy organizacyjne i systemowe, lecz także indywidualne doświadczenia, motywacje oraz źródła satysfakcji zawodowej. Materiał empiryczny ujawnia wyraźne napięcie pomiędzy wysokim poziomem zaangażowania opiekunów a niedoskonałościami systemu, w którym funkcjonują. Poniżej przedstawiono analizę w dwóch kluczowych wymiarach: problemów zawodowych opiekunów oraz czynników motywujących do pracy w tym zawodzie w województwie małopolskim.

Jednym z najczęściej wskazywanych problemów przez opiekunów zatrudnionych zarówno w OPS/CUS, jak i w DPS były **niskie wynagrodzenia**, postrzegane jako często nieadekwatne do zakresu obowiązków i poziomu odpowiedzialności.

„Pracownicy - opiekunowie w DPS powinni mieć takie same wynagrodzenie jak w jednostkach medycznych. Wykonujemy więcej pracy, mamy większą odpowiedzialność za cały budynek oraz wszystkich podopiecznych.” (DPS)

„Rola opiekuna jest bardzo ważna, zawód też wiąże się z dużą odpowiedzialnością fizyczną i psychiczną, mimo to płace są bardzo niskie. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Zadowolony pracownik to dobry pracownik.” (OPS)

„Brak satysfakcji finansowej, wynagrodzenie nieadekwatne do wykonywanych obowiązków, co wpływa na motywację do pracy” (DPS)

Z tym wiązało się poczucie **niedocenia**nia zawodu, zarówno finansowego, jak i społecznego – ze strony przełożonych, władz, systemu, ale również w zakresie postrzeganego uznania społecznego wobec zawodu.

„Jest to ciężka praca i bardzo niedoceniana, również pod względem zarobków. Chciałabym, aby osoby zarządzające przyszły zobaczyć co się tu dzieje. Są momenty bardziej spokojne, ale też wiele dni, w których dzieją się takie rzeczy, że można się nogą przywitać.” (DPS)

„Praca ciężka, satysfakcjonująca, ale mało doceniana.” (DPS)

Innym kluczowym problemem był niedobór personelu, skutkujący większym nakładem pracy przypadającym na jedną osobę, a w konsekwencji wysokim obciążeniem psychofizycznym i **przeciążeniem** pracą, co dotyczy w szczególności domów pomocy społecznej:

„Opiekun ma zbyt dużo pracy do wykonania. Za mało opiekunów przypadających na jednego mieszkańca, a za dużo obowiązków.” (DPS)

„Praca jest trudna z powodu, iż opiekunów jest coraz mniej i tę pracę, którą kiedyś wykonywałyśmy we dwie teraz wykonuje jedna osoba.” (DPS)

W domach pomocy społecznej szczególnie wyraźne były wyzwania i problemy o charakterze organizacyjnym i systemowym. Jednym z źródeł napięć i wypalenia mogą być **trudne relacje z kadrą zarządzającą**, a także konflikty w obszarze godzenia praw mieszkańców z prawami pracowników świadczących opiekę.

„Były Dyrektor źle traktował pracowników, w pracy był prawdziwy mobbing.” (DPS)

„Brak komunikacji między mną pracownikiem a dyrektorem placówki, brak docenienia pracy przez dyrektora placówki.” (DPS)

„Mieszkaniec ma prawo do picia alkoholu i palenia papierosów. Często palą na korytarzu, jak się zwróci uwagę jest wielki problem, ale dyrektor nie jest za nami, bo mieszkańcy mają prawo. (...) Wcześniej pracowałam w Krakowie i było tak samo. Jak mieszkaniec za dużo wypije to opiekun ponosi odpowiedzialność.” (DPS)

Problemem w części przypadków było także **niedopasowanie kompetencyjne** względem zakresu obowiązków, co może sprawiać, że opiekunowie mogli czuć się niewystarczająco przygotowani do wykonywania czynności wymagających większej odpowiedzialności i doświadczenia:

„Szkoła dla opiekunów medycznych nie przygotowuje do pobierania krwi. Ćwiczenia były na manekinie. Nie czuję się na siłach, aby to wykonywać i to co jest w zakresie czynności. Często pielęgniarek nie ma i każą opiekunom zastępować ich, tak układają zakres czynności by to było możliwe.” (DPS)

Pracownicy wskazywali również na **zagrożenia dla bezpieczeństwa**, które występują w pracy opiekuna, szczególnie w kontekście pracy z agresywnymi mieszkańcami w DPS:

„Wzrastająca liczba podopiecznych z dużą agresją, zagrażają sobie, współmieszkańcom i personelowi, złe rozlokowanie tych mieszkańców, zbyt mało personelu do nich. Często jesteśmy pobici. Pracownicy ulegają wypadkom w czasie interwencji przez agresywnych podopiecznych. Częste zwolnienia lekarskie po pobiciu przez podopiecznego.” (DPS)

Dodatkowym obciążeniem dla części pracowników sektora opieki był **system pracy zmianowej**, szczególnie nocnej i świątecznej, który stanowi obciążenie dla części pracowników, szczególnie w zakresie godzenia pracy z innymi obowiązkami i życiem rodzinnym:

„W tym momencie pracuję w systemie 8 h (na moją prośbę dyrektor dostosował zmiany, do mojej chwilowo trudnej sytuacji rodzinnej) i moja ocena

warunków pracy jest zdecydowanie lepsza niż gdybym wypełniała ankietę pracując jak dotąd w systemie 12h, który jest bardzo obciążający zarówno dla organizmu, jak i zdecydowanie wpływa na funkcjonowanie mojej rodziny – zmęczenie po nocnych zmianach, praca w weekendy i święta, brak dodatkowego wynagrodzenia za dyżury świąteczne oraz zaledwie 20% stawki od 22ej do 6tej rano, które w żaden sposób nie rekompensuje trudów pracy w godzinach nocnych czy w dni świąteczne.” (DPS)

Innym ważnym problemem w systemie opieki – szczególnie w odniesieniu do opieki środowiskowej świadczonej przez opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS oraz przez Zleceniobiorców – była **niestabilność zatrudnienia**. Brak umowy o pracę wiąże się z niepewnością co do własnej przyszłości zawodowej, a także brakiem wystarczającego zabezpieczenia socjalnego.

„Lubię to, ale praca jest niestabilna. Kiedy to w końcu zasłużę na umowę o pracę po czterech latach? Jestem osobą, która, dzięki Bogu, nie choruje, ludzie dobrze mówią o mnie. Ale denerwuje mnie to, bo muszę również pomóc dziecku, mam kredyt, lodówkę na raty. Jestem wdową, córka jest na studiach i musi ciężko pracować. Chorobowe płacę sobie sama, musiałam być zbadana, ale gdybym nie płaciła...” (OPS)

„Bardzo chciałabym mieć umowę o pracę, ponieważ czuję się niepewnie na zleceniu” (DPS)

„Gdybym miała umowę o pracę to byłabym bardzo usatysfakcjonowana, nie szukałabym w ogóle innej pracy. Jest to praca, która mi klikła, ale umowa zlecenie to jedno, a umowa o pracę to coś innego.” (OPS)

Znaczącym wyzwaniem dla opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS były także **koszty i logistyka dojazdów**: niewliczanie czasu dojazdów do klientów do czasu pracy, ryczałt niepokrywający kosztów paliwa oraz zużywania własnego pojazdu.

„Pracując 40 godzin tygodniowo nie mam czasu na dojazdy - jest to uniedogodnienie, muszę to urywać.” (OPS)

„Lubię tą pracę, spełniam się zawodowo. Jedyny minus tej pracy to bardzo niski ryczałt i niszczenie swojego samochodu.” (OPS)

„Dostajemy mało pieniędzy na paliwo - w praktyce przejeżdżamy więcej kilometrów.” (OPS)

Innym wyzwaniem, z którym mogą mieć do czynienia opiekunowie wykonujący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania to **trudne i zróżnicowane warunki pracy** u klientów:

„Pracy jest bardzo dużo i warunki trudne u klientów - na przykład nie ma ubikacji, łazienki.” (OPS)

Rysunek 2. Główne problemy i wyzwania wymieniane w odpowiedziach otwartych przez opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

Co również istotne, charakter pracy opiekuna sprzyja **wysokiemu zaangażowaniu emocjonalnemu**, co dodatkowo może zwiększać poziom

obciążenia psychofizycznego przez konieczność stałej dostępności oraz poczucia odpowiedzialności za klienta:

„Miałam podopiecznego, który całe zaufanie przełożył na mnie, ale to całe. Nocą potrafił dzwonić i mówi, o czym się martwi w tej chwili. Pan był trudny, trudno było go oddać do szpitala lub gdzieś. Pan miał majątek, ale trzymał nie wiadomo na co, a z GOPSu mu się należy. Nie był agresywny, ale jakieś zaburzenia miał, lęki w nocy. I innym na nic nie pozwalał, innej opiekunce, pracownikowi socjalnemu. To może trochę moja wina, że zostawiłam prywatny telefon, bo zawsze coś może się zdarzyć i muszę być dostępna. A są opiekunki co nie dają swojego numeru.” (OPS)

Pomimo licznych trudności, opiekunowie wykazywali silną motywację do wykonywania zawodu, opartą przede wszystkim na czynnikach wewnętrznych. Wśród najczęściej wymienianych pozytywnych cech pracy opiekuna była satysfakcja osobista i zawodowa oparta na poczuciu **sensu i wartości społecznej pracy**:

„Stresujący, ale potrzebny zawód, starzejące się społeczeństwo, pracy bardzo dużo, ludzie czekają, klienci potrzebują. Ciężki zawód, piękny, mało opłacalny.” (OPS)

„Praca bardzo ciężka, odpowiedzialna, ale satysfakcjonująca.” (DPS)

„To jest taka druga rodzina nasza. Ja uważam, że trzeba podać rękę drugiemu i jak się da innym pomóc to trzeba to robić.” (OPS)

Silnie akcentowane były relacje międzyludzkie, w szczególności relacje z podopiecznymi. Istotne były emocjonalne nagrody pracy, takie jak **wdzięczność i zaufanie ze strony klientów**.

„Jestem zadowolona, satysfakcjonuje mnie praca przy osobach starszych, jak widzę ich uśmiech to jest jak taki prezent.” (OPS)

„Ludzie, którzy wykonują ten zawód są usatysfakcjonowani swoją pracą, to jest warto, bo mają tylko nas, są samotni i czekają na nas, liczą na nas. Ja się cieszę tym, jestem zmęczona, ale dojeżdżam, bo ktoś czeka na mnie, myślą o nas, ufają nam. (...) Są ludzie, którzy uważają, że im się należy, ale są też tacy, którzy dziękują i czekają.” (OPS)

„Ta praca sprawia mi przyjemność, lubię pomagać innym osobom.” (OPS)

Nie bez znaczenia pozostawały także warunki organizacyjne, szczególnie jakość zarządzania i **relacje z przełożonymi**. Pozytywne relacje i atmosfera w pracy, a także możliwość polegania na wsparciu przełożonego w trudnych sytuacjach były istotnym czynnikiem wpływającym na satysfakcję z pracy:

„Mam najwspanialszego szefa pod słońcem. Tacy ludzie się nie zdarzają, panią koordynator na 1,5 oceniałabym, a szefa na 10, nawet 10,5. Jest naszą ostoją, obroną, nie stwarza takiej atmosfery, że jak się wchodzi to cierpnie.” (OPS)

„Kierownictwo bardzo dobre, szefowa wyrozumiała i można porozmawiać. Miałam możliwość dorobić jakieś kursy, aby pracować w szpitalu, ale nie chciałam – pasowała mi ta praca i dobrze się w niej czułam.” (OPS)

„Szef ma dla mnie czas i zawsze jakby coś było trzeba to załatwi.” (OPS)

Dla części pracowników w województwie małopolskim motywacją do pracy w zawodzie było także **poczucie kompetencji i skuteczności**, wynikające z doświadczenia:

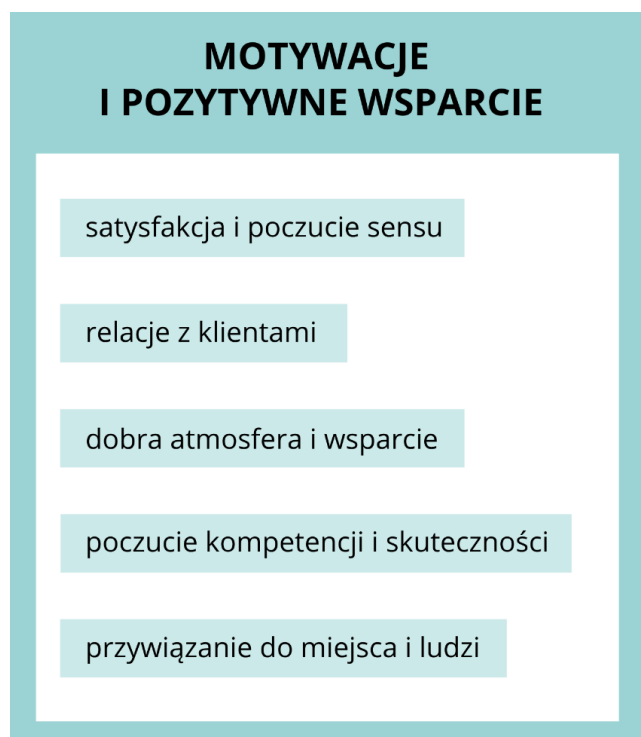
„Czasem nie przychodzą pielęgniarki do domu, które przychodzą zwykle, bo wiedzą, że ja dobrze zrobię, np. zmianę opatrunków. Lubię to i mam do tego cierpliwość. Jedna pani miała nogę do odcięcia od kolana, ale nikt nie powiedział, że jest do uratowania. Zarejestrowałam panią do chirurga, poprzyglądałam się, jak to robi. (...) W ciągu roku – potrwało to – ale potrafiłam to wyleczyć. Miałam cierpliwość i uratowałam tę nogę.” (OPS)

Niektórzy opiekunowie z dłuższym stażem podkreślają także wartość **długotrwałego związania się z miejscem pracy**, przywiązanie do instytucji oraz osób, z którymi się pracuje:

„Jestem bardzo zadowolona w pracy, jestem tak związana z DPS i podopiecznymi, że nigdzie bym dalej nie poszła. Będę pracować tu, ile Bozia da.” (DPS)

Analiza wypowiedzi opiekunów ujawnia wyraźny dualizm ich doświadczeń zawodowych. Z jednej strony mamy do czynienia z pracą o wysokim znaczeniu społecznym, silnie osadzoną w wartościach i relacjach międzyludzkich, stanowiącą źródło satysfakcji i poczucia sensu. Z drugiej strony – systemowe niedomagania, takie jak niskie wynagrodzenia, obciążenie pracą czy niestabilność

Rysunek 3. Czynniki motywujące do pracy jako opiekun w odpowiedziach otwartych opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceńbiorców



zatrudnienia, istotnie obniżają jakość pracy i zwiększają ryzyko wypalenia zawodowego.

Różnice między OPS/CUS a DPS wskazują na odmienny charakter obciążeń: w OPS/CUS dominowały problemy związane z niestabilnością i logistyką pracy, natomiast w DPS – przeciążenie systemowe, zagrożenia bezpieczeństwa i kwestie organizacyjne. Niezależnie od tych różnic, kluczowym zasobem systemu pozostaje wewnętrzna motywacja opiekunów, oparta na poczuciu misji i relacjach z podopiecznymi.

Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceńbiorczy) = 60.

Kompetencje i formy rozwoju opiekunów formalnych

Kompetencje

Kolejną kwestią, o którą zapytano osoby zarządzające podmiotami świadczącymi opiekę w Małopolsce, był poziom kompetencji opiekunów w nich zatrudnionych. Zadane pytania dotyczyły oceny poziomu różnych kompetencji wśród opiekunów zatrudnionych w jednostce, jak również znaczenia poszczególnych kompetencji w pracy opiekuna. Zarówno poziom kompetencji, jak i ich znaczenie, były oceniane przez osoby zarządzające podmiotami na skali od 1 do 3.

Badane OPS/CUS za najbardziej kluczowe kompetencje w zawodzie opiekuna (średnia ocena istotności powyżej 2,9 z 3) uznali:

- higienę i pielęgnację osób niesamodzielnych,
- nawiązywanie kontaktu i skuteczne komunikowanie się z klientami.

Większość OPS/CUS oceniła poziom tych kompetencji u swoich pracowników jako odpowiedni.

Stosunkowo często jako nieodpowiedni osoby zarządzające OPS/CUS oceniały poziom następujących kompetencji zatrudnionych przez siebie opiekunów:

- radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami, którą 69 z 160 OPS/CUS uznało za kompetencję na zbyt niskim poziomie,
- udzielanie pierwszej pomocy, którą 63 z 160 OPS/CUS uznały za kompetencję na zbyt niskim poziomie,
- komunikację międzykulturową i współpracę z cudzoziemcami, którą – pomimo stosunkowo niskiej oceny znaczenia w pracy opiekuna – co trzeci OPS/CUS (60 z 160) uznał za kompetencję na zbyt niskim poziomie.

Infografika 10. Ocena kompetencji opiekunów zatrudnionych przez OPS/CUS, DPS oraz Zleceniobiorców, a także średnia ocena stopnia, w jakim kompetencje te są potrzebne do pracy jako opiekun

Legenda

przeciętna samoocena danej kompetencji

4,0

Kompetencje

W jakim stopniu opiekunowie posiadają następujące kompetencje?

OPS

DPS

Zleceniobiorcy

za niski	odpowiedni	za wysoki		za niski	odpowiedni	za wysoki		za niski	odpowiedni	za wysoki			
		124	2,91	9		75	2,98			15	3,00		
21		112	2,91	33		48	2,94	2		14	3,00		
24		107	2,88	31		53	2,96	4		12	3,00		
		115	14	2,86	13		69	2,94		15	3,00		
	63	75	2,86	29		54	2,95	3		12	2,88		
	57	78	2,86		58	26	2,92	7		9	3,00		
	69	65	2,86		55	29	2,92	9		6	2,94		
46		89	2,84	35		47	2,93	3		12	2,75		
42		90	2,84	37		44	2,88	5		9	2	2,81	
38		97	2,83	40		43	2,85	6		9	2,88		
48		85	2,78	37		46	2,87	6		10	2,88		
49		80	2,78	38		46	2,88	5		10	2,63		
31		97	2,75	29		50	2,81			14	2	2,75	
44		85	2,70	33		48	2,87	4		12	2,56		
47		81	2,52	36		45	2,79	5		8	3	2,50	
31		79	29	2,42	29		52	2,68	5	6	5	2,56	
53		75	2,24	45		38	2,60	5		10	2,19		
35		83	21	2,06	30		41	13	2,21	3	10	3	2,06
60		62	17	2,01	35		41	8	2,30	6	10	1,94	

Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zleceniobiorcy) = 16.

Zarządzający podmiotami zostali również zapytani o to, jakie inne kompetencje są istotne w pracy osób świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Badane OPS/CUS wskazały m.in. na mobilność pracowników, związaną z posiadaniem prawa jazdy. Za kluczowe cechy osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podmioty uznają również empatię, cierpliwość, asertywność oraz zdolność szybkiego reagowania.

Za najmniej kluczowe kompetencje w zawodzie opiekuna badane OPS/CUS uznały:

- komunikację międzykulturową i współpracę z cudzoziemcami,
- obsługę komputera i innych urządzeń elektronicznych (korzystanie z internetu, aplikacji mobilnych, uczestnictwo w spotkaniach online) oraz
- podstawową znajomość odpowiednich przepisów prawnych (np. ustawy o pomocy społecznej).

Z kolei **osoby zarządzające domami pomocy społecznej** za najbardziej kluczowe kompetencje w zawodzie opiekuna (średnia ocena powyżej 2,9 z 3) uznały:

- higienę i pielęgnację osób niesamodzielnych,
- znajomość zasad i standardów opieki nad osobą starszą, niesamodzielną, z niepełnosprawnościami,
- udzielanie pierwszej pomocy,
- nawiązywanie kontaktu i skuteczne komunikowanie się z mieszkańcami,
- asystowanie w czynnościach dnia codziennego,
- wspieranie sprawności i aktywizowanie mieszkańców do samodzielności,
- radzenie sobie z własnymi emocjami,
- radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami.

Większość DPS jako odpowiedni oceniła poziom następujących kompetencji swoich pracowników świadczących opiekę:

- higienę i pielęgnację osób niesamodzielnych - 75 z 84 placówek uznało ją za kompetencję na odpowiednim poziomie,
- asystowanie w czynnościach dnia codziennego - 69 z 84 placówek uznało ją jako kompetencję na odpowiednim poziomie.

Z kolei jako nieodpowiedni osoby zarządzające DPS stosunkowo często oceniały poziom następujących kompetencji zatrudnionych opiekunów:

- radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami oraz z własnymi emocjami, które ponad połowa podmiotów (odpowiednio 55 i 58 na 84) określiła jako niewystarczające;
- podstawową znajomość odpowiednich przepisów prawnych, którą 45 z 84 DPS uznało za kompetencję na zbyt niskim poziomie;
- komunikację i opiekę nad osobami z demencją, które odpowiednio 40 i 37 z 84 DPS uznało za kompetencje na zbyt niskim poziomie.

W tym kontekście zwracają uwagę także dość niskie oceny kompetencji opiekunów w DPS w zakresie oceniania stanu i możliwości funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego mieszkańców, opracowywanie dla nich planu pomocy i opieki, a także wspierania ich sprawności i aktywizowania do samodzielności (których poziom uznało za niewystarczający odpowiednio 37, 36 i 35 z 84 zarządzających DPS w Małopolsce). Jednocześnie kompetencje te były uznawane przez dyrektorów DPS jako ważne w pracy opiekuńczej – co więcej oceny te były wyższe od analogicznych ocen ze strony podmiotów świadczących usługi opiekuńcze w środowisku.

Duże znaczenie w kontekście niedopasowania kompetencyjnego wydaje się również mieć stosunkowo niska ocena poziomu kompetencji kadry opiekuńczej uznawanych przez dyrektorów DPS za kluczowe w zawodzie, w szczególności:

- nawiązywanie kontaktu i skuteczne komunikowanie się z klientami, które co trzeci DPS (33 na 84) określił jako niewystarczającą,

- znajomość zasad i standardów opieki nad osobą starszą, niesamodzielną, z niepełnosprawnościami, którą 31 z 84 DPS określiło jako zbyt niską, oraz
- udzielanie pierwszej pomocy, którą co trzeci DPS (29 z 84) uznał za kompetencję na zbyt niskim poziomie.

Otrzymane wyniki ujawniają różnice – w ocenie dyrektorów DPS – pomiędzy znaczeniem dla optymalnego wykonywania obowiązków zawodowych a faktycznym przygotowaniem kadr opiekuńczych w zakresie świadczenia opieki, w szczególności dla osób z demencją, komunikacji z mieszkańcami, oceny ich stanu i odpowiedniego wspierania sprawności, a także zarządzania własnymi emocjami w stresujących sytuacjach. W związku z tym istotne wydaje się wzmocnienie działań szkoleniowych ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy i kompetencji w tych obszarach.

Zarządzający DPS również zostali zapytani o to, jakie kompetencje opiekunów, inne niż wskazane w kwestionariuszu ankiety, są istotne. Badane DPS-y wskazały na empatię, cierpliwość, asertywność oraz zdolność szybkiego reagowania. Podmioty wskazały również m.in. na kluczowe znaczenie umiejętności komunikacji i współpracy w zespole.

Za najmniej kluczowe kompetencje w zawodzie opiekuna badane DPS-y uznały:

- komunikację międzykulturową i współpracę z cudzoziemcami,
- obsługę komputera i innych urządzeń elektronicznych (korzystanie z internetu, aplikacji mobilnych, spotkania online).

Wreszcie, **Zleceńbiorky** za najbardziej kluczowe kompetencje w zawodzie opiekuna (średnia ocena istotności równa 3 z 3) uznali:

- higienę i pielęgnację osób niesamodzielnych,
- nawiązywanie kontaktu i skuteczne komunikowanie się z klientami,
- znajomość zasad i standardów opieki nad osobą starszą, niesamodzielną, z niepełnosprawnościami,
- asystowanie w czynnościach dnia codziennego,

- radzenie sobie z własnymi emocjami.

Większość Zleceniobiorców oceniła poziom tych kompetencji u swoich pracowników jako odpowiedni. Wyjątek stanowiły dwie kompetencje:

- znajomość zasad i standardów opieki nad osobą starszą, niesamodzielną, z niepełnosprawnościami, którą co czwarty podmiot (4 na 16) określił jako niewystarczającą,
- radzenie sobie z własnymi emocjami, gdzie prawie połowa podmiotów (7 z 16) uznała za kompetencję na zbyt niskim poziomie.

Za najmniej kluczowe kompetencje w zawodzie opiekuna Zleceniobiorcy uznali:

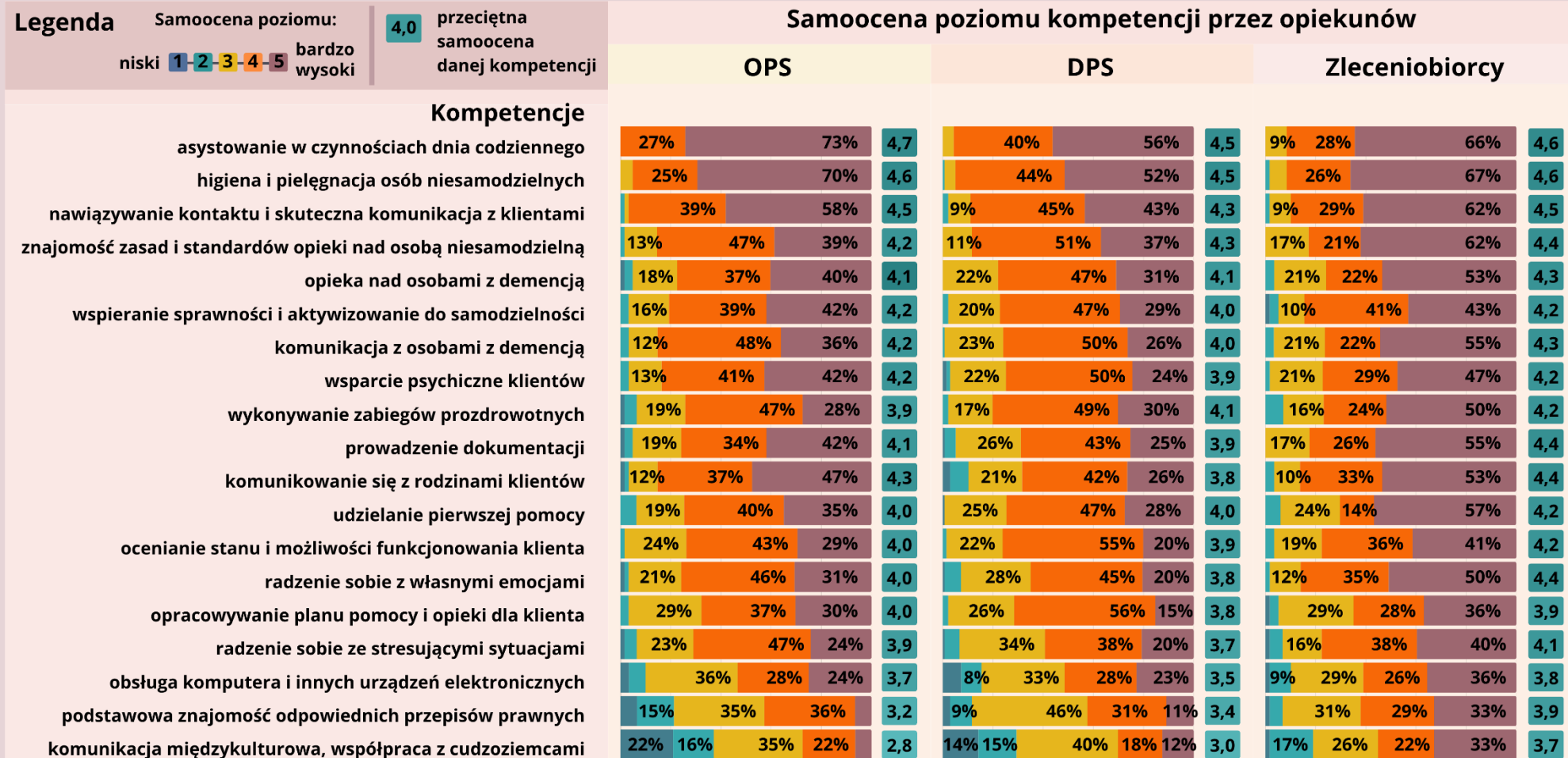
- komunikację międzykulturową i współpracę z cudzoziemcami,
- obsługę komputera i innych urządzeń elektronicznych (korzystanie z internetu, aplikacji mobilnych, spotkania online),
- podstawową znajomość odpowiednich przepisów prawnych (np. ustawy o pomocy społecznej).

Wykresy ilustrujące zależność między średnim poziomem zapotrzebowania na poszczególne kompetencje wymagane w zawodzie opiekuna a średnią oceną tych kompetencji wśród opiekunów znajdują się w aneksie do raportu.

W ocenach samych **opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS** najwyżej ocenianą kompetencją było asystowanie w czynnościach dnia codziennego – wszyscy badani (100%) ocenili ją na wysokim poziomie. Większość opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, oceniło jako wysoki lub bardzo wysoki poziom kompetencji w zakresie:

- nawiązywania kontaktu i skutecznego komunikowania się z klientami (97%), oraz
- higieny i pielęgnacji osób niesamodzielnych (95%).

Infografika 11. Samoocena poziomu kompetencji opiekunów zatrudnionych przez OPS/CUS, DPS oraz Zleceniobiorców



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

Najmniej opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS wysoko oceniło swoje kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej i współpracy z cudzoziemcami (28%), podstawowej znajomości odpowiednich przepisów prawnych (43%) oraz obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych (52%). Jednocześnie te kompetencje były uznawane przez osoby zarządzające OPS/CUS za najmniej kluczowe w zawodzie opiekuna.

Większość **opiekunów zatrudnionych w DPS** jako wysoki lub bardzo wysoki oceniło poziom kompetencji takich jak:

- asystowanie w czynnościach dnia codziennego (96%),
- higiena i pielęgnacja osób niesamodzielnych (96%),
- znajomość zasad i standardów opieki nad osobą starszą, niesamodzielną oraz z niepełnosprawnościami (88%),
- nawiązywanie kontaktu i skuteczne komunikowanie się z klientami (88%).

Co istotne, ocena przez opiekunów ostatnich dwóch z wyżej wymienionych kompetencji (znajomość zasad i standardów opieki oraz komunikowanie się z mieszkańcami) wskazuje na różnice między samooceną opiekunów a ocenami dokonanymi przez kadrę zarządzającą – nawet co trzeci dyrektor DPS (31 na 84) określił poziom tych kompetencji opiekunów jako niewystarczający. Wskazuje to na potencjalnie odmienne postrzeganie braków kompetencyjnych opiekunów zatrudnionych w DPS przez samych opiekunów oraz przez osoby zarządzające tymi jednostkami.

Jeżeli chodzi o najniżej oceniane kompetencje, najmniej opiekunów w DPS wysoko oceniło swoje kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej i współpracy z cudzoziemcami (30%), podstawowej znajomości odpowiednich przepisów prawnych (42%) oraz obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych (51%). Jednocześnie osoby zarządzające DPS uznali komunikację międzykulturową i współpracę z cudzoziemcami, a także obsługę komputera

i innych urządzeń elektronicznych za najmniej kluczowe kompetencje w zawodzie opiekuna.

Porównanie wyników samooceny opiekunów zatrudnionych w DPS z odpowiedziami udzielonymi przez dyrektorów tych placówek potwierdza, że przygotowanie kadry placówek do realizacji czynności higienicznych i pielęgnacyjnych było lepsze od przygotowania do realizacji zadań obejmujących planowanie wsparcia, ocenę stanu mieszkańców oraz aktywizowanie tych osób do samodzielności.

Wreszcie, większość opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców OPS/CUS jako wysoki lub bardzo wysoki oceniło poziom własnych kompetencji w zakresie:

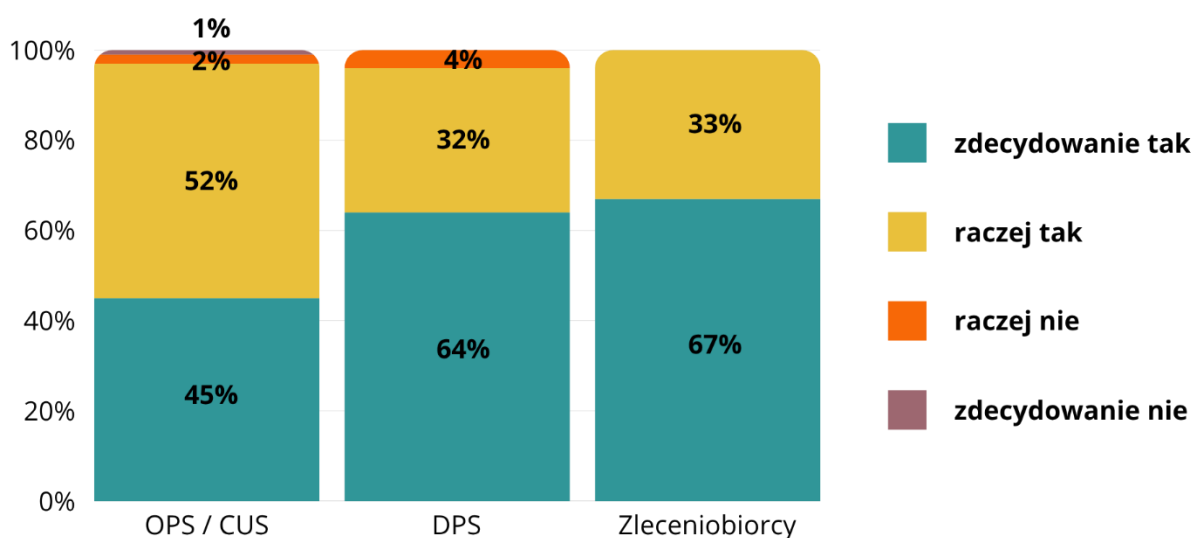
- higieny i pielęgnacji osób niesamodzielnych (93%),
- nawiązywania kontaktu i skutecznej komunikacji z klientami (91%),
- asystowania w czynnościach dnia codziennego (94%).
- komunikowania się z rodzinami klientów (86%),
- wspierania sprawności i aktywizowania klientów do samodzielności (84%),
- radzenia sobie z własnymi emocjami (85%) oraz
- prowadzenia dokumentacji (81%).

Najmniej **opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców** wysoko oceniło swoje kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej i współpracy z cudzoziemcami (55%), podstawowej znajomości odpowiednich przepisów prawnych (62%) oraz obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych (62%). Jednocześnie badani Zleceniobiorcy, podobnie jak pozostałe podmioty, uznali te trzy kompetencje za najmniej kluczowe w zawodzie opiekuna.

Zdecydowana większość opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS oraz DPS (96%) uważa, że obecne kompetencje pozwalają im na optymalne wykonywanie obowiązków zawodowych. Zdanie takie podzielali z kolei wszyscy opiekunowie zatrudnieni przez Zleceniobiorców. Jednocześnie odpowiedzi opiekunów z DPS

wskazują na dość wysoką skłonność do krytycznej samooceny kompetencji – co może mieć związek z wyższym poziomem wykształcenia i przygotowania kierunkowego tej grupy. Wśród pracowników DPS 33% uznało swoje kompetencje za częściowo wystarczające do optymalnego wykonywania obowiązków zawodowych, a 4% za niewystarczające.

Wykres 11. Na ile obecne kompetencje pozwalają na optymalne wykonywanie obowiązków w opinii opiekunów formalnych



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceńbiorky) = 60.

Szkolenia

Podmioty świadczące opiekę oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania zostały zapytane, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy opiekunowie w nich zatrudnieni uczestniczyli w jakichkolwiek kursach lub szkoleniach – z wyłączeniem tych z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej (Ppoż). Pytanie o udział w kursach lub szkoleniach w ostatnich 12 miesiącach zadano również opiekunom zatrudnionym w tych jednostkach.

W Małopolsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy w szkoleniach lub kursach innych niż obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej wzięło

udział tylko 28% opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, 62% opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców oraz 88% opiekunów zatrudnionych w DPS. Warto przy tym podkreślić, że to właśnie opiekunowie pracujący w OPS/CUS najrzadziej ze wszystkich grup uznawali swoje kompetencje za zdecydowanie wystarczające do optymalnego wykonywania obowiązków zawodowych – jedynie niecała połowa opiekunów w OPS/CUS (45%) była tego zdania, wobec 65% wśród opiekunów zatrudnionych w DPS i 67% opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców. Dane te akcentują potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na tę grupę opiekunów podczas planowania wsparcia szkoleniowego dla osób świadczących opiekę.

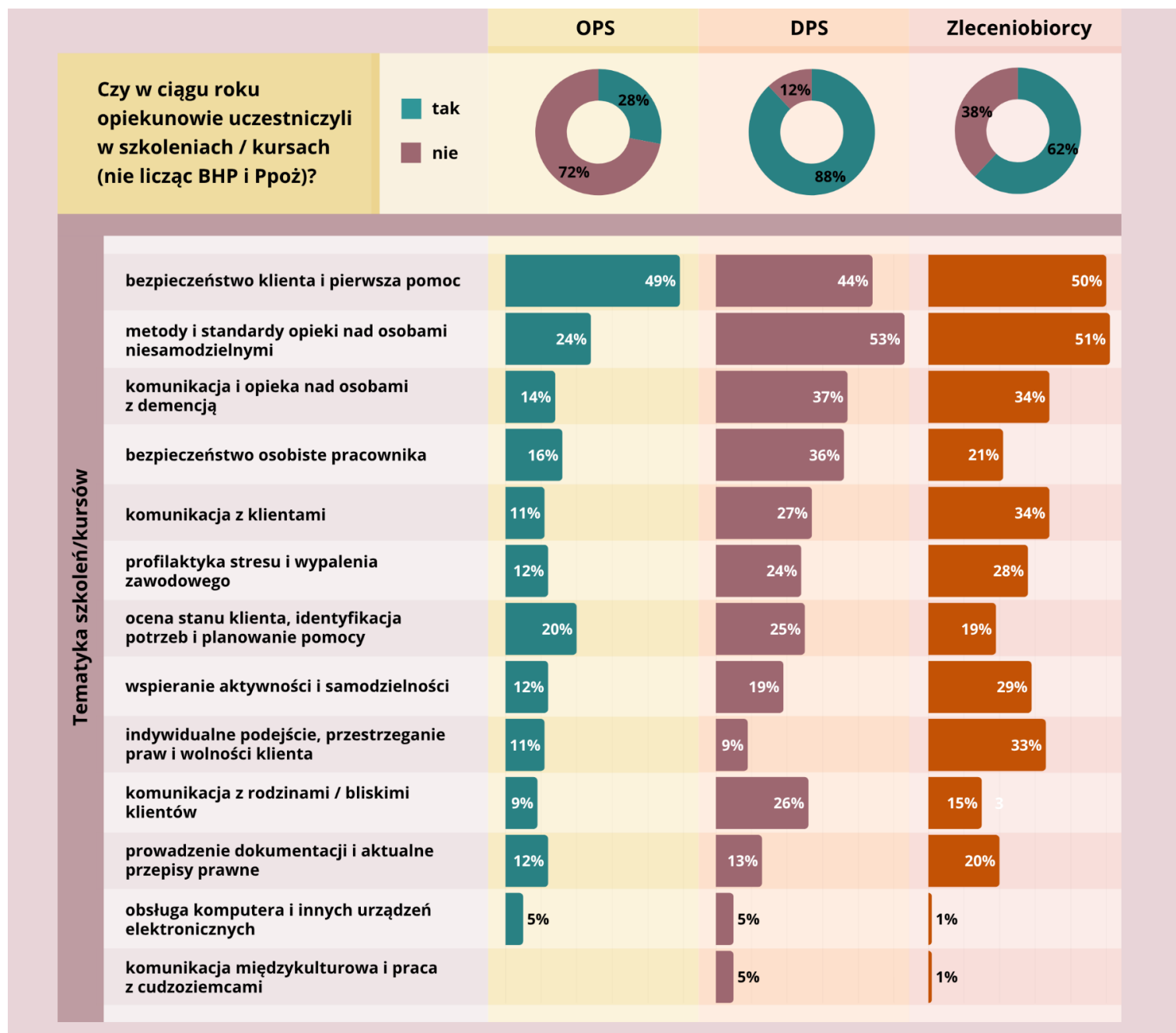
Szkolenia, w których brali udział opiekunowie formalni, najczęściej dotyczyły takich obszarów jak:

- bezpieczeństwo klienta i pierwsza pomoc (44% w DPS, 49% w OPS/CUS, 50% wśród Zleceniobiorców),
- metody i standardy opieki nad osobami niesamodzielnymi (24% w OPS/CUS, 51% wśród Zleceniobiorców, 53% w DPS),
- komunikacja i opieka nad osobami z demencją (14% w OPS/CUS, 34% wśród Zleceniobiorców, 37% w DPS).

Inne tematy stosunkowo często poruszane podczas szkoleń dla opiekunów to:

- bezpieczeństwo osobiste pracownika (16% w OPS/CUS, 21% wśród Zleceniobiorców, 36% w DPS),
- komunikacja z klientami (11% w OPS/CUS, 27% w DPS, 34% wśród Zleceniobiorców),
- profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego (12% w OPS/CUS, 24% w DPS, 28% wśród Zleceniobiorców),
- ocena stanu klienta, identyfikacja potrzeb i planowanie pomocy (19% wśród Zleceniobiorców, 20% w OPS/CUS, 25% w DPS).

Infografika 12. Szkolenia opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS



Grafika przedstawia średnią z odpowiedzi podmiotów oraz opiekunów - % podmiotów, które zorganizowały dane szkolenie oraz % opiekunów, którzy zadeklarowali udział w takim szkoleniu.

Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zleceniobiorcy) = 16; Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

Wśród najrzadziej poruszanych tematów szkoleń, w których brali udział opiekunowie formalni, były takie tematy jak:

- obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych (1% wśród Zleceniobiorców, 5% w OPS/CUS, 5% w DPS),
- komunikacja międzykulturowa i współpraca z cudzoziemcami (brak takich szkoleń OPS/CUS, 1% wśród Zleceniobiorców, 5% w DPS).

Warto zauważyć, że opiekunowie zatrudnieni w DPS częściej aniżeli opiekunowie wykonujący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania brali udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa osobistego pracownika (36% wobec 16% w OPS/CUS i 21% u Zleceniobiorców) oraz komunikacji z rodzinami lub bliskimi klientów (26% wobec 9% w OPS/CUS i 15% u Zleceniobiorców).

Wśród innych rodzajów szkoleń, w których brali udział opiekunowie w województwie małopolskim w ostatnich 12 miesiącach, osoby zarządzające podmiotami oraz sami opiekunowie wskazali profilaktykę i pielęgnację w opiece długoterminowej, cyberbezpieczeństwo, przeciwdziałanie przemocy, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, praca z osobą agresywną, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi oraz zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym.

Opiekunowie zatrudnieni w OPS/CUS najczęściej wskazywali, że uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę (wszyscy opiekunowie, którzy wzięli udział w szkoleniach, czyli 23% wszystkich opiekunów w OPS/CUS), natomiast część z nich brała również udział w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty (mniej więcej co czwarty opiekun uczestniczący w szkoleniach, 6% wszystkich opiekunów w OPS/CUS).

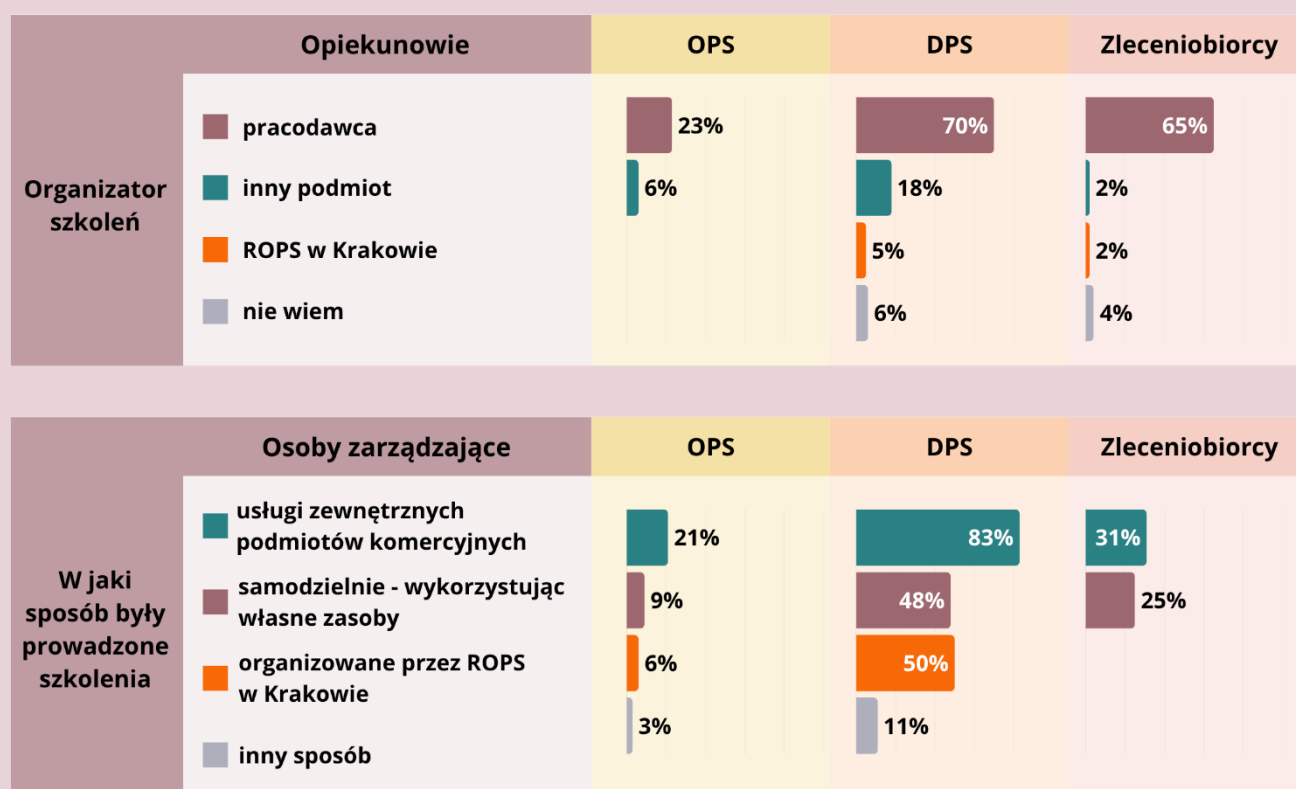
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku DPS oraz Zleceniobiorców – zdecydowana większość opiekunów w nich zatrudnionych wskazywała, że szkolenia były organizowane przez pracodawcę (70% wszystkich opiekunów w DPS oraz 65% opiekunów w podmiotach będących Zleceniobiorcami OPS/CUS).

Jednocześnie 18% opiekunów w DPS uczestniczących w szkoleniach wskazało, że szkolenia te były zorganizowane przez inny podmiot, a 5% – przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Wśród opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców, którzy wzięli udział w szkoleniach w ostatnich 12 miesiącach po 2% wskazało, że szkolenia te były zorganizowane przez inny podmiot oraz przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

6% opiekunów zatrudnionych w DPS i 4% opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców, którzy wzięli udział w szkoleniach w ostatnich 12 miesiącach, nie potrafiło wskazać, jaki podmiot był organizatorem tych szkoleń.

Infografika 13. Sposoby organizowania szkoleń oraz podmioty prowadzące szkolenia – z perspektywy opiekunów oraz osób zarządzających OPS/CUS, DPS oraz podmiotami realizującymi usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zleceniobiorcy) = 16; Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

Z kolei osoby zarządzające podmiotami świadczącymi opiekę najczęściej deklarowały realizację szkoleń poprzez korzystanie z usług zewnętrznych podmiotów komercyjnych prowadzących szkolenia (21% OPS/CUS, 31% Zleceniobiorców oraz 83% DPS).

Mniej podmiotów prowadziło szkolenia samodzielnie wykorzystując własne materiały i zasoby kadrowe (9% OPS/CUS, 25% Zleceniobiorców oraz 48% DPS) lub korzystało ze szkoleń organizowanych przez ROPS w Krakowie (6% OPS/CUS, 50% DPS oraz żaden ze Zleceniobiorców).

Inne sposoby realizacji szkoleń (stosowane przez 3% OPS/CUS oraz 11% DPS) obejmowały działania prowadzone m.in. we współpracy z różnymi jednostkami, w tym organizacjami pozarządowymi.

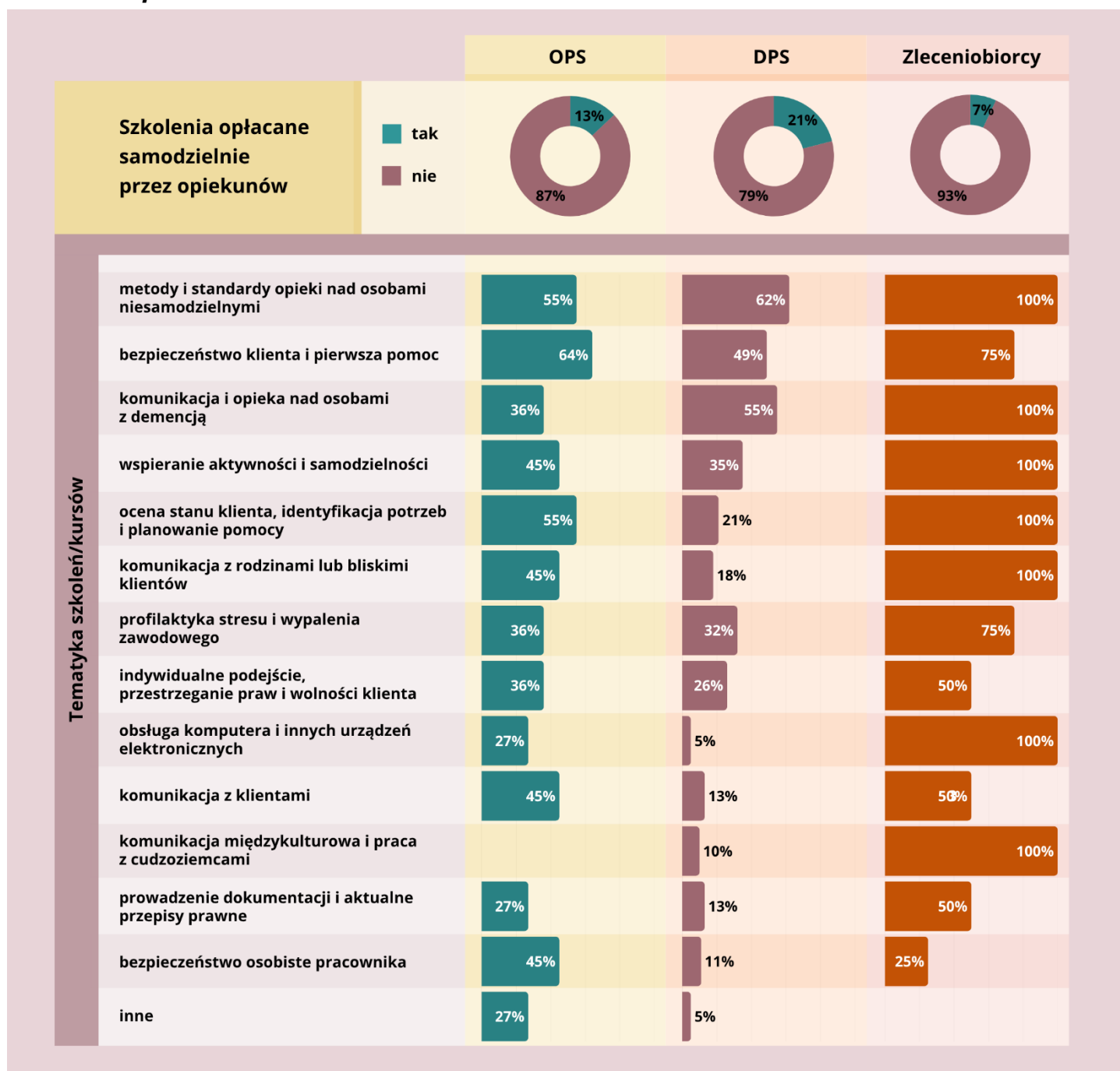
Zestawienie odpowiedzi opiekunów oraz osób zarządzających podmiotami na pytanie dotyczące organizacji szkoleń pokazuje, że świadomość organizacji i prowadzenia szkoleń przez podmioty zewnętrzne, w tym przez ROPS w Krakowie była stosunkowo niska wśród opiekunów formalnych w Małopolsce. Podkreśla to znaczenie skutecznej komunikacji pomiędzy osobami zarządzającymi jednostkami a kadrą opiekuńczą w zakresie informowania opiekunów o możliwościach udziału w szkoleniach. Jednocześnie wskazuje na potrzebę rozwijania i poszerzania oferty szkoleniowej dedykowanej tej grupie zawodowej, ponieważ dostępność takich szkoleń pozostaje ograniczona.

Szkolenia opłacane samodzielnie

W województwie małopolskim w sumie co dziesiąty opiekun zatrudniony w OPS/CUS brał udział w szkoleniach opłacanych samodzielnie (13%). Tematyka szkoleń opłacanych samodzielnie najczęściej dotyczyła bezpieczeństwa klienta i pierwszej pomocy (64%), metod i standardów opieki nad osobami niesamodzielnymi (55%) oraz oceny stanu klienta, identyfikacji potrzeb

i planowania pomocy (również 55%). Wśród innych (27%) typów szkoleń opłacanych samodzielnie opiekunowie wskazali również na profilaktykę i pielęgnację w opiece długoterminowej oraz choroby przewlekłe osób starszych.

Infografika 14. Szkolenia opłacane samodzielnie przez opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

W sumie co piąty opiekun zatrudniony w DPS brał udział w szkoleniach opłacanych samodzielnie (21%). Tematyka szkoleń opłacanych samodzielnie najczęściej dotyczyła metod i standardów opieki nad osobami niesamodzielnymi (62%), komunikacji i opieki nad osobami z demencją (55%) oraz bezpieczeństwa klienta i pierwszej pomocy (49%). Wśród innych (5%) typów szkoleń opłacanych samodzielnie opiekunowie wskazali na fizjoterapie i rozwój osobisty.

Jedynie niewielki odsetek opiekunów wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zatrudnionych przez Zleceniobiorców, uczestniczył w szkoleniach finansowanych samodzielnie (7%). Tematyka szkoleń opłacanych samodzielnie u wszystkich (100%) dotyczyła metod i standardów opieki nad osobami niesamodzielnymi; komunikacji i opieki nad osobami z demencją; oceny stanu klienta, identyfikacji potrzeb i planowania pomocy; komunikacji z rodzinami lub bliskimi klientów; wspierania aktywności i samodzielności; obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych oraz komunikacji międzykulturowej i pracy z cudzoziemcami.

Najbardziej przydatne formy doskonalenia zawodowego

Wskazując na najbardziej przydatne formy doskonalenia zawodowego, większość opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS wymieniła kursy i szkolenia (76%).

Zdecydowanie mniej respondentów wskazało supervizję (16%), natomiast co piąty badany zadeklarował, że nie potrzebuje żadnej formy doskonalenia zawodowego (22%).

Wśród innych form podnoszenia kwalifikacji w polu zainteresowania ankietowanych opiekunów w Małopolsce znalazły się wizyty studyjne (6%), głównie dotyczące zagadnień z zakresu psychologii oraz nowych standardów opieki, studia podyplomowe (5%) w zakresie wiedzy medycznej, obejmującej m.in. leczenie odleżyn czy pobieranie krwi oraz związanych z kompetencjami

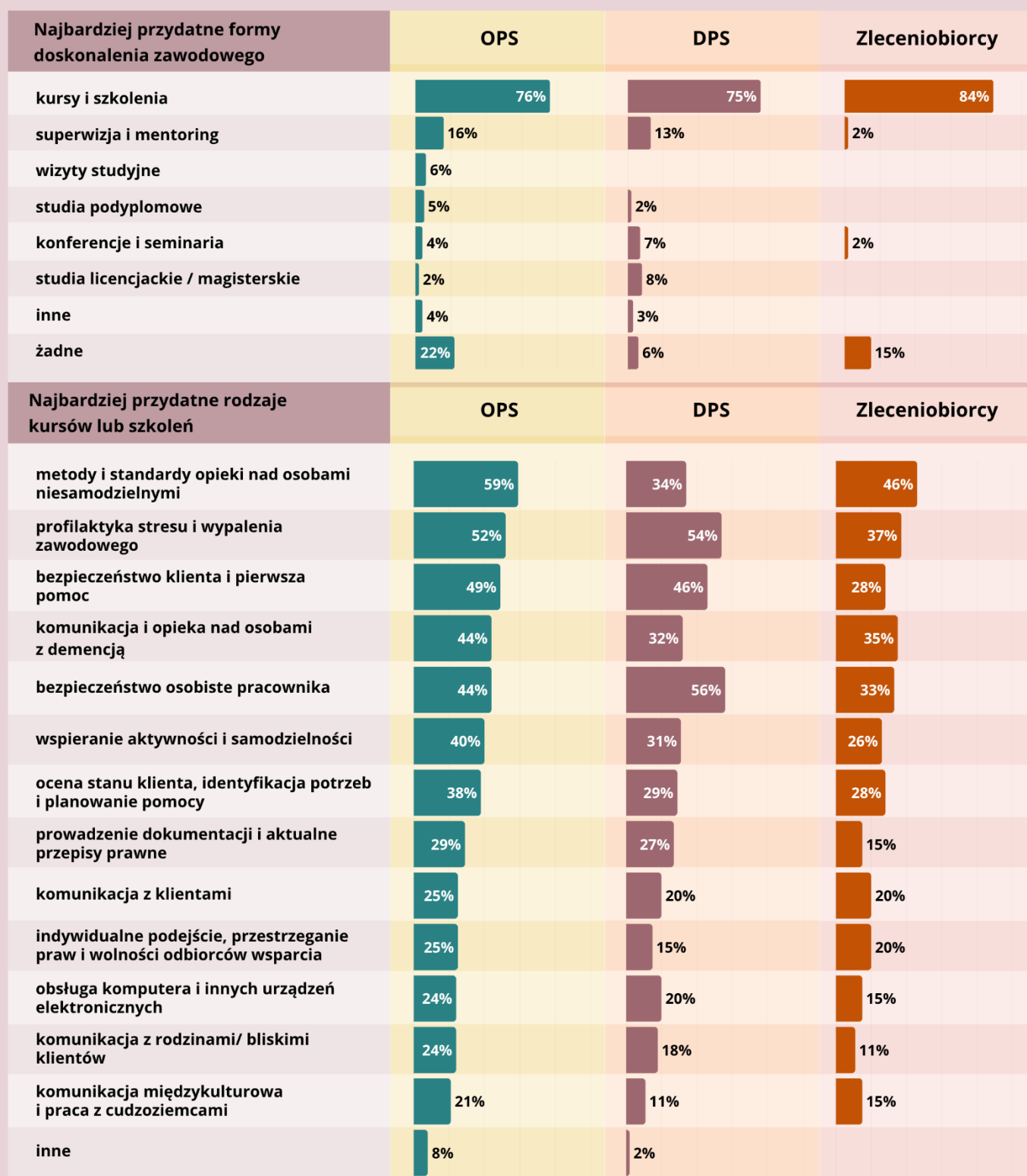
opiekuna osób starszych, konferencje (4%) dotyczące pracy opiekuna oraz studia licencjackie lub magisterskie (2%) w dziedzinie pielęgniarstwa. W kategorii „inne” (4%) opiekunowie wymieniali m.in. szkolenia i wsparcie ze strony specjalistów, w tym lekarzy i pielęgniarek, dostęp do książek i publikacji branżowych, a także potrzebę organizowania kursów w miejscu pracy, w godzinach popołudniowych. Ponad połowa opiekunów, zatrudnionych w OPS/CUS, za najbardziej przydatne tematy kursów lub szkoleń uznała metody i standardy opieki nad osobami niesamodzielnymi (59%) oraz profilaktykę stresu i wypalenia zawodowego (52%). Nieco mniej respondentów wskazało na tematykę dotyczącą bezpieczeństwa klienta i pierwszej pomocy (49%), komunikacji i opieki nad osobami z demencją (44%) oraz bezpieczeństwa osobistego pracownika (również 44%). Wśród innych (8%) najbardziej przydatnych tematów kursów zostały wskazane również szkolenia medyczne i praktyczne, dotyczące chorób osób starszych, a także kompetencji komunikacyjnych i kulturowych.

Wskazując na najbardziej przydatne formy doskonalenia zawodowego, większość opiekunów formalnych w DPS wskazała kursy i szkolenia (75%). Zdecydowanie mniej respondentów wskazało superwizję (13%).

Wśród innych form podnoszenia kwalifikacji opiekunowie w DPS wskazywali na studia licencjackie lub magisterskie (8%) w dziedzinie pielęgniarstwa, konferencje (7%) dotyczące kodeksu pracy i opieki nad osobami starszymi oraz studia podyplomowe (2%) w zakresie spektrum autyzmu i opieki nad osobami z niepełnosprawnościami. W kategorii „inne” (3%) opiekunowie wymieniali m.in. szkoły policealne, dotyczące zawodu opiekuna medycznego.

Ponad połowa opiekunów zatrudnionych w DPS za najbardziej przydatne tematy szkoleń uznała bezpieczeństwo osobiste pracownika (56%) oraz profilaktykę stresu i wypalenia zawodowego (54%). Nieco mniej respondentów wskazało na tematykę dotyczącą bezpieczeństwa klienta i pierwszej pomocy (46%).

Infografika 15. Najbardziej przydatne formy doskonalenia zawodowego według opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

Wśród innych (2%) najbardziej przydatnych tematów kursów zostały wskazane szkolenia w zakresie fizjoterapii, integracji sensorycznej oraz opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

Wskazując na najbardziej przydatne formy doskonalenia zawodowego, większość opiekunów wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania zatrudnionych przez Zleceniobiorców wskazała kursy i szkolenia (84%). 15% respondentów wskazało, że nie potrzebuje żadnej formy doskonalenia. Jedynie pojedynczy opiekunowie wskazali na superwizję oraz konferencję (po 2%).

Najwięcej opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców za najbardziej przydatne tematy szkoleń uznało metody i standardy opieki nad osobami niesamodzielnymi (46%). Nieco mniej opiekunów wskazało na profilaktykę stresu i wypalenia zawodowego (37%) oraz bezpieczeństwo osobiste pracownika (33%).

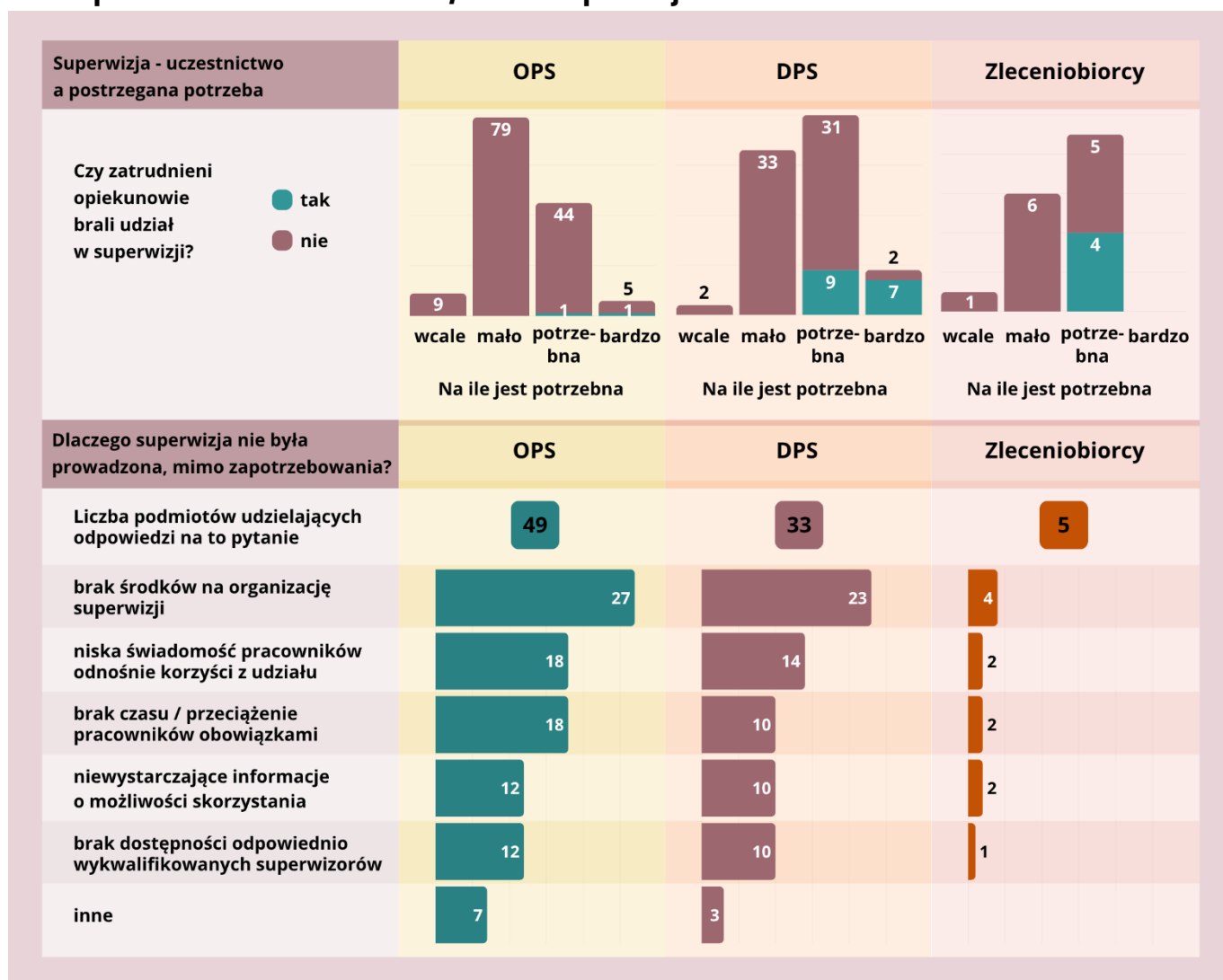
Superwizja

Kolejnym badanym zagadnieniem był udział opiekunów w województwie małopolskim w superwizji. W zdecydowanej większości badanych OPS/CUS (137 na 139) pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie brali udziału w spotkaniach superwizyjnych. W sumie mniej niż połowa jednostek (51 na 139) uważała, że superwizja jest potrzebna lub bardzo potrzebna, jednak tylko opiekunowie zatrudnieni w dwóch z nich brali w ciągu ostatniego roku udział w superwizji. Te jednostki, które uważały, że superwizja jest potrzebna, ale jednocześnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich pracownicy nie brali w niej udziału (49) zostali zapytani o przyczyny. Najwięcej z zapytanych wskazało na brak środków na organizację superwizji (27), nieco mniej na brak czasu lub przeciążenie pracowników obowiązkami zawodowymi (18) oraz na niską świadomość pracowników odnośnie korzyści płynących z udziału w superwizji (18). Po 12 jednostek

wskazało na niewystarczające informacje o możliwości skorzystania z superwizji oraz brak dostępności odpowiednio wykwalifikowanych superwizorów.

7 jednostek wskazało inne przyczyny, w tym problemy organizacyjne lub formalne (m.in. forma umowy pracowników).

Infografika 16. Wyowiedzi podmiotów dotyczące udziału opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS w superwizji



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zleceniobiorcy) = 16.

W zdecydowanej większości badanych DPS (68 na 84) opiekunowie nie brali udziału w spotkaniach superwizyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W sumie prawie 60% dyrektorów DPS (49 na 84) uważało, że superwizja jest potrzebna

lub bardzo potrzebna, jednak tylko opiekunowie zatrudnieni w 16 małopolskich DPS wzięli w ciągu roku udział w superwizji. Te jednostki, które uważają, że superwizja jest potrzebna, ale jednocześnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich pracownicy nie brali w niej udziału (33 DPS) zostali zapytani o przyczyny. Najwięcej z nich wskazało na brak środków na organizację superwizji (23). Nieco mniej wskazało na niską świadomość pracowników odnośnie korzyści płynących z udziału w superwizji (14), a także na brak czasu lub przeciążenie pracowników obowiązkami zawodowymi (10), brak dostępności odpowiednio wykwalifikowanych superwizorów (10) oraz niewystarczające informacje o możliwości skorzystania z superwizji (10). W sumie 3 podmioty wskazały na inną przyczynę, w tym brak chęci ze strony pracowników.

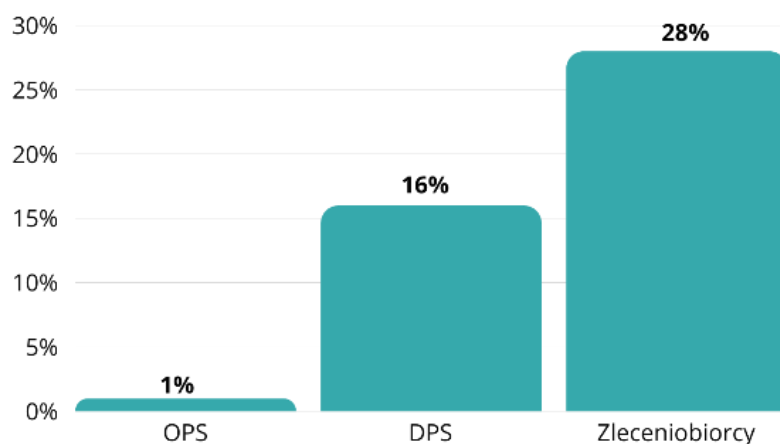
W zdecydowanej większości badanych Zleceniobiorców (12 na 16) pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie brali udziału w spotkaniach superwizyjnych. W sumie nieco ponad połowa jednostek (9 na 16) uważała, że superwizja jest potrzebna, a tylko pracownicy 4 z nich w ciągu roku brali udział w superwizji. Te jednostki, które uważały, że superwizja jest potrzebna, ale jednocześnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich pracownicy nie brali w niej udziału (5) zostali zapytani o przyczyny. Najwięcej z nich wskazało na brak środków na organizację superwizji (4). Po dwa podmioty wskazały na brak czasu lub przeciążenie pracowników obowiązkami zawodowymi, niską świadomość korzyści płynących z udziału w superwizji wśród opiekunów lub niewystarczające informacje o możliwości skorzystania z superwizji. Jeden Zleceniobiorca wskazał na brak dostępności odpowiednio wykwalifikowanych superwizorów.

Prawie żaden opiekun zatrudniony w OPS/CUS (99%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie uczestniczył w spotkaniach superwizyjnych. Uzyskane wyniki były spójne z odpowiedziami przedstawicieli badanych podmiotów, którzy w zdecydowanej większości (99%) wskazywali, że pracownicy wykonujący

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystali ze spotkań superwizyjnych.

Również wśród opiekunów zatrudnionych w DPS zdecydowana większość (84%), w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie uczestniczyła w spotkaniach superwizyjnych. Jedynie 16% badanych wzięło udział w superwizji. Uzyskane wyniki były spójne z odpowiedziami przedstawicieli badanych podmiotów, którzy w większości (81%) wskazywali, że opiekunowie pracujący w DPS w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystali ze spotkań superwizyjnych.

Wykres 12. Udział opiekunów w superwizji w ciągu ostatnich 12 miesięcy



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

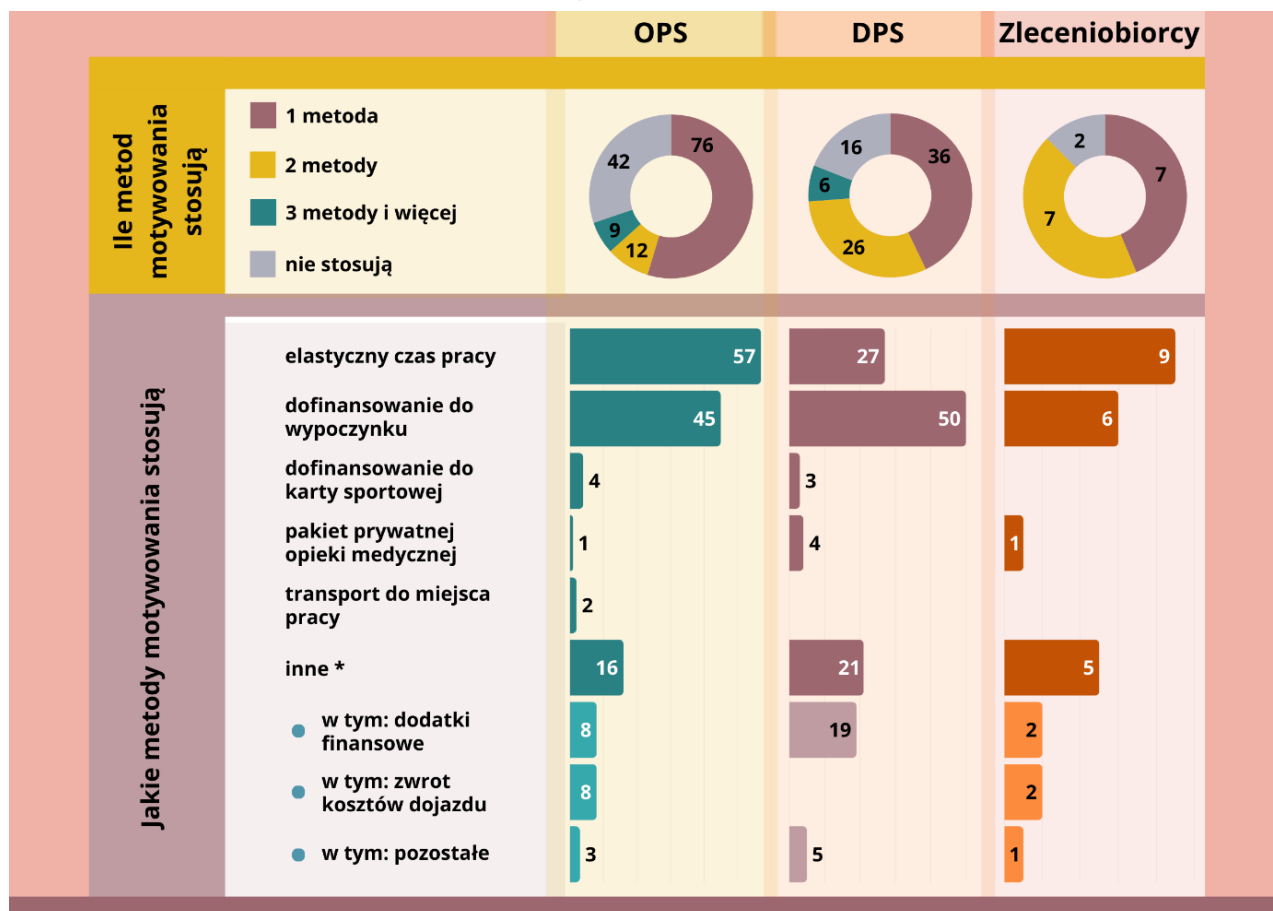
Prawie wszyscy opiekunowie wykonujący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania zatrudnieni przez Zleceniobiorców (72%), w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie uczestniczyli w spotkaniach

superwizyjnych. Uzyskane wyniki były spójne z odpowiedziami przedstawicieli badanych podmiotów, którzy w zdecydowanej większości (75%) wskazywali, że pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystali ze spotkań superwizyjnych.

Sposoby motywowania pracowników

Badane podmioty w województwie małopolskim zostały zapytane o to, czy stosują jakieś dodatkowe sposoby motywowania osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub opiekunów w DPS. Większość z nich zadeklarowała stosowanie przynajmniej jednej formy motywowania opiekunów. Jednocześnie część jednostek (2 Zleceniobiorców, 16 DPS oraz 42 OPS/CUS) wskazała, że nie stosuje żadnych form motywowania kadry opiekuńczej.

Infografika 17. Metody motywowania pracowników stosowane przez OPS/CUS, DPS oraz podmioty realizujące usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zleceniobiorcy) = 16.

* Liczba odpowiedzi w podkategoriach „w tym” nie sumuje się do wartości kategorii „inne”. Podkategorie powstały na podstawie otwartych odpowiedzi respondentów – część z nich wskazała więcej niż jedną metodę, dlatego suma podkategorii może przekraczać liczbę wskazań „inne”.

Infografika 17 prezentuje liczbę oraz rodzaje metod motywowania pracowników stosowane przez poszczególne podmioty. Odpowiedzi w kategorii „inne” zostały podzielone na osobne podkategorie („w tym”), które zostały pogrupowane na podstawie otwartych odpowiedzi respondentów.

Wskazując metody motywowania pracowników 76 przedstawicieli OPS/CUS wskazało na 1 metodę, 12 – 2 metody, a 9 – co najmniej 3 metody. Spośród stosowanych metod najczęściej OPS/CUS wskazało na elastyczny czas pracy (57), czyli możliwość dopasowania godzin pracy do potrzeb pracownika, dofinansowanie do wypoczynku (45) oraz inne metody (16). Wśród innych sposobów motywowania opiekunów formalnych, najczęściej wymieniano metody związane z zastosowaniem dodatków finansowych (8 podmiotów), takich jak nagrody, premie oraz świadczenia z funduszu socjalnego. Tyle samo OPS/CUS (8) oferowało zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – w wielu przypadkach w formie ryczałtu, czyli ustalonej z góry kwoty wypłacanej pracownikowi, która nie wymaga szczegółowego rozliczenia poniesionych kosztów. W sumie 3 OPS/CUS wskazało na dbałość o atmosferę w miejscu pracy jako metodę motywowania opiekunów, której przejawem było m.in. organizowanie spotkań okolicznościowych oraz elastyczne podejście do potrzeb pracowników w codziennej pracy.

Wśród osób zarządzających DPS 1 metodę wskazali dyrektorzy 36 jednostek, 2 metody – 26 jednostek, a co najmniej 3 metody – 6 jednostek. Wśród najczęściej stosowanych sposobów motywowania opiekunów w DPS były: dofinansowanie do wypoczynku (50), elastyczny czas pracy (27) oraz inne metody (21). Prawie wszystkie DPS-y, które stosowały inne metody motywowania pracowników, wskazały na dodatki finansowe (19 odpowiedzi), w tym premie, nagrody oraz dofinansowania do wypoczynku. Wśród pozostałych odpowiedzi w kategorii inne (5), dwa podmioty wskazały na metody związane z rozwojem zawodowym pracowników, takie jak możliwość awansu czy ocena pracownicza uwzględniająca

zarówno mocne strony pracownika, jak i obszary wymagające dalszego rozwoju. Niewiele podmiotów wskazało również na kwestie związane z zapewnieniem lepszych warunków pracy przez wprowadzenie technologii ułatwiających pracę (2 odpowiedzi) oraz dbałość o atmosferę w miejscu pracy (1 odpowiedź), realizowane m.in. poprzez organizowanie spotkań integrujących zespół.

Wśród Zleceniobiorców zarówno 1 metodę, jak i 2 metody wskazało po 7 podmiotów. Najczęściej stosowany był elastyczny czas pracy (9), dofinansowanie do wypoczynku (6) oraz inne metody (5) – w tym dodatki finansowe dla pracowników, takie jak premie i nagrody (2 odpowiedzi), czy też całkowity lub częściowy zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy (2 odpowiedzi).

Wyzwania podmiotów świadczących opiekę

Wyzwania związane z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

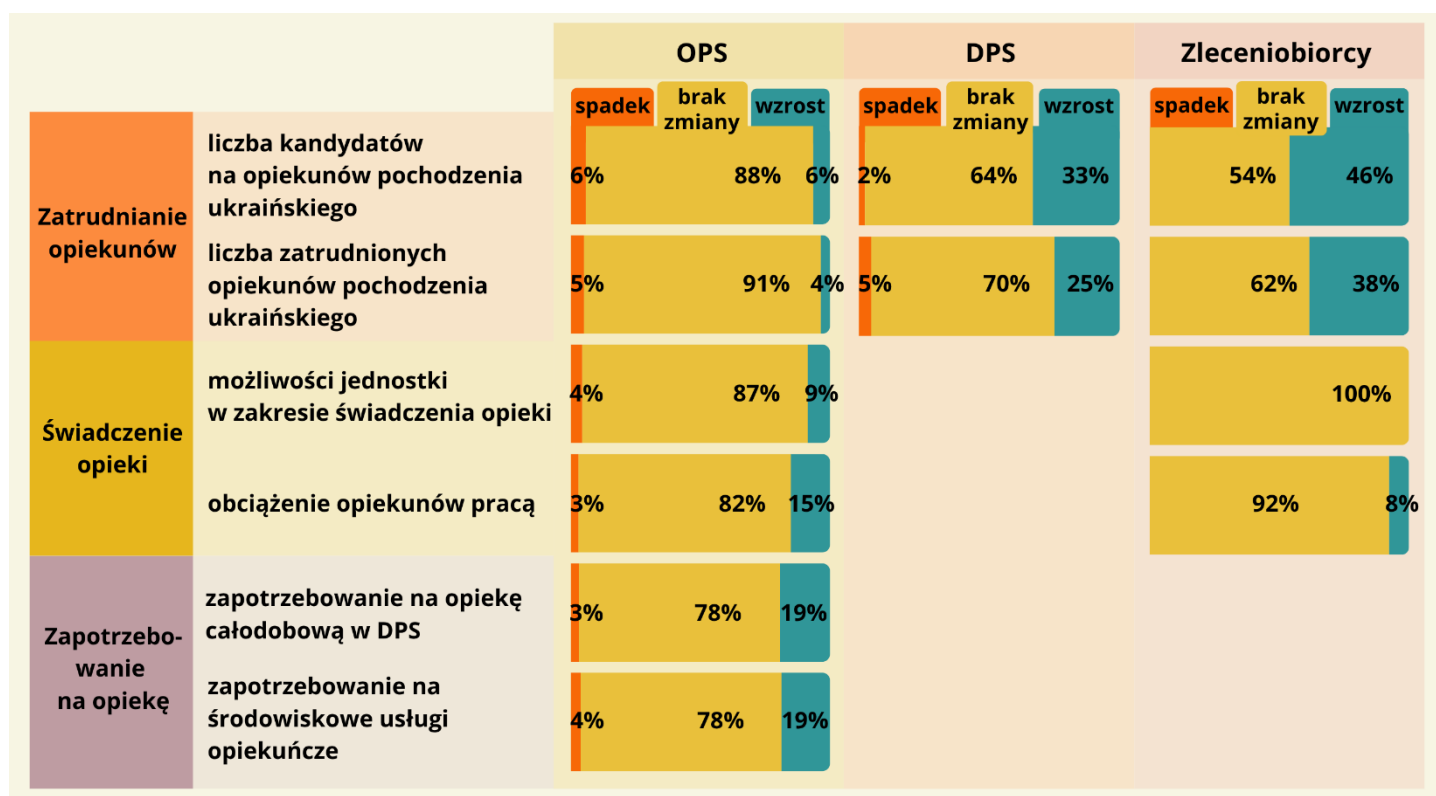
Konflikt zbrojny w Ukrainie, trwający od 2022 r., nie wpłynął w istotny sposób na skalę zaangażowania osób z Ukrainy świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w OPS/CUS w Małopolsce. W większości z nich (88%) zmianie nie uległa liczba kandydatów na opiekunów formalnych pochodzenia ukraińskiego w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie. W 6% OPS/CUS odnotowano wzrost, a w kolejnych 6% spadek liczby kandydatów na opiekunów formalnych pochodzenia ukraińskiego. W przeważającej części OPS/CUS (91%) nie zmieniła się również liczba zatrudnionych opiekunów pochodzenia ukraińskiego. W 4% OPS/CUS odnotowano wzrost, a w 5% OPS/CUS spadek liczby zatrudnionych opiekunów pochodzenia ukraińskiego.

Wzrost kandydatów na opiekunów, jak również zatrudnionych na tym stanowisku osób pochodzenia ukraińskiego, odnotowały za to domy pomocy społecznej oraz podmioty realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS. Co trzeci DPS (33%) zauważył wzrost kandydatów na opiekunów pochodzenia ukraińskiego w związku z konfliktem zbrojnym na, a co czwarty (25%) – wzrost liczby zatrudnionych opiekunów z Ukrainy. Spadek w tym zakresie odnotowało odpowiednio 2% oraz 5% DPS.

Największy wzrost zasobów kadr opiekuńczych pochodzenia ukraińskiego odnotowali niepubliczni Zleceniobiorcy. Niemal połowa z nich (6 na 13) wskazała, że w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie wzrosła liczba kandydatów na opiekunów pochodzenia ukraińskiego, a 5 na 13 – że przybyło również pracowników pochodzenia ukraińskiego świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Żaden podmiot nie odnotował spadku w tym zakresie.

W wyniku napływu ludności ukraińskiej wzrosło również zapotrzebowanie na opiekę oraz obciążenie opiekunów pracą. W co szóstym OPS/CUS (15%) wzrosło obciążenie opiekunów pracą, a tylko 3% jednostek zadeklarowało spadek. Mniej więcej co piąty OPS/CUS (19%) odnotował wzrost zapotrzebowania zarówno na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, jak również na opiekę stacjonarną w DPS na swoim terenie (odpowiednio 3% i 4% OPS/CUS zadeklarowało spadek zapotrzebowania w tym zakresie).

Infografika 18. Zmiany związane ze świadczeniem opieki przez OPS/CUS, DPS oraz Zleceńbiorców



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zleceńbiorców) = 16.

W większości OPS/CUS (87%) możliwości jednostki w zakresie świadczenia opieki w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie²⁴ nie uległy zmianie, u 9% OPS/CUS zwiększyła się ta możliwość, a w przypadku 4% uległa spadkowi.

²⁴ Uzyskane wyniki świadczą o tym, że przez respondentów to sformułowanie prawdopodobnie mogło być rozumiane na dwa sposoby: jako zwiększenie zdolności zabezpieczenia usług opiekuńczych w wymiarze i zakresie odpowiednim do zapotrzebowania (przykładowo ze względu na większą liczbę kandydatów do pracy

Również wszyscy Zleceniobiorcy wskazali, że możliwości jednostki w zakresie świadczenia opieki nie uległy zmianie. W zadecydowanej większości (92%) nie zmieniło się również obciążenie opiekunów pracą, natomiast wzrosło ono u 8% Zleceniobiorców.

Osoby zarządzające badanymi podmiotami w Małopolsce miały również możliwość wskazania innych wyzwań i zmian, które napotkały w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Wśród najczęstszych wyzwań (11 wskazań) były trudności w komunikacji ze względu na niski poziom znajomości języka polskiego przez część osób pochodzących z Ukrainy (występujące zarówno w roli opiekunów, jak i klientów) oraz różnice kulturowe, które wpływały na sposób świadczenia opieki. Inne wyzwania wymieniane przez osoby zarządzające to: praca osób z Ukrainy poza systemem (w szarej strefie) wykonywana za niższe stawki, problemy finansowe podmiotów związane ze wzrostem kosztów, zmniejszenie zainteresowania zawodem oraz odejścia z pracy opiekunów, wzrost liczby osób wymagających wsparcia, czy też niechęć niektórych klientów do obcokrajowców, w tym osób z Ukrainy.

Wyzwania związane z pandemią COVID-19

Wśród wyzwań opiekuńczych podczas pandemii COVID-19 najwięcej OPS/CUS w województwie małopolskim mierzyło się z trudnościami w świadczeniu opieki ze względu na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne (68%), większym stresem i wypaleniem zawodowym opiekunów (58%) oraz zwiększonymi kosztami prowadzenia jednostki (17%). Najczęstsze wyzwania po pandemii jakie trwają do tej pory to większy stres i wypalenie zawodowe opiekunów (u 18%) oraz

jako opiekun), jak również jako wzrost liczby sytuacji, w których jednostka miała możliwość zaproponowania mieszkańcom tej formy wsparcia ze względu na napływ osób z Ukrainy, spośród których część mogła wymagać tego rodzaju wsparcia.

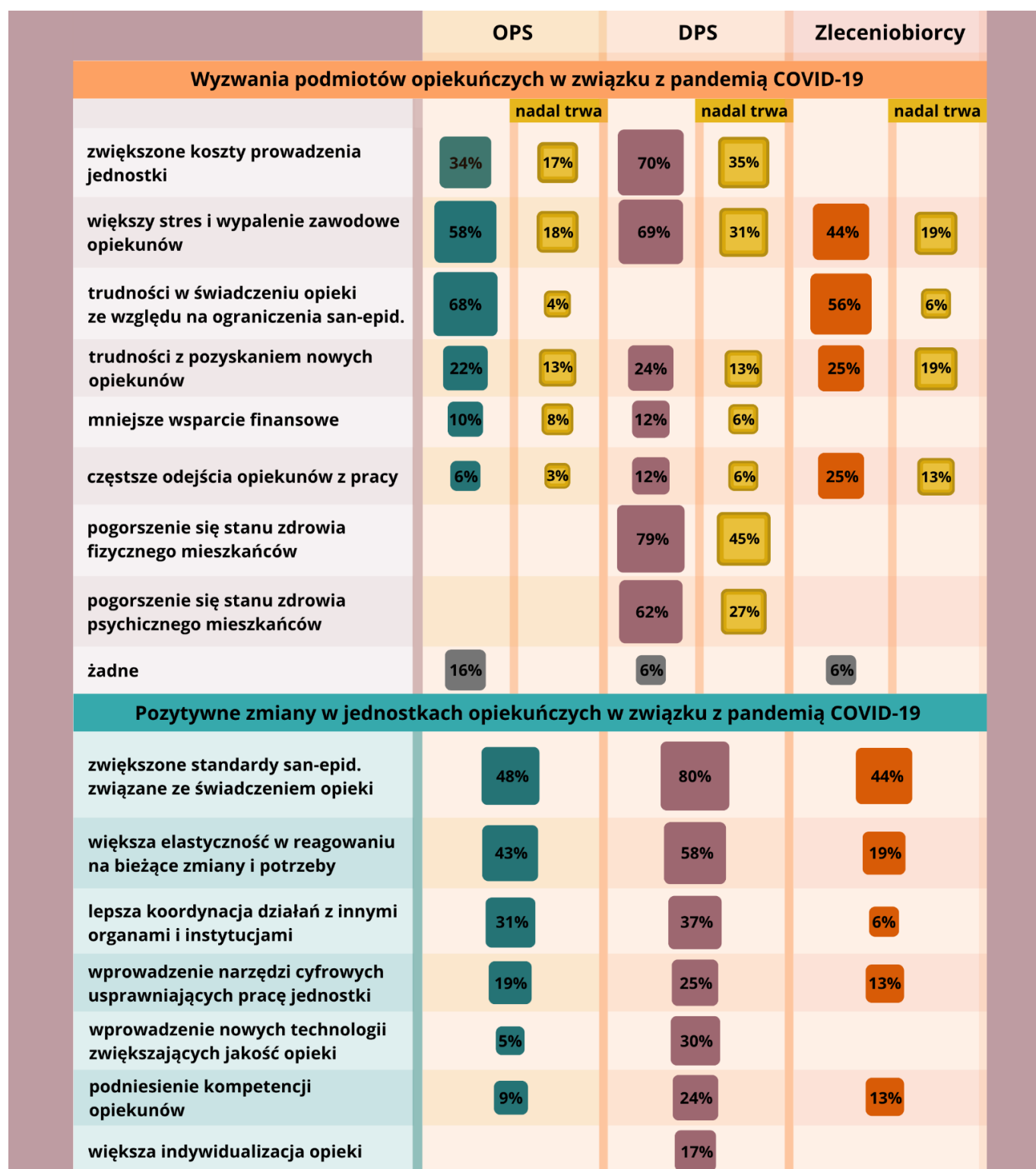
zwiększone koszty prowadzenia jednostki (u 17%). Tylko 16% nie wskazało na żadne wyzwania w związku z pandemią COVID-19.

Osoby zarządzające DPS jako największe wyzwania związane z pandemią COVID-19 wskazały pogorszenie się stanu zdrowia fizycznego mieszkańców (79%), jak również ich zdrowia psychicznego (62%), zwiększone koszty prowadzenia domu (70%) oraz większy stres i wypalenie zawodowe opiekunów (69%). Około połowa osób zarządzających, które zidentyfikowały te problemy, wskazała, że nadal wywierają one wpływ na funkcjonowanie jednostki.

W odpowiedziach Zleceniobiorców największym wyzwaniem, które się pojawiło w związku z pandemią, były – podobnie jak w przypadku OPS/CUS – trudności w świadczeniu usług ze względu na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne (56% wskazań), a w dalszej kolejności – większy stres i wypalenie zawodowe opiekunów (44% wskazań). Co czwarty podmiot wskazał, że w związku z pandemią COVID-19 mierzył się z częstszymi odejściami opiekunów z pracy oraz miał trudności z pozyskaniem nowych pracowników do pełnienia tej roli. Co piąty podmiot wskazał, że wyzwania związane z większym stresem i wypaleniem zawodowym opiekunów oraz z rekrutacją nowych pracowników nadal występują pomimo zakończenia pandemii.

Osoby zarządzające badanymi jednostkami miały również możliwość wskazania dodatkowych problemów spoza listy, które wystąpiły w związku z pandemią COVID-19. Wśród udzielonych odpowiedzi były: problemy kadrowe z uwagi na kwarantannę lub chorobę pracowników (3 podmioty), utrudniona współpraca z innymi instytucjami (2 podmioty), lęk klientów przed kontaktem z opiekunami w obawie przed zakażeniem (1 podmiot), a także obostrzenia organizacyjne wpływające na funkcjonowanie jednostki (1 podmiot).

Infografika 19. Zmiany w funkcjonowaniu OPS/CUS, DPS oraz Zleceńbiorców w związku z pandemią COVID-19



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zleceńbiorczy) = 16.

Wśród pozytywnych zmian w jednostkach opiekuńczych w Małopolsce w wyniku pandemii COVID-19 osoby zarządzające badanymi jednostkami najczęściej wskazywały na zwiększone standardy sanitarno-epidemiologiczne związane ze świadczeniem opieki (44% Zleceniobiorców, 48% OPS/CUS, 80% DPS), większą elastyczność w reagowaniu na bieżące zmiany i potrzeby (19% Zleceniobiorców, 43% OPS/CUS, 58% DPS) oraz wprowadzenie narzędzi cyfrowych usprawniających pracę jednostki (13% Zleceniobiorców, 19% OPS/CUS, 25% DPS). Dodatkowo osoby zarządzające OPS/CUS oraz DPS wśród pozytywnych zmian wymieniły lepszą koordynację działań z innymi organami i instytucjami (31% OPS/CUS, 37% DPS), a Zleceniobiorcy – podniesienie poziomu kompetencji opiekunów (13%).

Dodatkowo, osoby zarządzające podmiotami mogły wymienić inne pozytywne zmiany, które zaszły w związku z pandemią COVID-19. Udzielone przez 3 podmioty odpowiedzi wskazywały na usprawnienie zdalnej obsługi interesantów, wzmocnienie procedur bezpieczeństwa sanitarnego oraz polepszenie komunikacji w zespole.

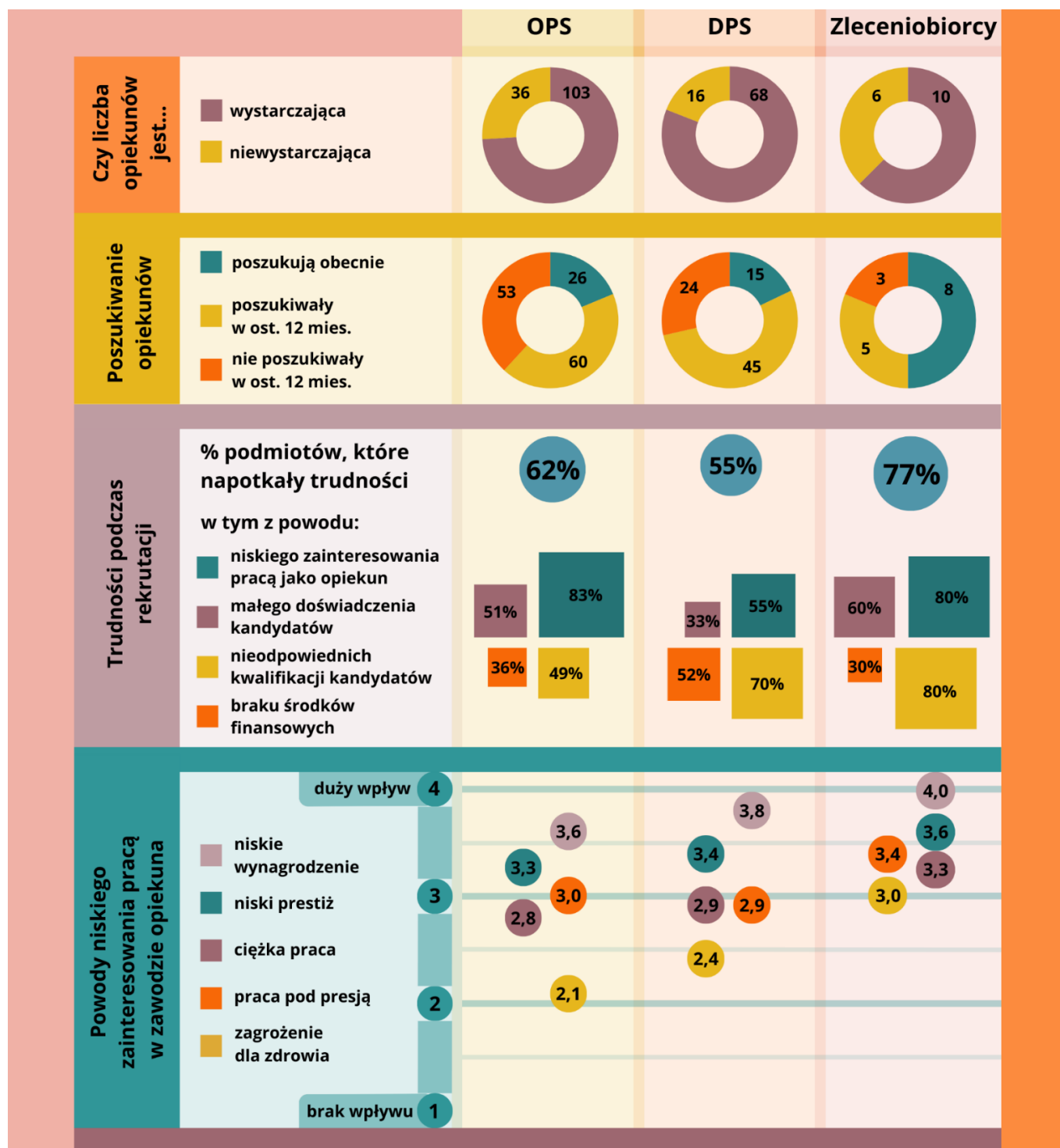
Trudności w rekrutacji opiekunów do pracy

Wśród podmiotów w województwie małopolskim, które wzięły udział w badaniu co czwarty OPS/CUS (36 na 139), niemal co piąty DPS (16 na 84), a także co trzeci (6 na 16) Zleceniobiorca wskazał, że obecna liczba osób zatrudnionych w jednostce jest niewystarczająca.

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie 62% OPS/CUS (86/139), 71% DPS (60/84) oraz większość podmiotów realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS (13 z 16) poszukiwało nowych pracowników na stanowisko opiekuna. W momencie badania opiekunów

poszukiwało 19% OPS/CUS (26 na 139), 18% DPS (15 na 84) oraz połowa (8 na 16) Zleceńbiorców.

Infografika 20. Braki kadrowe wśród opiekunów, a także działania i plany w zakresie rekrutacji nowych opiekunów przez OPS/CUS, DPS oraz podmioty realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zleceńbiorczy) = 16.

Wśród podmiotów, które poszukiwały nowych opiekunów w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie (w tym w momencie badania) 62% OPS/CUS, 55% DPS oraz 77% Zleceniobiorców napotkało trudności w rekrutacji odpowiednich pracowników. Głównym powodem tych problemów w opinii OPS/CUS było niskie zainteresowanie pracą jako opiekun (83% wskazań), z kolei domy pomocy społecznej wskazywały przeważnie na nieodpowiednie kwalifikacje kandydatów (70% wskazań). Wśród Zleceniobiorców tyle samo respondentów (8 na 10) wskazało na niskie zainteresowanie pracą na tym stanowisku, jak również nieodpowiednie kwalifikacje kandydatów.

Brak środków finansowych jako przyczynę trudności w rekrutacji nowych opiekunów do pracy wskazało 52% DPS, 36% OPS/CUS oraz 3 na 10 Zleceniobiorców, które doświadczyły takich trudności, z kolei małe doświadczenie kandydatów – 51% OPS/CUS, 33% DPS oraz 6 na 10 Zleceniobiorców.

Wśród powodów niskiego zainteresowania pracą w zawodzie opiekuna największy wpływ zdaniem osób zarządzających badanymi podmiotami miało niskie wynagrodzenie. Istotny wpływ w opinii wszystkich typów podmiotów miał również niski prestiż zawodu. Ciężka praca, w tym pod presją, także miała znaczny wpływ. Mniejsze znaczenie przypisywano natomiast zagrożeniom dla zdrowia opiekuna, zwłaszcza w przypadku OPS/CUS i DPS.

Podmioty, które zaznaczyły, iż nie poszukują nowych pracowników do wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub opieki w DPS, ani nie planują prowadzić rekrutacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy pomimo niewystarczającej liczby zatrudnionych opiekunów zapytano o powody takiej decyzji. Większość z nich (10 na 16, w tym 6 OPS/CUS, 3 DPS oraz 1 Zleceniobiorca) jako przyczynę podało brak środków finansowych

Wykres 13. Powody nieprowadzenia rekrutacji nowych opiekunów oraz braku planów w tym zakresie pomimo ich niewystarczającej liczby przez OPS/CUS, DPS oraz Zleceniobiorców



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 9, N (DPS) = 6, N (Zleceniobiorcy) = 1.

na zatrudnienie nowych opiekunów, co wskazuje na powszechny charakter problemu. 3 OPS/CUS wskazały na problemy z rekrutacją odpowiednich pracowników, 2 DPS – na ograniczenia etatowe, w tym limity zatrudnienia w jednostce,

a 2 podmioty – na inne przyczyny (w tym jeden OPS/CUS wskazał na fakt, iż w momencie badania lukę opiekuńczą uzupełniały programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”).

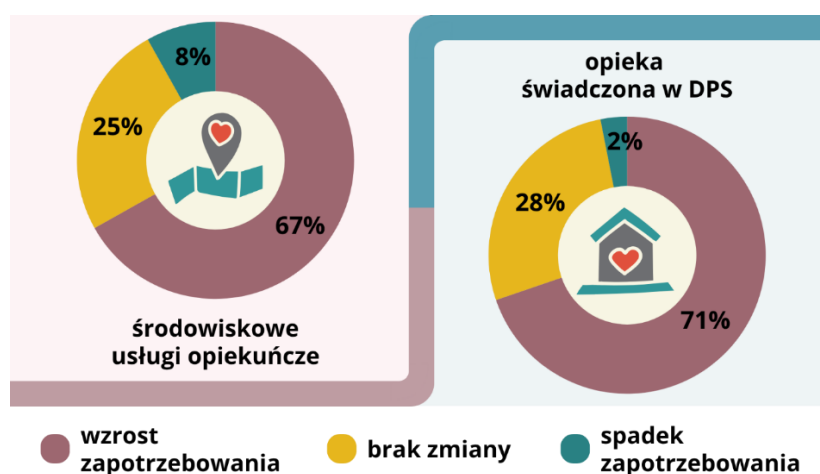
OPS/CUS zapytano również o postrzeganą zmianę zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz opiekę świadczoną w DPS na terenie gminy w ostatnich 5 latach poprzedzających badanie. Na wzrost zapotrzebowania na opiekę w DPS wskazało 71% jednostek, a na wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – dwie na trzy jednostki (67%).

Jedynie 8% OPS/CUS wskazało, iż w ostatnich 5 latach spadło u nich zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, a 2% OPS/CUS – na spadek zapotrzebowania na opiekę stacjonarną w DPS, podczas gdy około ¼ podmiotów nie zaobserwowała zmiany w zapotrzebowaniu na opiekę w miejscu zamieszkania oraz całodobową opiekę w DPS na swoim terenie.

Dane te wskazują zatem na wzrastające w województwie małopolskim potrzeby społeczne w zakresie zapewnienia opieki osobom mającym trudności w codziennym funkcjonowaniu przy wciąż niewystarczającej liczbie kandydatów chętnych do podjęcia pracy jako opiekun, a także posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania tego zawodu.

Ośrodkom pomocy społecznej oraz centrom usług społecznych zadano również pytanie dotyczące tego, z jakich źródeł pozyskują one informację o zapotrzebowaniu społeczności lokalnej na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz opiekę stacjonarną

Rysunek 4. Ocena przez OPS/CUS zmiany zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz opiekę w DPS w ostatnich 5 latach

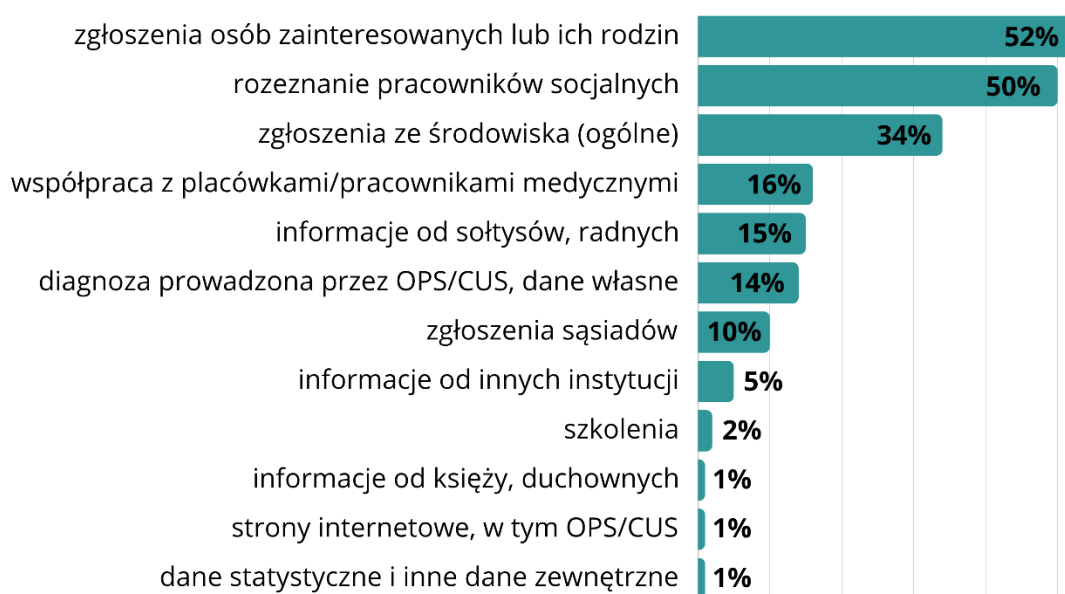


Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160.

w DPS. Odpowiedzi udzielone na to pytanie pokazują, że wśród źródeł pozyskiwania takich informacji były najczęściej bezpośrednie zgłoszenia zapotrzebowania na usługi opiekuńcze lub opiekę przez osoby zainteresowane lub ich członków rodziny i inne bliskie osoby. Drugim istotnym źródłem były informacje pozyskiwane przez pracowników socjalnych podczas pracy w środowisku, w tym poprzez prowadzenie rozeznania potrzeb oraz wywiady środowiskowe. Znaczna część OPS/CUS wymieniła, że pozyskuje dane ze środowiska za pośrednictwem źródeł innych niż bezpośrednie zgłoszenia się osób potrzebujących wsparcia – w tym 34% wymieniło ogólnie środowisko i społeczność lokalną bez doprecyzowania, o jakie osoby chodzi, 15% –

informacje od sołtysów lub radnych gminy/dzielnicy, a 10% – zgłoszenia sąsiadów. Część OPS/CUS również pozyskuje informacje o zapotrzebowaniu od placówek medycznych (16%) oraz innych podmiotów (5%), np. organizacji pozarządowych, a także od księży lub duchownych (1%). 14% OPS/CUS jako źródło informacji o potrzebach wskazało diagnozę prowadzoną wśród społeczności lokalnej oraz inne dane zgromadzone przez ośrodek.

Wykres 14. Źródła, z których OPS/CUS czerpią informację o zapotrzebowaniu społeczności lokalnej na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz opiekę w DPS (% OPS/CUS)



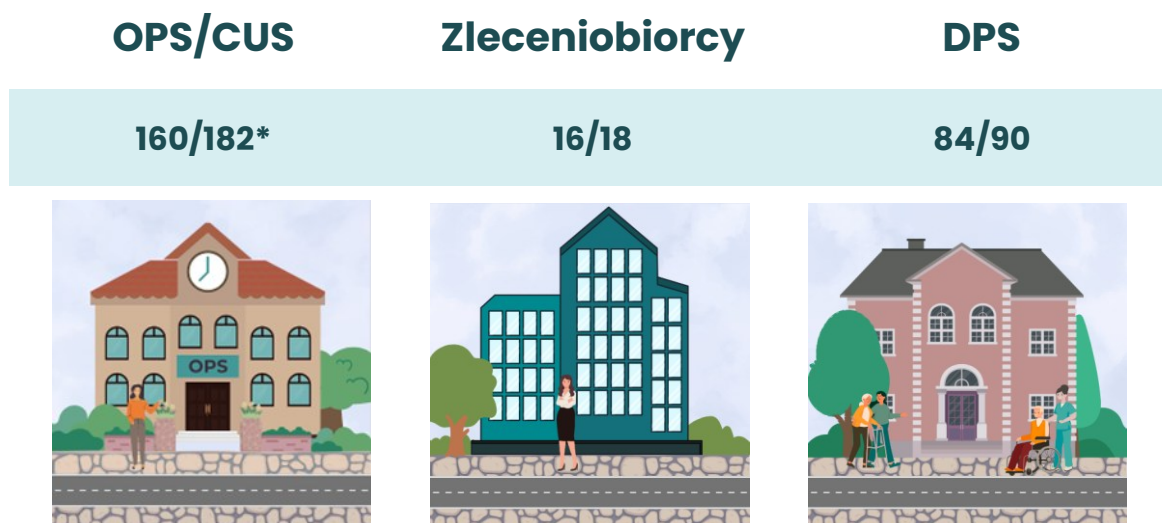
Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160.

Metodologia badania

Populacja i przebieg badania

Badanie składało się z dwóch etapów. **Pierwszy etap badania** obejmował ankietę skierowaną do osób zarządzających podmiotami realizującymi opiekę świadczoną w miejscu zamieszkania lub opiekę stacjonarną – ośrodkami pomocy społecznej, podmiotami, którym OPS/CUS zlecały wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz domami pomocy społecznej, w województwie małopolskim. W części przypadków ankietę wypełniły osoby wyznaczone przez zarządzających tymi jednostkami.

Rysunek 5. Liczba OPS/CUS, podmiotów realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS oraz DPS w próbie badawczej i w populacji w Małopolsce (I etap badania)



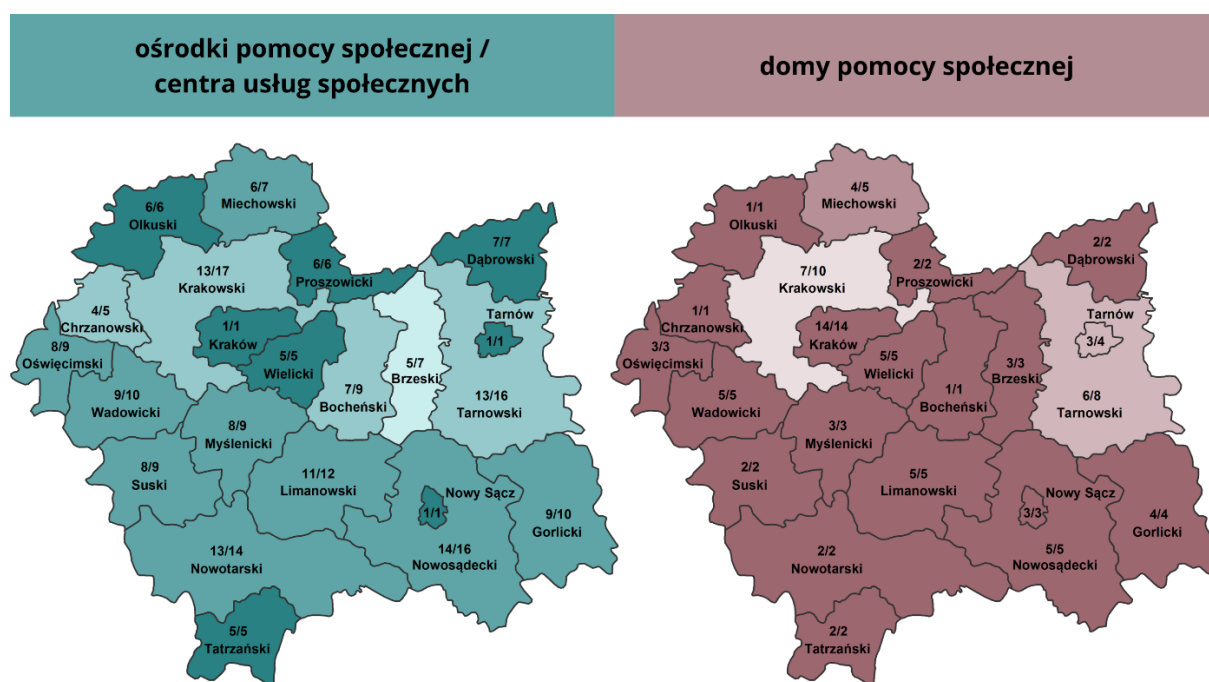
* Liczba gmin uwzględnionych w badaniu wyniosła 182, podczas gdy całkowita liczba gmin w Małopolsce od 1 stycznia 2025 r. wynosiła 183. Nieuwzględnienie gminy Szczawa, wyodrębnionej z gminy Kamienica, było podyktowane faktem, że w momencie prowadzenia badania gmina ta była jeszcze w trakcie procesu organizacji.

Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I).

Badanie było przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej w narzędziu CADAS oraz obejmowało domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej oraz centra usług społecznych funkcjonujące w województwie małopolskim w momencie badania (luty-marzec 2025 r.). Ankiety udostępniono respondentom za pomocą linka w wiadomości e-mail w dniu 18 lutego 2025 r. Proces zbierania danych w ramach pierwszego etapu został zakończony 19 marca 2025 r.

Stopa realizacji ankiet w pierwszym etapie badania wyniosła łącznie 90% wszystkich jednostek (260 z 290), w tym 88% ośrodków pomocy społecznej, 93% domów pomocy społecznej oraz 16 z 18 podmiotów, którym ośrodki pomocy społecznej zlecały realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Mapa 2. Stopa realizacji próby OPS/CUS i DPS w powiatach Małopolski



Źródło: ROPS w Krakowie – Badanie wśród osób zarządzających (etap I).

W grupie ośrodków pomocy społecznej / centrów usług społecznych pozyskano odpowiedzi od wszystkich jednostek w miastach na prawach powiatu oraz w pięciu powiatach: dąbrowskim, olkuskim, proszowickim, tatrzańskim i wielickim. Najmniejsza stopa realizacji próby OPS/CUS była w powiecie brzeskim, gdzie pozyskano dane od 5 z 7 jednostek.

Z kolei w grupie DPS w większości powiatów (18) pozyskano odpowiedzi od wszystkich domów pomocy społecznej funkcjonujących na ich terenie, w tym we wszystkich miastach na prawach powiatu poziom zwrotów wyniósł 100%. Najmniejsza stopa realizacji była w powiecie krakowskim, gdzie odpowiedzi na ankietę udzieliło 7 na 10 jednostek.

Drugi etap badania obejmował ankietę adresowaną do opiekunów zatrudnionych w badanych podmiotach – ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na ich zlecenie, a także w domach pomocy społecznej. W ramach tego etapu zastosowano inny schemat doboru próby dla różnych jednostek, zakładając minimalny poziom zwrotu na poziomie 10% jednostek wewnątrz różnych kategorii podmiotów. W szczególności:

- w przypadku OPS/CUS pozyskano dane od opiekunów w 22 ośrodkach ze 182 (12% takich jednostek w Małopolsce). W tych ośrodkach ze względu na charakter pracy opiekunów środowiskowych oraz – w większości przypadków – niewielką liczbę zatrudnianych opiekunów, w wybranych jednostkach dążono do przeprowadzenia ankiety ze wszystkimi opiekunami w kontakcie pośrednim. Ankiety przeprowadzano w formie telefonicznej lub internetowej, oraz w wyjątkowych przypadkach papierowej – tej formy ankietowania unikano m.in. ze względu na chęć zachowania anonimowego charakteru ankiet. W celu upowszechnienia ankiety wśród opiekunów nawiązywano współpracę z osobą wyznaczoną do koordynacji działań na danym terenie. Ostatecznie wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS zrealizowano 84 ankiety, w tym 53 – w formie internetowej (CAWI), 19 – w formie wywiadu telefonicznego, a 12 – w formie ankiety papierowej pozyskanej w postaci skanów od ośrodków. Ostateczna stopa zwrotów w wybranych ośrodkach wyniosła 50% (odpowiedzi udzieliło 84 opiekunów na 168).

- W przypadku DPS pozyskano ankiety od opiekunów w 14 jednostkach (16% takich placówek w Małopolsce). W przypadku większych domów pomocy społecznej (posiadających co najmniej ok. 80 miejsc dla mieszkańców)²⁵ oraz znajdujących się w Krakowie lub w niewielkiej od niego odległości²⁶ ankiety przeprowadzano w kontakcie osobistym z opiekunami obecnymi na zmianie podczas jednej wizyty pracowników ROPS w Krakowie w DPS, które w części przypadków uzupełniano o ankiety przeprowadzane telefonicznie lub internetowo z pracownikami z różnych przyczyn nieobecnymi. W przypadku zaś DPS mniejszych lub znajdujących się w znacznej odległości od Krakowa ankietę przeprowadzano w kontakcie telefonicznym lub internetowo ze wszystkimi zatrudnionymi pracownikami lub na próbie wybranych losowo pracowników.²⁷ Ostatecznie przeprowadzono 119 ankiet z opiekunami zatrudnionymi w DPS, w tym 81 – w formie papierowej (w kontakcie osobistym), 31 – w formie ankiety internetowej oraz 7 – w formie ankiety telefonicznej. Z uwagi na mieszaną technikę pozyskiwania danych w DPS na etapie przygotowania danych do analizy dane poddano ważeniu, aby zniwelować efekt doboru próby na udział w niej poszczególnych grup.
- W przypadku podmiotów realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS badaniem objęto pracowników dwóch podmiotów z 18 (licząc jednostki będące filiami jako jeden podmiot). Ze względu na niewielką liczbę podmiotów w populacji oraz ograniczone możliwości nawiązania kontaktu z częścią z nich, do próby weszły jedynie dwa podmioty, w tym jeden – w Krakowie. Są to jednostki współpracujące

²⁵ Od wielkości DPS zależała liczba opiekunów obecnych na danej zmianie w ciągu dnia, z którymi możliwe było przeprowadzenie ankiet podczas jednej wizyty pracowników ROPS w Krakowie w danym DPS.

²⁶ Co miało wpływ na możliwości oraz czas dojazdu pracowników ROPS w Krakowie do placówki.

²⁷ Sposób przeprowadzenia ankiet dostosowywano do możliwości jednostki, uzgadniając najbardziej dogodną metodę doboru ankietowania przy zachowaniu jak największej losowości doboru pracowników do próby.

w sposób długoterminowy z ośrodkami pomocy społecznej w obszarze realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Ankiety przeprowadzono ze wsparciem osób wyznaczonych do kontaktu. W jednym z podmiotów zrealizowano ankiety w formie elektronicznej wśród wszystkich zatrudnionych opiekunów, a w drugim – na próbie opiekunów w postaci ankiety papierowej lub elektronicznej (do próby dobierano co drugą osobę podczas wizyt opiekunów w jednostkach w celach rozliczeniowych odbywających się w przeciągu kilku dni). Finalnie do próby weszło 60 opiekunów zatrudnionych w podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS, przy czym ankietę papierową wypełniły 34 osoby, a ankietę internetową – 26 osób.

Tabela 2. Liczba ankiet pozyskanych za pomocą różnych technik od opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na ich zlecenie oraz w DPS

		OPS/CUS	Zleceniobiorcy	DPS	OGÓŁEM
LICZBA PODMIOTÓW		22	2	14	38
LICZBA OPIEKUNÓW	ankieta papierowa	12	34	81	127
	ankieta telefoniczna	19	0	7	26
	ankieta internetowa	53	26	31	110
	OGÓŁEM	84	60	119	263

Źródło. ROPS w Krakowie – II etap (badanie opiekunów).

Łącznie w drugim etapie badania przeprowadzono 263 ankiety z opiekunami świadczącymi opiekę w DPS oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na terenie województwa małopolskiego (ok. 6,5% opiekunów wykazanych przez badane podmioty). Wielkość próby oraz zastosowane techniki doboru,

a także ważenia, pozwalają w dużej mierze uznać próbę za reprezentatywną dla osób wykonujących zawód opiekuna w Małopolsce²⁸.

Badane obszary i metody badawcze

Celem badania było pozyskanie informacji na temat różnych aspektów pracy opiekunów w DPS i opiekunów wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich zadowolenia z pracy, motywacji do pracy w zawodzie, kwalifikacji oraz wypalenia zawodowego.

Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach z użyciem metod ilościowych:

- ankieta wśród osób zarządzających OPS/CUS, DPS, oraz podmiotami, którym OPS/CUS zlecają wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
- oraz ankieta wśród opiekunów zatrudnionych w tych jednostkach²⁹.

Badanie ilościowe pozwoliło na zebranie reprezentatywnych danych dla populacji podmiotów świadczących opiekę oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania³⁰ w zakresie ich funkcjonowania, a także potrzeb opiekunów w nich zatrudnionych.

Badanie miało na celu udzielenie odpowiedzi na szereg pytań badawczych:

- Jak opiekunowie oceniają różne aspekty swojej pracy?
- Czy opiekunowie mają poczucie sensu pracy? W jakim stopniu odczuwają wypalenie zawodowe?

²⁸ Dokładną charakterystykę populacji oraz próby OPS/CUS, DPS oraz podmiotów realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS obrazują: Infografika 26, Infografika 27 oraz Infografika 28. Pokazują one, na ile cechy próby dobranych jednostek są zbliżone do cech populacji. Z kolei wątpliwości dotyczące reprezentatywności próby opiekunów zatrudnionych przez Zleceniobiorców są omówione w części „Uwagi metodologiczne”.

²⁹ Kwestionariusze ankiet zarówno dla osób zarządzających podmiotami organizującymi i świadczącymi opiekę, jak również wśród opiekunów, którzy są w nich zatrudnieni, znajdują się w aneksie.

³⁰ Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w części „Uwagi metodologiczne”.

- Czy opiekunowie mają wystarczające możliwości rozwoju zawodowego w miejscu pracy (podnoszenia kompetencji, np. szkolenia, awansu)? Jakich kompetencji / szkoleń najbardziej brakuje?
- Jaka są cechy społeczno-demograficzne opiekunów (wykształcenie, wiek, płeć)?
- Jakie są plany zawodowe opiekunów?
- Czy obecna liczba opiekunów zatrudnionych w badanych jednostkach jest wystarczająca w stosunku do potrzeb?
- Czy pracodawcy poszukują obecnie nowych pracowników na stanowisko opiekuna? Czy występują jakieś trudności w rekrutacji odpowiednich pracowników?
- Jak zmieniło się zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i opiekę w DPS w ostatnich latach? Czy pracodawcy planują zwiększyć lub zmniejszyć liczbę opiekunów w najbliższym roku?
- Jakiej narodowości są opiekunowie? Czy zwiększa się liczba opiekunów pochodzących z Ukrainy i z innych krajów?
- Jakich kompetencji oczekują pracodawcy od opiekunów? Jak oceniają kompetencje obecnych pracowników na tym stanowisku?
- W jaki sposób pandemia Covid-19 oraz wojna w Ukrainie wpłynęły na pracę opiekunów oraz funkcjonowanie jednostek pomocy społecznej świadczących opiekę i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania? Czy skutki tych wydarzeń są nadal odczuwalne?

Kluczowe obszary, które stanowiły przedmiot zainteresowania były zatem następujące:

1. Zadowolenie z pracy

Zadowolenie z pracy obejmuje takie jej aspekty jak: stabilność zatrudnienia, wymiar pracy, work-life balance, wynagrodzenie, wyposażenie w środki i narzędzia pracy, bezpieczeństwo w pracy, możliwość awansu, możliwości rozwoju (np. szkolenia), możliwość wykorzystania swoich umiejętności i doświadczenia, stosunki między kierownictwem a pracownikami, stosunki między współpracownikami, obciążenie pracą, skala napięć i stresu, uznanie społeczne wobec zawodu. Wymiary zadowolenia z pracy, które wykorzystano w kwestionariuszu podczas badania opiekunów wyodrębniono z wykorzystaniem kwestionariusza z ogólnopolskiego badania „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” z 2022 r.³¹

2. Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe zostało zdefiniowane poprzez takie wymiary jak przeciążenie pracą, brak autonomii, brak kontroli nad przebiegiem i efektami własnych działań, brak wsparcia, niedostateczne wynagrodzenie.³²

Beata Mańkowska wyróżniła następujące etapy wypalenia zawodowego w zawodach z obszaru pomocy społecznej:

I etap: chroniczne zmęczenie, brak energii i zapału do działania.

II etap: negatywne zmiany w zakresie społecznego funkcjonowania pracownika – utrata zainteresowania i troski o sprawy klientów, narastające zobojętnienie, lekceważenie wobec osób zwracających się po pomoc.

³¹ Grabowska, I., Kuźma, K., Polańska, Z., Abramowicz, J., Kozera, J. (2022). Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 2020–2021. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 46.

³² Maslach, C., Leiter, M. P. (2010). Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawienia relacji z pracą. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

III etap: utrata poczucia osiągnięć i zawodowej satysfakcji, przekonanie o bezwartościowości oraz bezcelowości wykonywanej pracy, braku kompetencji zawodowych, obniżenie osobistego zaangażowania w pełnione obowiązki.³³

Pytania dotyczące wypalenia zawodowego oraz oceny środowiska pracy w drugim etapie badania (wśród opiekunów formalnych) są oparte na pytaniach z badań „Diagnoza społeczna” z 2015 roku³⁴ oraz Kopenhaskiego Kwestionariusza Prychospołecznego (COPSOQ)³⁵.

3. Plany zawodowe opiekunów

Plany zawodowe opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, które są przedmiotem zainteresowania w tym badaniu obejmują perspektywę zmiany miejsca pracy (w tym założenia własnej działalności gospodarczej), zmiany zawodu bądź też rezygnacji z pracy zawodowej lub przejścia na emeryturę.

4. Kompetencje pracowników

Obszar kompetencji opiekunów był w badaniu oceniany zarówno przez osoby zarządzające badanymi podmiotami, jak również przez samych opiekunów. Kompetencje opiekunów obejmują:

- wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie higieny i pielęgnacji osób niesamodzielnych, asystowania w czynnościach dnia codziennego, rozpoznawania i oceniania stanu i możliwości funkcjonowania klienta, opracowywania planu pomocy i opieki, a także znajomości specyfiki pracy z danym typem klienta oraz zasad i standardów opieki.

³³ Mańkowska, B. (2015). W trosce o pracownika. Ryzyko wypalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej. *Polityka Społeczna* 5-6, s. 22-26.

³⁴ Diagnoza społeczna 2015. Niezależne badanie warunków i jakości życia w Polsce. Kwestionariusze i instrukcja. <http://www.diagnoza.com/>.

³⁵ German standard version of COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire). <https://www.copsoq.de/en/questionnaire>.

- kompetencje społeczne – nawiązywanie kontaktu i skuteczne komunikowanie się z klientami i ich rodzinami, wsparcie psychiczne, wspieranie sprawności i aktywizowanie do samodzielności
- kompetencje medyczne – wykonywanie zabiegów prozdrowotnych, udzielanie pierwszej pomocy
- kompetencje emocjonalne – radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami, radzenie sobie z własnymi emocjami
- inne kompetencje, na przykład administracyjne (prowadzenie dokumentacji, podstawowa znajomość odpowiednich przepisów prawnych), kompetencje cyfrowe oraz kompetencje międzykulturowe.

Wymiary kompetencje, które wykorzystano w kwestionariuszach zarówno dla osób zarządzających, jak i opiekunów, są oparte o ogólnopolskie badanie „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego” z 2022 r.³⁶

5. Wpływ pandemii i kryzysu migracyjnego

Wśród możliwych konkwencji pandemii Covid-19 oraz wojny w Ukrainie trwającej od lutego 2022 roku, mogą być zmiany liczby kandydatów na opiekunów oraz zatrudnionych opiekunów, klientów wymagających wsparcia, poziomu obciążenia pracą oraz stresu opiekunów, a także inne wyzwania związane z nową sytuacją, w tym konieczność reorganizacji pracy przez podmioty świadczące opiekę.

Analiza i wizualizacja wyników

W procesie opracowania wyników badania wykorzystano zróżnicowane narzędzia analityczne i wizualizacyjne. Wstępna obróbka danych,

³⁶ Grabowska, I., Kuźma, K., Polańska, Z., Abramowicz, J., Kozera, J. (2022). *Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 2020–2021*. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 214-218.

ich porządkowanie oraz przygotowanie większości podstawowych statystyk opisowych oraz analiz statystycznych zostały przeprowadzone z wykorzystaniem programu Excel. Pogłębiona analiza, w szczególności w zakresie stworzenia modelu SEM oraz części wizualizacji danych została zrealizowana w środowisku R, przy użyciu wybranych pakietów: „tidyverse”³⁷, „dplyr”³⁸, „openxlsx”³⁹, „ggplot2”⁴⁰, „eulerr”⁴¹, „readxl”⁴², „broom”⁴³, „lavaan”⁴⁴, „psych”⁴⁵, oraz „semPlot”⁴⁶. Wizualna prezentacja części wyników została opracowana przy użyciu narzędzia Canva.

Analiza wyników została przeprowadzona w podziale na poszczególne rodzaje podmiotów, co pozwoliło na uchwycenie różnic i podobieństw pomiędzy nimi. Takie podejście umożliwia lepsze zrozumienie specyfiki funkcjonowania badanych jednostek, a także identyfikację ewentualnych zróżnicowań w analizowanych obszarach.

³⁷ Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L. D., François, R., Golemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T. L., Miller, E., Bache, S. M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., Takahashi, K., Vaughan, D., Wilke, C., Woo, K., Yutani, H. (2019). “Welcome to the tidyverse.” *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. doi:10.21105/joss.01686.

³⁸ Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K., Vaughan, D. (2023). *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. R package version 1.1.4. <https://CRAN.R-project.org/package=dplyr>.

³⁹ Schauburger, P., Walker, A. (2023). *openxlsx: Read, Write and Edit xlsx Files*. R package version 4.2.5.2. <https://CRAN.R-project.org/package=openxlsx>.

⁴⁰ Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. New York: Springer-Verlag.

⁴¹ Larsson, J. (2024). *eulerr: Area-Proportional Euler and Venn Diagrams with Ellipses*. R package version 7.0.2. <https://CRAN.R-project.org/package=eulerr>.

⁴² Wickham, H., Bryan, J. (2023). *readxl: Read Excel Files*. R package version 1.4.3. <https://CRAN.R-project.org/package=readxl>.

⁴³ Robinson, D., Hayes, A., Couch, S. (2023). *broom: Convert Statistical Objects into Tidy Tibbles*. R package version 1.0.5. <https://CRAN.R-project.org/package=broom>.

⁴⁴ Rosseel, Y. (2012). *lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling*. *Journal of Statistical Software*, 48(2), 1-36. <https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02>.

⁴⁵ Revelle, W. (2024). *psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research*. Northwestern University, Evanston, Illinois. R package version 2.4.1. <https://CRAN.R-project.org/package=psych>.

⁴⁶ Epskamp, S. (2026). *semPlot: Path Diagrams and Visual Analysis of Various SEM Packages' Output*. R package version 1.1.8. <https://CRAN.R-project.org/package=semPlot>.

Uwagi metodologiczne

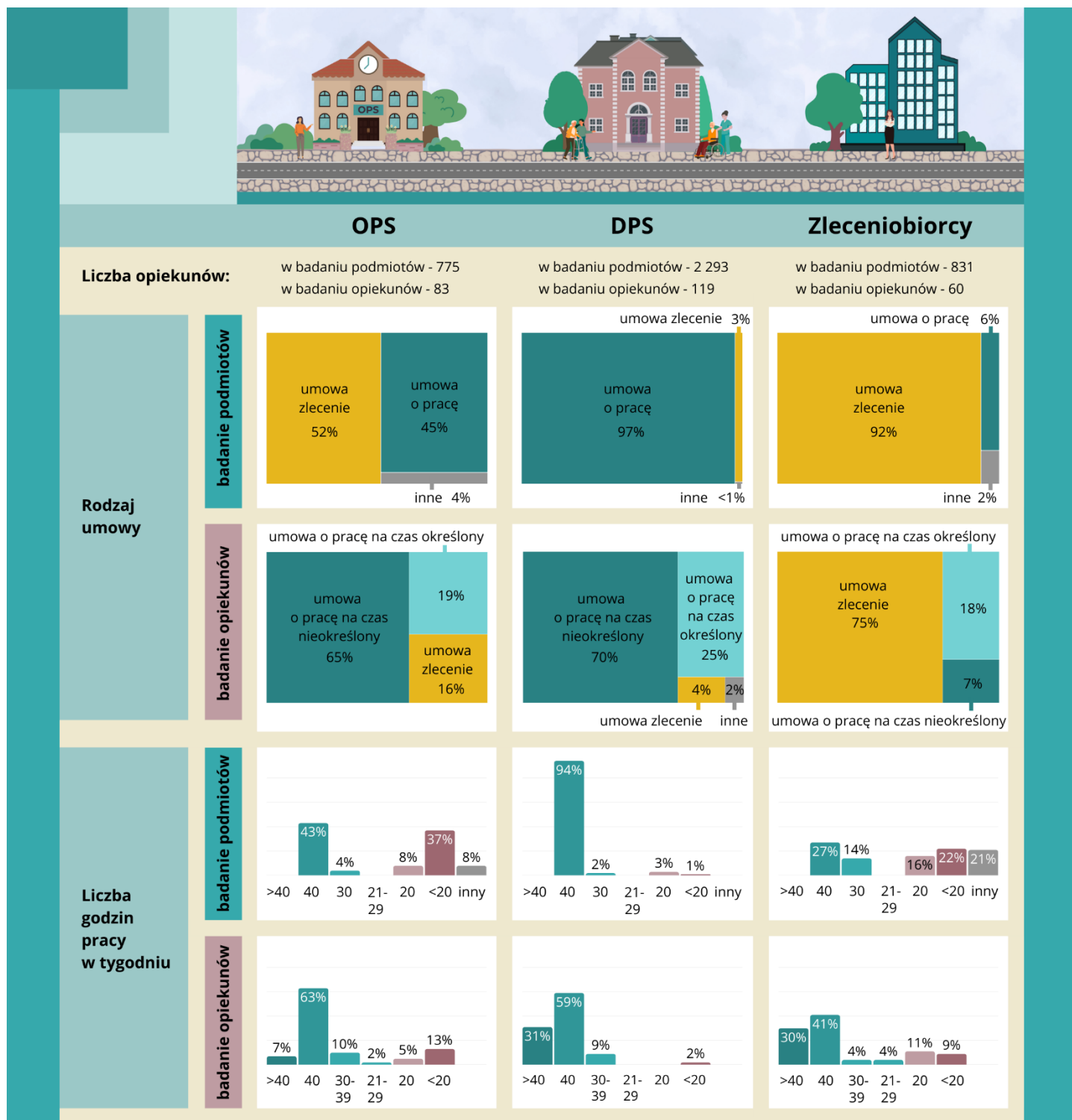
Charakterystyka populacji a próby opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS

W trakcie analizy danych zebranych podczas badania zostały uwidocznione pewne rozbieżności w charakterystyce próby opiekunów zatrudnionych w badanych jednostkach względem charakterystyki populacji opiekunów opartej na danych pozyskanych w badaniu podmiotów świadczących opiekę w Małopolsce. W szczególności, podczas gdy charakterystyka próby opiekunów pracujących w DPS i u Zleceniobiorców OPS/CUS pod względem formy zatrudnienia i wymiaru pracy była zbliżona do deklaracji podmiotów, wśród ankietowanych opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS znacznie więcej osób deklarowało pracę na umowę o pracę (84%) oraz w pełnym wymiarze czasu pracy (70%), aniżeli w odpowiedziach osób zarządzających tego typu jednostkami.

Podczas przeprowadzania badania opiekunów formalnych podkreślano, że badanie dotyczy wszystkich opiekunów zatrudnionych w jednostce bez względu na formę zatrudnienia. Pomimo to, jak się wydaje, część pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w wybranych jednostkach nie weszła do próby. Jednym z wyjaśnień tego faktu może być mniejszy stopień przywiązania do miejsca pracy opiekunów wykonujących pracę na umowę zlecenie, bądź też mniej ścisły kontakt pomiędzy tymi osobami a pracownikami reprezentującymi OPS/CUS, co prowadzi do nadreprezentacji w próbie osób zatrudnionych w OPS/CUS na umowę o pracę.

Ta rozbieżność może wpływać na prezentowane wyniki, które w większym stopniu reprezentują opinie opiekunów pracujących w OPS/CUS na umowę o pracę oraz w większym wymiarze godzin, aniżeli osób wykonujących taką pracę w sposób dorywczy lub w ramach mniej stabilnych form zatrudnienia.

Infografika 21. Rodzaj umowy oraz wymiar pracy opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS – w odpowiedziach podmiotów oraz opiekunów (% opiekunów)



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zleceniobiorcy) = 16; Badanie opiekunów formalnych (etap II), N (OPS/CUS) = 83, N (DPS) = 119, N (Zleceniobiorcy) = 60.

Próba opiekunów zatrudnionych u Zleceniobiorców OPS/CUS

Pomimo że w badaniu opiekunów objęto co najmniej 10% podmiotów należących do różnych rodzajów jednostek opiekuńczych w Małopolsce, w przypadku podmiotów realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS do próby trafili opiekunowie zatrudnieni jedynie w dwóch podmiotach, co wynika z niewielkiej liczby populacji takich podmiotów na terenie województwa, która wynosi 18 (licząc jednostki będące filiami jako jeden podmiot).

W związku z niewielką liczbą podmiotów, których pracownicy weszli do próby badawczej, jej reprezentatywność dla populacji opiekunów zatrudnionych w pozostałych podmiotach niepublicznych realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS może być ograniczona.

W szczególności, jeden z podmiotów realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla Krakowa, zatrudniając znaczną liczbę pracowników do wykonywania tego zadania. Z kolei drugi podmiot był jednostką organizacyjną gminy miejskiej realizującą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie ośrodka pomocy społecznej.

Podczas interpretacji wyników należy zatem wziąć pod uwagę potencjalnie mniejszy poziom reprezentatywności tych wyników w odniesieniu do opiekunów zatrudnionych w jednostkach innego typu – w tym firmach prywatnych bądź spółdzielniach socjalnych, działających w mniejszych miejscowościach, na terenach wiejskich, czy też posiadających inną strukturę organizacyjną, aniżeli wyżej opisane podmioty.

Spis ilustracji

Wykresy

Wykres 1. Sposoby realizacji usług opiekuńczych przez OPS/CUS	28
Wykres 2. Sposoby realizacji przez OPS/CUS gminnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	29
Wykres 3. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz inne usługi świadczone przez podmioty działające na zlecenie OPS/CUS	32
Wykres 4. Tryb pracy opiekunów zatrudnionych w DPS	39
Wykres 5. Liczba dni pracy w godzinach nocnych w tygodniu wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS i DPS	41
Wykres 6. Liczba dni pracy w weekendy w miesiącu wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców	43
Wykres 7. Stopień obaw przed utratą pracy wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców	59
Wykres 8. Ocena łatwości znalezienia nowej pracy, co najmniej tak samo dobrej jak obecna, wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców	60
Wykres 9. Ocena prawdopodobieństwa zakończenia pracy w obecnym miejscu zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców	61
Wykres 10. Najbardziej prawdopodobny powód zakończenia pracy w obecnym miejscu zatrudnienia w najbliższych 12 miesiącach wśród opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS (liczba opiekunów)	62
Wykres 11. Na ile obecne kompetencje pozwalają na optymalne wykonywanie obowiązków w opinii opiekunów formalnych	87
Wykres 12. Udział opiekunów w superwizji w ciągu ostatnich 12 miesięcy	100
Wykres 13. Powody nieprowadzenia rekrutacji nowych opiekunów oraz braku planów w tym zakresie pomimo ich niewystarczającej liczby przez OPS/CUS, DPS oraz Zleceniobiorców	112
Wykres 14. Źródła, z których OPS/CUS czerpią informację o zapotrzebowaniu społeczności lokalnej na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz opiekę w DPS (% OPS/CUS)	114

Rysunki

Rysunek 1. Schemat modelu SEM określającego czynniki wpływające na ocenę pracy przez opiekunów formalnych oraz poziom wypalenia zawodowego	64
Rysunek 2. Główne problemy i wyzwania wymieniane w odpowiedziach otwartych przez opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców.....	74
Rysunek 3. Czynniki motywujące do pracy jako opiekun w odpowiedziach otwartych opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców	77
Rysunek 4. Ocena przez OPS/CUS zmiany zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz opiekę w DPS w ostatnich 5 latach.....	113
Rysunek 5. Liczba OPS/CUS, podmiotów realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS oraz DPS w próbie badawczej i w populacji w Małopolsce (I etap badania)	115

Infografiki

Infografika 1. Formy realizacji środowiskowych usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych oraz specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przez OPS/CUS w Małopolsce	31
Infografika 2. Liczba DPS w Małopolsce według rodzaju grupy docelowej mieszkańców.....	34
Infografika 3. Rodzaj umowy oraz wymiar czasu pracy opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS (% opiekunów).....	38
Infografika 4. Cechy pracy opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS – tygodniowy wymiar, obszar pracy, praca w nocy i w weekendy	40
Infografika 5. Charakterystyka społeczno-demograficzna opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach, którym OPS/CUS zlecają wykonywanie środowiskowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	45
Infografika 6. Podmioty zatrudniające opiekunów pochodzenia innego niż polskie oraz liczba opiekunów według narodowości (liczba podmiotów)	49

Infografika 7. Ocena różnych aspektów pracy przez opiekunów zatrudnionych w małopolskich OPS/CUS, DPS oraz podmiotach, którym OPS/CUS zlecają wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.....	51
Infografika 8. Ocena różnych stwierdzeń dotyczących pracy przez opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców.....	55
Infografika 9. Ocena częstości występowania szeregu sytuacji związanych z pracą przez opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz u Zleceniobiorców	58
Infografika 10. Ocena kompetencji opiekunów zatrudnionych przez OPS/CUS, DPS oraz Zleceniobiorców, a także średnia ocena stopnia, w jakim kompetencje te są potrzebne do pracy jako opiekun.....	79
Infografika 11. Samoocena poziomu kompetencji opiekunów zatrudnionych przez OPS/CUS, DPS oraz Zleceniobiorców	84
Infografika 12. Szkolenia opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS.....	89
Infografika 13. Sposoby organizowania szkoleń oraz podmioty prowadzące szkolenia – z perspektywy opiekunów oraz osób zarządzających OPS/CUS, DPS oraz podmiotami realizującymi usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS	91
Infografika 14. Szkolenia opłacane samodzielnie przez opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS	93
Infografika 15. Najbardziej przydatne formy doskonalenia zawodowego według opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz przez Zleceniobiorców	96
Infografika 16. Wypowiedzi podmiotów dotyczące udziału opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS w superwizji.....	98
Infografika 17. Metody motywowania pracowników stosowane przez OPS/CUS, DPS oraz podmioty realizujące usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS.....	101
Infografika 18. Zmiany związane ze świadczeniem opieki przez OPS/CUS, DPS oraz Zleceniobiorców	105
Infografika 19. Zmiany w funkcjonowaniu OPS/CUS, DPS oraz Zleceniobiorców w związku z pandemią COVID-19.....	108
Infografika 20. Braki kadrowe wśród opiekunów, a także działania i plany w zakresie rekrutacji nowych opiekunów przez OPS/CUS, DPS oraz podmioty realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na zlecenie OPS/CUS....	110
Infografika 21. Rodzaj umowy oraz wymiar pracy opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, DPS oraz podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu	

zamieszkania na zlecenie OPS/CUS – w odpowiedziach podmiotów oraz opiekunów (% opiekunów).....	127
Infografika 22. Ocena poziomu kompetencji opiekunów formalnych przez OPS/CUS, DPS oraz podmioty realizujące usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS potrzebne do pracy jako opiekun	162
Infografika 23. Zależność między średnim poziomem kompetencji opiekunów/opiekunek formalnych przez OPS/CUS, a zapotrzebowaniem na poszczególne kompetencje wymagane w zawodzie opiekuna	163
Infografika 24. Zależność między średnim poziomem kompetencji opiekunów/opiekunek formalnych przez DPS, a zapotrzebowaniem na poszczególne kompetencje wymagane w zawodzie opiekuna	164
Infografika 25. Zależność między średnim poziomem kompetencji opiekunów/opiekunek formalnych przez podmioty realizujące usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS, a znaczeniem tych kompetencji w zawodzie opiekuna....	165
Infografika 26. Charakterystyka populacji i próby OPS/CUS do badania opiekunów formalnych (badanie wśród wszystkich opiekunów zatrudnionych w wybranych jednostkach)	166
Infografika 27. Charakterystyka populacji i próby DPS do badania opiekunów formalnych (dobór próby mieszany)	167
Infografika 28. Charakterystyka populacji i próby Zleceniobiorców oraz opiekunów w nich zatrudnionych do badania opiekunów formalnych (dobór próby mieszany)	168

Tabele

Tabela 1. Współczynniki modelu SEM określającego czynniki wpływające na ocenę pracy przez opiekunów oraz poziom wypalenia zawodowego	65
Tabela 2. Liczba ankiet pozyskanych za pomocą różnych technik od opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, podmiotach realizujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na ich zlecenie oraz w DPS	119

Mapy

Mapa 1. Liczba domów pomocy społecznej w Małopolsce według powiatów.....	33
Mapa 2. Stopa realizacji próby OPS/CUS i DPS w powiatach Małopolski	116

Aneks

Kwestionariusz dla osób zarządzających OPS/CUS, podmiotami realizującymi usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS, oraz DPS w Małopolsce

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w ankiecie skierowanej do osób zarządzających jednostkami świadczącymi opiekę całodobową oraz organizującymi i/lub świadczącymi usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - dyrektorów domów pomocy społecznej, dyrektorów/kierowników ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych, prezesów organizacji / firm realizujących usługi opiekuńcze na zlecenie samorządów.

Celem badania jest zebranie informacji na temat zapotrzebowania na pracowników w sektorze opiekuńczym w Małopolsce, potrzeb szkoleniowych kadr, przemian, jakie mogły zajść w ostatnim czasie w obszarze tych usług oraz wyzwań z tym związanych i możliwych rozwiązań. Informacje pozyskane od Państwa będą cennym źródłem wiedzy. Wyniki badania pomogą nam w lepszym zrozumieniu problemów, przed którymi stoją jednostki opiekuńcze oraz umożliwią doskonalenie systemu wsparcia pracowników. Proszę nie zamieszczać w ankiecie danych osobowych. Uzyskane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i przedstawiane w postaci zbiorczej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anastazją Zakusiło (tel.: 12 422 06 36 w. 40, e-mail: azakusilo@rops.krakow.pl). UWAGA: Ankieta jest skierowana do zarządzających jednostkami. Proszę z każdej jednostki wysyłać tylko jedną ankietę. Ankietę można wypełniać w odstępach czasowych. Aby zachować odpowiedzi należy wcisnąć przycisk "ODŁÓŻ" znajdujący się w prawym górnym rogu.

Dziękujemy za poświęcony czas!

Część 1. Podstawowe dane dot. jednostki, liczba pracowników

Pytanie 1. (OPS/CUS) Proszę wskazać, czy realizują Państwo następujące rodzaje usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, a jeżeli tak, to w jakich formach?

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

1. zatrudnianie opiekunów/opiekunek (proszę wziąć pod uwagę wszystkie typy umów)
2. zlecanie zadania organizacjom pozarządowym (fundacjom / stowarzyszeniom)
3. zlecanie zadania firmom komercyjnym
4. w innej formie (jakiej?)
5. nie realizujemy takich usług

Pytanie 2. (OPS/CUS) Czy realizują Państwo usługi opiekuńcze w formie sąsiedzkiej?

tak

nie

Pytanie 3. (DPS) Jaka jest ogólna liczba miejsc w DPS dedykowanych dla klientów wszystkich kategorii na dzień wypełniania ankiety?

|_|_|_|_| miejsc

Pytanie 4. (DPS) Ile miejsc w Państwa DPS jest przeznaczonych dla:

osób przewlekle somatycznie chorych

osób przewlekle psychicznie chorych

osób w podeszłym wieku

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

osób niepełnosprawnych fizycznie

osób uzależnionych od alkoholu

|_|_|_|_| miejsc

Pytanie 5. Ilu wszystkich pracowników jest zatrudnionych w Państwa jednostce na dzień wypełniania ankiety (w tym na umowę o pracę/ zlecenie/ dzieło/ inny rodzaj umowy)?

|_|_|_|_| osób

Pytanie 6. {DPS: Ilu opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS (w tym również specjalistyczne oraz specjalistyczne dla osób chorujących psychicznie)} {Zleceniobiorcy: Ile osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania} jest zatrudnionych w Państwa jednostce na dzień wypełniania ankiety (w tym na umowę o pracę/ zlecenie/ dzieło/ inny rodzaj umowy)?

|_|_|_|_| osób

Pytanie 7. Proszę podać, {DPS: ilu opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: ile osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania} jest zatrudnionych w Państwa jednostce w ramach następujących umów:

umowę o pracę

umowę zlecenie

inny rodzaj umowy (jaki?)

|_|_|_|_| osób

Pytanie 8. Proszę podać, {DPS: ilu opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: ile osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania} zatrudnionych w Państwa jednostce pracuje w następującym wymiarze godzin (proszę wziąć pod uwagę również osoby pracujące na umowę zlecenie lub o dzieło):

pełny etat (40 godzin tygodniowo)

$\frac{3}{4}$ etatu (30 godzin tygodniowo)

$\frac{1}{2}$ etatu (20 godzin tygodniowo)

mniej niż $\frac{1}{2}$ etatu (poniżej 20 godzin tygodniowo)

inny wymiar (jaki?)

|_|_|_|_| osób

Pytanie 9. (DPS) W jakim systemie pracują opiekunowie/opiekunki w Państwa placówce?

dwuzmianowym

trzymianowym

innym (jakim?) → PRZEJDŹ DO PYTANIA 9

Pytanie 10. (DPS) Proszę wpisać godziny rozpoczęcia i zakończenia każdej zmiany oraz przeciętną liczbę opiekunów/opiekunek pracujących jednocześnie na danej zmianie:

Zmiana 1:

Zmiana 2:

(jeżeli 3 zmiany) Zmiana 3:

Pytanie 11. (jeżeli inny system - DPS) Ilu opiekunów/opiekunek jest przeciętnie obecnych w pracy w tym samym czasie?

|_|_|_| osób

Pytanie 12. {DPS: Ilu opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: Ile osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania} niebędących obywatelami polskimi jest zatrudnionych w Państwa {OPS/CUS, DPS: jednostce} {Zleceniobiorcy: organizacji/firmie}?

|_|_|_| osób

Pytanie 12.1. (jeżeli p.10>0) Ile jest wśród nich osób będących obywatelami następujących krajów?

Ukraina |_|_|_| osób

Białoruś |_|_|_| osób

Gruzja |_|_|_| osób

Mołdawia |_|_|_| osób

Armenia |_|_|_| osób

Inny kraj 1 (jaki?) |_|_|_| osób

Inny kraj 2 (jaki?) |_|_|_| osób

Inny kraj 3 (jaki?) |_|_|_| osób

Pytanie 12.2. (jeżeli p.10>0) {DPS: Ilu opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: Ile osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania} niebędących

obywatelami polskimi pochodzących z następujących krajów było zatrudnionych w Państwa jednostce na koniec 2019 roku?

Ukraina	_ _ _	osób
Białoruś	_ _ _	osób
Gruzja	_ _ _	osób
Mołdawia	_ _ _	osób
Armenia	_ _ _	osób
Inny kraj 1 (jaki?)	_ _ _	osób
Inny kraj 2 (jaki?)	_ _ _	osób
Inny kraj 3 (jaki?)	_ _ _	osób

Pytanie 13. (Zleceńbiorki) Czy świadczą Państwo usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania również poza zleceniami publicznymi (z ośrodków pomocy społecznej lub centrów usług społecznych), np. w ramach działalności statutowej lub innego rodzaju działalności, w tym komercyjnej, itd.?

tak

nie

Pytanie 14. (Zleceńbiorki - jeżeli pyt. 11 = 1) Jaki jest w przybliżeniu procentowy (%) udział klientów, dla których Państwa opiekunowie świadczą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach zlecenia / powierzenia zadania przez ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych wśród wszystkich klientów?

|_|_| %

Część 2. Zapotrzebowanie jednostki na {DPS: opiekunów} {OPS/CUS, Zleceńbiorki: osoby wykonujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania}

Pytanie 15. Czy obecna liczba {DPS: opiekunów/opiekunek jest wystarczająca} {OPS/CUS: osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania zatrudnionych w Państwa jednostce jest wystarczająca, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie społeczne?} {Zleceńbiorki: osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

zatrudnionych w Państwa organizacji/firmie jest wystarczająca do realizacji zlecenia/zleceń}?

tak → PRZEJDŹ DO 14.1

nie → PRZEJDŹ DO 15

Pytanie 15.1. Ilu {DPS: opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania} brakuje?

|_|_|_| osób

Pytanie 16. Czy poszukują Państwo obecnie nowych {DPS: opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: pracowników do wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania}?

tak

nie

Pytanie 17. Czy w ostatnich 12 miesiącach poszukiwali Państwo nowych {DPS: opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: osób do wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania}?

tak

nie

Pytanie 17.1. (jeżeli p.14=1 lub p.15=1) Czy napotkali Państwo trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników do {DPS: pracy jako opiekun/opiekunka} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania}?

tak → PRZEJDŹ DO 17.1.1

nie → PRZEJDŹ DO 18

Pytanie 17.1.1. Co utrudnia znalezienie pracownika do {DPS: pracy jako opiekun/opiekunka} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania} (proszę wybrać wszystkie odpowiedzi, które Państwa dotyczą)

brak wystarczających środków do zatrudnienia nowych pracowników

brak kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach

brak kandydatów o odpowiednim doświadczeniu

brak kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku opiekuna

inne (jakie?)

Pytanie 17.1.2. (jeżeli p. 16.1.1 „liczba kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku opiekuna / opiekuna środowiskowego” =1) Jaki wpływ na niskie zainteresowanie pracą {DPS: jako opiekun/opiekunka} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: związaną z wykonywaniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania} Pani(-a) zdaniem mają poszczególne czynniki?

niskie wynagrodzenie

niski prestiż zawodu

niechęć do wykonywania pracy wymagającej intensywnego wysiłku fizycznego

niechęć do wykonywania pracy związanej z presją psychiczną

obawy dotyczące zagrożeń dla zdrowia (np. zakażenia koronawirusem)

inne (jakie?)

1. duży wpływ

2. umiarkowany wpływ

3. niewielki wpływ

4. brak wpływu

Pytanie 18. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy planują Państwo zwiększyć, zmniejszyć, czy też utrzymać liczbę {DPS: opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania} na obecnym poziomie?

zwiększyć

utrzymać na obecnym poziomie

zmniejszyć

Pytanie 19. (jeżeli pyt. 15=2 oraz pyt. 18=2 lub 3) Dlaczego pomimo niewystarczającej liczby {DPS: opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania} nie planują Państwo zwiększenia ich liczby w ciągu najbliższych 12 miesięcy? (proszę wybrać wszystkie odpowiedzi, które Państwa dotyczą)

brak środków finansowych

problemy z rekrutacją odpowiednich pracowników
działania w zakresie zwiększenia wydajności pracy obecnie zatrudnionych pracowników
inne przyczyny (jakie?)

Pytanie 20. (OPS/CUS) Czy w ostatnich 5 latach zauważyli Państwo zmianę poziomu potrzeb mieszkańców w zakresie korzystania z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz w placówkach całodobowej opieki? Proszę wskazać w odniesieniu do każdego z tych typów usług, czy nastąpił wzrost czy spadek zapotrzebowania:

usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania
opieka świadczona w DPS

1. wzrost zapotrzebowania
2. brak zmiany
3. spadek zapotrzebowania

Pytanie 21. (OPS/CUS) Z jakich źródeł czerpią Państwo wiedzę na temat zapotrzebowania na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania lub w placówce całodobowej opieki wśród mieszkańców gminy?

.....

Część 3. Kompetencje pracowników

Pytanie 22. Jak oceniają Państwo poziom niżej wymienionych kompetencji {DPS: opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS: osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania zatrudnionych w Państwa jednostce} {Zleceniobiorcy: osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania zatrudnionych w Państwa organizacji/firmie}?

znajomość zasad i standardów opieki nad osobą starszą, niesamodzielną, z niepełnosprawnościami
komunikacja z osobami z demencją
opieka nad osobami z demencją
rozpoznawanie i ocenianie stanu i możliwości funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego klienta

opracowywanie planu pomocy i opieki dla klienta uwzględniając poziom jego możliwości psychofizycznych
higiena i pielęgnacja osób niesamodzielnych
asystowanie w czynnościach dnia codziennego
wykonywanie zabiegów prozdrowotnych
udzielanie pierwszej pomocy
nawiązywanie kontaktu i skuteczne komunikowanie się z klientami
wsparcie psychiczne klientów
wspieranie sprawności i aktywizowanie klientów do samodzielności
radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami
radzenie sobie z własnymi emocjami
prowadzenie dokumentacji
podstawowa znajomość odpowiednich przepisów prawnych (np. ustawy o pomocy społecznej)
obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych (korzystanie z internetu, aplikacji mobilnych, spotkania online)
komunikowanie się z rodzinami klientów
komunikacja międzykulturowa i współpraca z cudzoziemcami

1. wysoki
2. średni
3. niski

Pytanie 23. W jakim stopniu te kompetencje są potrzebne do {DPS: pracy jako opiekun/opiekunka} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania}?

znajomość zasad i standardów opieki nad osobą starszą, niesamodzielną, z niepełnosprawnościami
komunikacja z osobami z demencją
opieka nad osobami z demencją
rozpoznawanie i ocenianie stanu i możliwości funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego klienta

opracowywanie planu pomocy i opieki dla klienta uwzględniając poziom jego
 możliwości psychofizycznych
 higiena i pielęgnacja osób niesamodzielnych
 asystowanie w czynnościach dnia codziennego
 wykonywanie zabiegów prozdrowotnych
 udzielanie pierwszej pomocy
 nawiązywanie kontaktu i skuteczne komunikowanie się z klientami
 wsparcie psychiczne klientów
 wspieranie sprawności i aktywizowanie klientów do samodzielności
 radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami
 radzenie sobie z własnymi emocjami
 prowadzenie dokumentacji
 podstawowa znajomość odpowiednich przepisów prawnych (np. ustawy o
 pomocy społecznej)
 obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych (korzystanie z internetu,
 aplikacji mobilnych, spotkania online)
 komunikowanie się z rodzinami klientów
 komunikacja międzykulturowa i współpraca z cudzoziemcami
 1. wysokim
 2. średnim
 3. niskim

Pytanie 24. Jeżeli są jeszcze jakieś kompetencje istotne w {DPS: pracy opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania}, proszę je wymienić oraz wskazać, w jakim stopniu Państwa pracownicy je posiadają?

.....

Pytanie 25. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy {DPS: opiekunowie/opiekunki pracujący(-e)} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: osoby wykonujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania pracujące} w Państwa {OPS/CUS, DPS: jednostce} {Zleceniobiorcy:

organizacji/firmie} {DPS: brali} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: brały} udział w kursach lub szkoleniach, nie licząc BHP i Ppoż (ochrona przeciwpożarowa)?

tak → PRZEJDŹ DO 22.1

nie → PRZEJDŹ DO 23

Pytanie 25.1. Jakich obszarów / zagadnień dotyczyły te szkolenia? (proszę wybrać wszystkie obszary, których dotyczyły szkolenia dla {DPS: opiekunów} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania zatrudnionych} w Państwa {OPS/CUS, DPS: jednostce} {Zleceniobiorcy: organizacji/firmie} w ostatnich 12 miesiącach)

metody i standardy opieki nad osobami niesamodzielnymi

komunikacja i opieka nad osobami z demencją

ocena stanu klienta, identyfikacja potrzeb i planowanie pomocy

komunikacja z klientami

komunikacja z rodzinami / bliskimi klientów

wspieranie aktywności i samodzielności

profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego

bezpieczeństwo klienta i pierwsza pomoc

prowadzenie dokumentacji i aktualne przepisy prawne

obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych (korzystanie z internetu, aplikacji mobilnych, spotkania online)

komunikacja międzykulturowa i praca z cudzoziemcami

indywidualne podejście, przestrzeganie praw i wolności odbiorców wsparcia

bezpieczeństwo osobiste pracownika

inne (jakie?)

Pytanie 25.2. Czy organizując szkolenia dla {DPS: opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania}... (proszę wybrać wszystkie odpowiedzi, które Państwa dotyczą)

samodzielnie prowadzą Państwo szkolenia wykorzystując własne materiały i

zasoby kadrowe

korzystają Państwo z usług zewnętrznych podmiotów komercyjnych
prowadzących szkolenia

korzystają Państwo ze szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie

organizują Państwo szkolenia w inny sposób (jaki?)

Pytanie 26. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy {DPS: opiekunowie/opiekunki pracujący(-e)} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: osoby wykonujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania zatrudnione} w Państwa {OPS/CUS, DPS: jednostce} {Zleceniobiorcy: organizacji/firmie} brali udział w spotkaniach superwizyjnych?

tak

nie

Pytanie 27. Jak bardzo {DPS: opiekunom/opiekunkom} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: pracownikom wykonującym usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania} zatrudnionym w Państwa {OPS/CUS, DPS: jednostce} {Zleceniobiorcy: organizacji/firmie} potrzebna jest superwizja w celu wsparcia w codziennej pracy?

zupełnie niepotrzebna

mało potrzebna

potrzebna

bardzo potrzebna

Pytanie 28. Dlaczego pomimo zaobserwowanej potrzeby superwizji Państwa {DPS: opiekunowie/opiekunki} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania} w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie brali udziału w spotkaniach superwizyjnych? (proszę wybrać wszystkie odpowiedzi, które Państwa dotyczą)

brak dostępności odpowiednio wykwalifikowanych superwizorów

brak środków na organizację superwizji

niewystarczające informacje o możliwości skorzystania z superwizji

brak czasu lub przeciążenie pracowników obowiązkami zawodowymi

niska świadomość pracowników odnośnie korzyści płynących z udziału w

superwizji

inne (jakie?)

Część 4. Sposoby motywowania pracowników

Pytanie 29. Czy stosują Państwo jakieś dodatkowe sposoby motywowania {DPS: opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania}? (proszę wybrać wszystkie odpowiedzi, które Państwa dotyczą)

dofinansowanie do wypoczynku

pakiet prywatnej opieki medycznej

dofinansowanie do karty sportowej

elastyczny czas pracy (możliwość dopasowania godzin pracy do potrzeb pracownika)

transport do miejsca pracy

inne (jakie?)

żadne

Pytanie 30. (Zleceniobiorcy) Czy świadczyli Państwo usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na terenie województwa małopolskiego...

w 2019 roku

w 2022 roku

1. tak

2. nie

Część 5. Wyzwania związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Pytanie 31. (OPS/CUS, Zleceniobiorcy) Poniżej są wymienione niektóre aspekty funkcjonowania systemu związane z realizacją opieki / usług opiekuńczych. Proszę wskazać, w odniesieniu do każdego z nich, czy od wybuchu wojny na Ukrainie w danym obszarze nastąpił wzrost, spadek, czy też nie zaszła żadna zmiana.

(OPS/CUS) zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

(OPS/CUS) zapotrzebowanie na opiekę całodobową w DPS

obciążenie pracą osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
możliwości jednostki w zakresie świadczenia opieki w miejscu zamieszkania
liczba kandydatów na osoby wykonujące usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania pochodzenia ukraińskiego
liczba zatrudnionych osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania pochodzenia ukraińskiego

1. wzrost
2. brak zmiany
3. spadek

Pytanie 32. (DPS) Proszę wskazać, czy od wybuchu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy nastąpił wzrost, spadek, czy też nie zaszła żadna zmiana w liczbie kandydatów i pracowników pochodzenia ukraińskiego świadczących opiekę w DPS.

liczba kandydatów na opiekunów/opiekunek pochodzenia ukraińskiego
liczba zatrudnionych opiekunów/opiekunek pochodzenia ukraińskiego

1. wzrost
2. brak zmiany
3. spadek

Pytanie 33. Czy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie zaszły jeszcze jakieś zmiany lub pojawiły się nowe wyzwania, które miały wpływ na świadczenie {DPS: opieki lub pracę opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobioicy: opieki w miejscu zamieszkania lub pracę osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania}? Jeżeli tak, proszę wpisać, jakie.

.....

Część 6. Wyzwania związane z pandemią COVID-19

Pytanie 34. Które z następujących wyzwań dotknęły Państwa jednostkę ze względu na wybuch pandemii COVID-19? (proszę wybrać wszystkie odpowiedzi, które Państwa dotyczą)

- (DPS) pogorszenie się stanu zdrowia fizycznego mieszkańców
- (DPS) pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego mieszkańców
- (OPS/CUS, Zleceniobiorcy) utrudnienia w zakresie świadczenia opieki środowiskowej ze względu na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne
- większy stres i wypalenie zawodowe {DPS: opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania}
- częstsze odejścia z pracy {DPS: opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania}
- trudności z pozyskaniem nowych pracowników do {DPS: pracy jako opiekun/opiekunka} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania}
- (OPS/CUS, DPS) zwiększone koszty prowadzenia jednostki
- (OPS/CUS, DPS) mniejsze wsparcie finansowe
- inne (jakie?)
- żadne

Pytanie 35. Które z tych wyzwań nadal wywierają wpływ na funkcjonowanie jednostki? (proszę wybrać wszystkie odpowiedzi, które Państwa dotyczą)

- (DPS) pogorszenie się stanu zdrowia fizycznego mieszkańców
- (DPS) pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego mieszkańców
- (OPS/CUS, Zleceniobiorcy) utrudnienia w zakresie świadczenia opieki środowiskowej ze względu na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne
- większy stres i wypalenie zawodowe {DPS: opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania}
- częstsze odejścia z pracy {DPS: opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania}
- trudności z pozyskaniem nowych pracowników do {DPS: pracy jako

opiekun/opiekunka} {OPS/CUS, Zleceniobiorcy: wykonywania usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania}
(OPS/CUS, DPS) zwiększone koszty prowadzenia jednostki
(OPS/CUS, DPS) mniejsze wsparcie finansowe
inne (jakie?)
żadne

Pytanie 36. Czy w wyniku pandemii COVID-19 zaszły jakieś długoterminowe pozytywne zmiany w funkcjonowaniu Państwa {OPS/CUS, DPS: jednostki} (Zleceniobiorcy: organizacji/firmy)? (proszę wybrać wszystkie odpowiedzi, które Państwa dotyczą)

wprowadzenie narzędzi cyfrowych usprawniających pracę jednostki (np. w zakresie zarządzania i komunikacji wewnątrz jednostki)
większa elastyczność jednostki w zakresie reagowania na bieżące zmiany i potrzeby
lepszą koordynacją działań z innymi organami i instytucjami
wprowadzenie nowoczesnych technologii i wyposażenia zwiększającego jakość opieki {OPS/CUS: świadczonej w miejscu zamieszkania}
podniesienie kompetencji {DPS: opiekunów/opiekunek} {OPS/CUS: osób wykonujących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania}
zwiększone standardy sanitarno-epidemiologiczne związane ze świadczeniem opieki {OPS/CUS: w miejscu zamieszkania}
(DPS) większa indywidualizacja opieki
inne (jakie?)

Część 7. Informacja o jednostce

Pytanie 37. (DPS) Podmiot prowadzący DPS:

powiat
gmina
inny podmiot

Pytanie 38. Proszę wybrać {DPS: w którym powiecie znajduje się DPS} {OPS/CUS: powiat, w którym znajduje się Państwa gmina}:

bocheński
brzeski
chrzanowski
dąbrowski
gorlicki
krakowski
Kraków
limanowski
miechowski
myślenicki
nowosądecki
Nowy Sącz
nowotarski
olkuski
oświęcimski
proszowicki
suski
tarnowski
Tarnów
tatrzański
wadowicki
wielicki

Pytanie 39. (Zleceniobiorcy) Proszę wybrać formę organizacyjną Państwa podmiotu:

firma komercyjna
stowarzyszenie
fundacja
spółdzielnia socjalna
inny podmiot

Pytanie 40. (Zleceńbiocy) Jakiego rodzaju usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizuje Państwa podmiot? (proszę wybrać wszystkie odpowiedzi, które Państwa dotyczą)

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania tzw. "zwykłe"

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z

zaburzeniami psychicznymi

innego rodzaju usługi opiekuńcze (jakie?)

Pytanie 41. (OPS/CUS) Czy Państwa gmina jest gminą:

wiejską

miejską

miejsko-wiejską

Pytanie 42. Proszę podać nazwę Pani(-a) stanowiska:

.....

Kwestionariusz dla opiekunów zatrudnionych w OPS/CUS, podmiotach realizujących usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS, oraz DPS w Małopolsce

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w ankiecie skierowanej do pracowników świadczących środowiskowe usługi opiekuńcze lub opiekę całodobową w DPS.

Celem badania jest zebranie opinii na temat różnych aspektów pracy, takich jak zadowolenie, potrzeby szkoleniowe czy doświadczenie wypalenia zawodowego. Wyniki badania pomogą nam w lepszym zrozumieniu problemów opiekunów oraz budowaniu systemu wsparcia.

Proszę nie zamieszczać w ankiecie danych osobowych. Zebrane dane pozostaną anonimowe, a uzyskane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i przedstawiane w postaci zbiorczej.

Ankietę można wypełniać w odstępach czasowych. Aby zachować odpowiedzi należy wcisnąć przycisk "ODŁÓŻ" znajdujący się w prawym górnym rogu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anastazją Zakusiło (tel.: 12 422 06 36 w. 40, e-mail: azakusilo@rops.krakow.pl).

Dziękujemy za poświęcony czas!

Część 1. Ocena warunków pracy

Pytanie 1. Jaka jest Pana/Pani płeć?

kobieta

mężczyzna

Pytanie 2. Gdzie jest Pan(i) zatrudniony(-a) – miejsce pracy, z którego dowiedział(a) się Pan(i) o ankiecie?

w domu pomocy społecznej (DPS)

w ośrodku pomocy społecznej (OPS) lub centrum usług społecznych (CUS)

w innym podmiocie (firmie/organizacji pozarządowej/innym podmiocie)

Pytanie 3. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(-a) z następujących aspektów Pana(-i) pracy? (proszę ocenić poniższe aspekty na skali od 1 gwiazdki "bardzo niezadowolony(-a)" do 5 gwiazdek "bardzo zadowolony(-a)")

wysokość wynagrodzenia

pewność zatrudnienia

możliwość awansu

możliwość rozwoju zawodowego i osobistego (np. poprzez szkolenia)

uznanie społeczne wobec zawodu

ilość pracy

poziom bezpieczeństwa w pracy

skala napięć i stresu

możliwość wykorzystania swoich umiejętności i doświadczenia

możliwość pogodzenia pracy z życiem osobistym/rodzinnym

godzinowy wymiar pracy

wyposażenie w środki i narzędzia pracy

stosunki między kierownictwem a pracownikami

stosunki między współpracownikami



Część 2. Wypalenie zawodowe

Pytanie 4. Jak często w ostatnich miesiącach:

odczuwał(a) Pan(i) satysfakcję z wykonanej pracy

odczuwał(a) Pan(i) nadmiar obowiązków w pracy, którym nie mogła/mógł Pan(i) podołać

czuł(a) Pan(i), że Pani(-a) praca jest doceniana przez innych

był(a) Pan(i) traktowana(-y) niesprawiedliwie przez innych w pracy

odczuwał(a) Pan(i) motywację i zapał do pracy

czuł(a) Pan(i), że Pani(-a) praca jest zbyt uciążliwa, brudna lub niebezpieczna

czuł(a) Pan(i), że Pani(-a) praca ma sens

przez pracę czuł(a) się Pan(i) emocjonalnie wyczerpana(-y)

wymagania Pani(-a) pracy zawodowej kłóciły się z Pani(-a) życiem prywatnym lub rodzinnym

zdarzało się Pani(-u) przychodzić do pracy, mimo że czuł(a) się Pan(i) źle lub jest Pan(i)/ chora(-y)

1. bardzo często
2. często
3. czasami
4. prawie nigdy
5. nigdy

Część 3. Relacje w pracy, przywiązanie do pracy i plany zawodowe

Pytanie 5. Proszę ustosunkować się do następujących stwierdzeń:

Jestem dumna(-y) z rodzaju pracy, którą wykonuję

Jestem dumna(-y) z tego, że pracuję dla mojej firmy/instytucji

Gdybym miał(a) okazję, zmienił(a)bym rodzaj swojej obecnej pracy na jakiś inny

W mojej pracy pomiędzy współpracownikami panuje dobra atmosfera

Mogę liczyć na wsparcie współpracowników w razie potrzeby

1. zdecydowanie się nie zgadzam
2. nie zgadzam się
3. ani się zgadzam, ani nie zgadzam
4. zgadzam się
5. zdecydowanie się zgadzam
88. nie mam współpracowników

Pytanie 6. W jakim stopniu, jeśli w ogóle, obawia się Pan(i) utraty pracy?

bardzo się obawiam

trochę się obawiam

wcale się nie obawiam

Pytanie 7. Jak trudno lub łatwo byłoby Panu(-i) znaleźć nową pracę, co najmniej tak samo dobrą jak obecna?

- bardzo łatwo
- raczej łatwo
- ani łatwo ani trudno
- raczej trudno
- bardzo trudno

Pytanie 8. Biorąc wszystko pod uwagę, na ile prawdopodobne jest to, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zakończy Pan(i) pracę w obecnym miejscu zatrudnienia?

- bardzo prawdopodobne → PRZEJDŹ DO 8.1
- prawdopodobne → PRZEJDŹ DO 8.1
- mało prawdopodobne → PRZEJDŹ DO 9
- bardzo mało prawdopodobne → PRZEJDŹ DO 9

Pytanie 8.1. Jaki byłby najbardziej prawdopodobny powód zakończenia pracy w obecnym miejscu zatrudnienia?

- rozpoczęcie pracy w innym miejscu na podobnym stanowisku
- rozpoczęcie pracy w innym zawodzie
- przejsięcie na emeryturę
- rezygnacja z pracy zawodowej
- założenie własnej działalności gospodarczej
- inny powód (jaki?)

Część 4. Kompetencje i potrzeby szkoleniowe

Pytanie 9. Jak ocenia Pan(i) poziom swojej wiedzy i kompetencji w następujących obszarach? (proszę ocenić każdą pozycję na skali od 1 gwiazdki "niski" do 5 gwiazdek "bardzo wysoki")?

- znajomość zasad i standardów opieki nad osobą starszą, niesamodzielną, z niepełnosprawnościami
- komunikacja z osobami z demencją

opieka nad osobami z demencją
rozpoznawanie i ocenianie stanu i możliwości funkcjonowania fizycznego,
psychicznego i społecznego klienta/mieszkańca
opracowywanie planu pomocy i opieki dla klienta/mieszkańca uwzględniając
poziom jego możliwości psychofizycznych
higiena i pielęgnacja osób niesamodzielnych
asystowanie w czynnościach dnia codziennego
wykonywanie zabiegów prozdrowotnych
udzielanie pierwszej pomocy
nawiązywanie kontaktu i skuteczne komunikowanie się z klientami/mieszkańcami
wsparcie psychiczne klientów
wspieranie sprawności i aktywizowanie klientów/mieszkańców do samodzielności
radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami
radzenie sobie z własnymi emocjami
prowadzenie dokumentacji
podstawowa znajomość odpowiednich przepisów prawnych (np. ustawy o
pomocy społecznej)
obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych (korzystanie z internetu,
aplikacji mobilnych, spotkania online)
komunikowanie się z rodzinami klientów/mieszkańców
komunikacja międzykulturowa i współpraca z cudzoziemcami



Pytanie 10. Czy Pana(-i) obecne kompetencje pozwalają na optymalne wykonywanie obowiązków zawodowych?

- zdecydowanie tak
- raczej tak
- raczej nie
- zdecydowanie nie

Pytanie 11. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzięła/wziął Pan(i) udział w superwizji?

tak

nie

Pytanie 12. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzięł/wzięła Pan(i) udział w kursach i/lub szkoleniach, nie licząc BHP i szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

tak → PRZEJDŹ DO 12.1

nie → PRZEJDŹ DO 13

Pytanie 12.1. Czy te szkolenia były zorganizowane przez: (proszę wybrać wszystkie opcje, które Pana(-ią) dotyczą)

pracodawcę

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

inny podmiot

nie wiem

Pytanie 12.2. Jakiej tematyki dotyczyły te szkolenia/kursy? (proszę wybrać wszystkie opcje, które Pana(-ią) dotyczą)

metody i standardy opieki nad osobami niesamodzielnymi

komunikacja i opieka nad osobami z demencją

ocena stanu klienta, identyfikacja potrzeb i planowanie pomocy

komunikacja z klientami

komunikacja z rodzinami / bliskimi klientów

wspieranie aktywności i samodzielności

profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego

bezpieczeństwo klienta i pierwsza pomoc

prowadzenie dokumentacji i aktualne przepisy prawne

obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych (np. korzystanie z

internetu, aplikacji mobilnych, spotkania online)

komunikacja międzykulturowa i praca z cudzoziemcami

indywidualne podejście, przestrzeganie praw i wolności odbiorców wsparcia

bezpieczeństwo osobiste pracownika

inne (jakie?)

Pytanie 13. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wziął/wzięła Pan(i) udział w kursach i/lub szkoleniach, które opłacił(a) Pan(i) sam(a)?

tak → PRZEJDŹ DO 13.1

nie → PRZEJDŹ DO 14

Pytanie 13.1. Jakiej tematyki dotyczyły te szkolenia/kursy? (proszę wybrać wszystkie opcje, które Pana(-ią) dotyczą)

metody i standardy opieki nad osobami niesamodzielnymi

komunikacja i opieka nad osobami z demencją

ocena stanu klienta, identyfikacja potrzeb i planowanie pomocy

komunikacja z klientami

komunikacja z rodzinami / bliskimi klientów

wspieranie aktywności i samodzielności

profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego

bezpieczeństwo klienta i pierwsza pomoc

prowadzenie dokumentacji i aktualne przepisy prawne

obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych (np. korzystanie z

internetu, aplikacji mobilnych, spotkania online)

komunikacja międzykulturowa i praca z cudzoziemcami

indywidualne podejście, przestrzeganie praw i wolności odbiorców wsparcia

bezpieczeństwo osobiste pracownika

inne (jakie?)

Pytanie 14. Jakie formy doskonalenia zawodowego byłyby obecnie najbardziej przydatne dla Pana(-i) (proszę wybrać wszystkie opcje, które Pana(-ią) dotyczą)

kursy i szkolenia

studia podyplomowe (proszę wpisać jakie)

studia licencjackie/magisterskie (proszę wpisać jakie)

superwizja i mentoring

wizyty studyjne (proszę wpisać jakie)
konferencje i seminaria (proszę wpisać jakie)
inne (jakie?)
żadne

Pytanie 15. (jeżeli p. 14 „kursy i szkolenia” = 1) Jakiego rodzaju kursy lub szkolenia byłyby dla Pana(-i) najbardziej przydatne? (proszę wybrać wszystkie obszary, które uważa Pan(i) za najbardziej przydatne)

metody i standardy opieki nad osobami niesamodzielnymi
komunikacja i opieka nad osobami z demencją
ocena stanu klienta, identyfikacja potrzeb i planowanie pomocy
komunikacja z klientami
komunikacja z rodzinami / bliskimi klientów
wspieranie aktywności i samodzielności
profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
bezpieczeństwo klienta i pierwsza pomoc
prowadzenie dokumentacji i aktualne przepisy prawne
obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych (np. korzystanie z internetu, aplikacji mobilnych, spotkania online)
komunikacja międzykulturowa i praca z cudzoziemcami
indywidualne podejście, przestrzeganie praw i wolności odbiorców wsparcia
bezpieczeństwo osobiste pracownika
inne (jakie?)

Część 5. Forma zatrudnienia, wymiar i tryb pracy

Pytanie 16. Czy pracuje Pan(i)...

w jednym miejscu pracy
w kilku miejscach pracy (proszę wpisać w ilu) |__|__|

Pytanie 17. W jakiej formie jest Pan(i) zatrudniona(-y) - miejsce pracy, z którego dowiedział(a) się Pan(i) o ankiecie?

umowa o pracę na czas określony

umowa o pracę na czas nieokreślony
umowa zlecenie
inna forma zatrudnienia (jaka?)

Pytanie 18. Ile przeciętnie godzin w tygodniu Pan(i) pracuje, biorąc pod uwagę wszystkie miejsca pracy?

|_|_| godzin

Pytanie 19. Ile przeciętnie godzin w tygodniu Pan(i) pracuje - miejsce pracy, z którego dowiedział(a) się Pan(i) o ankiecie?

|_|_| godzin

Pytanie 20. Ile przeciętnie razy w tygodniu zdarza się Panu(-i) wykonywać pracę w godzinach nocnych (czyli pomiędzy godziną 23. a 6.), biorąc pod uwagę wszystkie miejsca pracy?

|_| razy w tygodniu

Pytanie 21. Ile przeciętnie dni w miesiącu zdarza się Panu(-i) wykonywać pracę w sobotę lub niedzielę, biorąc pod uwagę wszystkie miejsca pracy?

|_| razy w miesiącu

Pytanie 22. (OPS, Zleceniobiorcy) Na jakim terenie Pan(i) pracuje (wykonując usługi opiekuńcze) - miejsce pracy, z którego dowiedział(a) się Pan(i) o ankiecie?

miasto
wieś
zarówno miasto, jak i wieś

Pytanie 23. (DPS) Na jakim terenie jest zlokalizowana jednostka, w której Pan(i) pracuje - miejsce pracy, z którego dowiedział(a) się Pan(i) o ankiecie?

miasto
wieś
zarówno miasto, jak i wieś

Pytanie 24. Czy ma Pan(i) współpracowników pracujących na tym samym lub podobnym stanowisku co Pan(i) - miejsce pracy, z którego dowiedział(a) się Pan(i) o ankiecie?

tak → PRZEJDŹ DO 24.1

nie → PRZEJDŹ DO 25

Pytanie 24.1. Czy wykonuje Pan(i) swoje zadania w pracy w większości samodzielnie czy też wspólnie z innymi współpracownikami - miejsce pracy, z którego dowiedział(a) się Pan(i) o ankiecie?

w całości samodzielnie

w większości samodzielnie

w równym stopniu samodzielnie co wspólnie z innymi współpracownikami

w większości wspólnie z innymi współpracownikami

w całości wspólnie z innymi współpracownikami

Pytanie 25. W którym roku się Pan(i) urodził(a)?

|_|_|_|_|

Pytanie 26. Jak długo jest Pan(i) zatrudniony(-a) - miejsce pracy, z którego dowiedział(a) się Pan(i) o ankiecie? Proszę wpisać liczbę lat. Jeżeli pracuje Pan(i) krócej niż rok proszę wpisać "0", a następnie wpisać liczbę miesięcy w kolejnym polu.

|_|_| lat

|_|_| miesiący

Pytanie 27. Jakiego jest Pani(-a) wykształcenie?

podstawowe → PRZEJDŹ DO 28

gimnazjalne → PRZEJDŹ DO 28

zasadnicze zawodowe / zasadnicze branżowe → PRZEJDŹ DO 27.1

średnie zawodowe → PRZEJDŹ DO 27.1

policealne / pomaturalne → PRZEJDŹ DO 27.1

średnie ogólnokształcące → PRZEJDŹ DO 28

wyższe → PRZEJDŹ DO 27.1

Pytanie 27.1. Jaki był Pana(-i) kierunek kształcenia? Jeżeli kształcił(a) się Pan(i) na kilku kierunkach, proszę wskazać wszystkie.

.....

Pytanie 28. Czy poza pracą ma Pan(i) pod opieką dzieci w wieku do 12 lat lub inne osoby zależne (np. starsze, przewlekłe chorujące, z niepełnosprawnościami)?

tak

nie

Pytanie 29. Czy wypełnia Pan(i) ankietę na:

komputerze lub laptopie

telefonie

tablecie

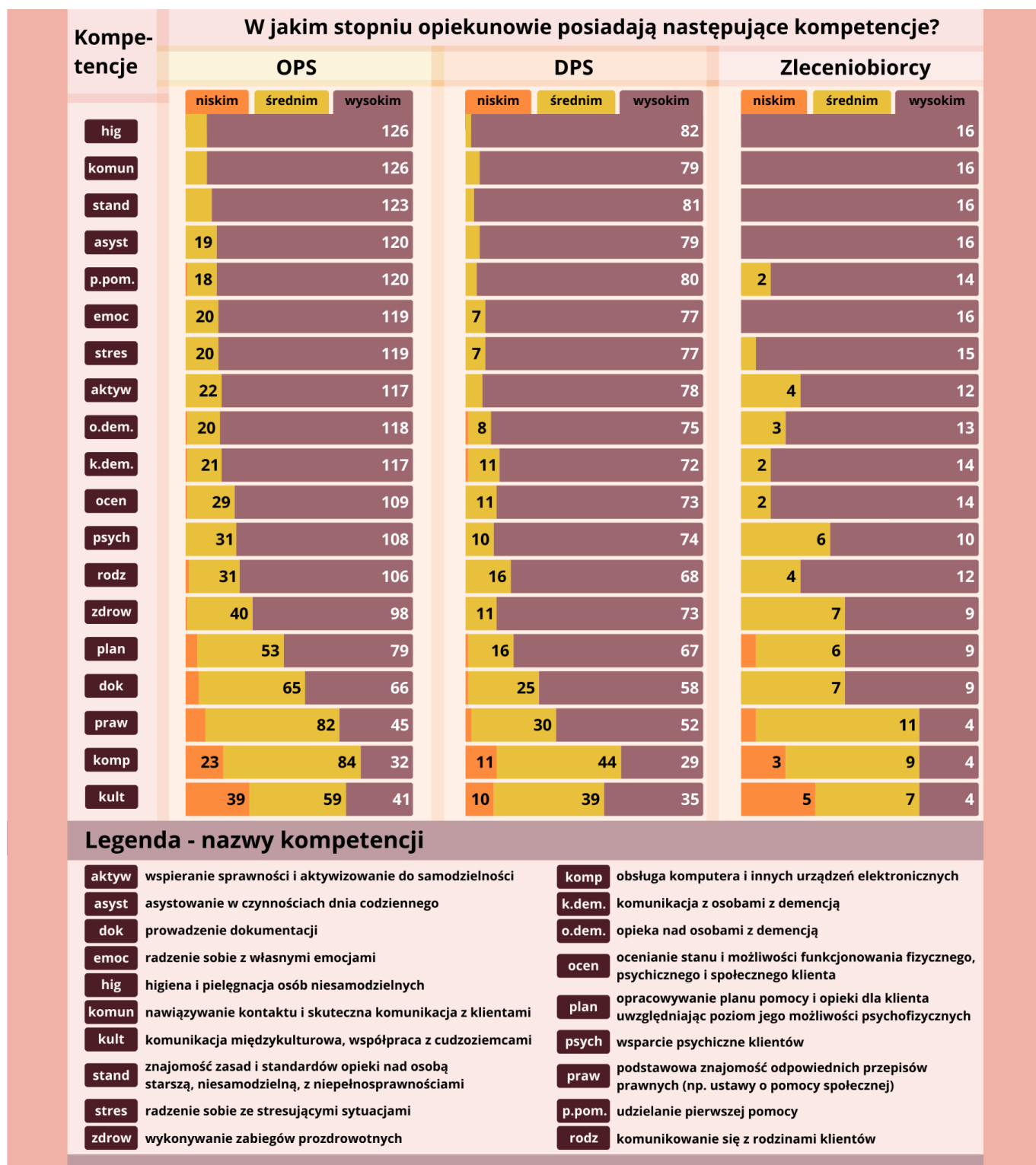
innym urządzeniu (jakim?)

Pytanie 30. Czy chciał(a)by Pan(i) jeszcze czymś się z nami podzielić?

.....

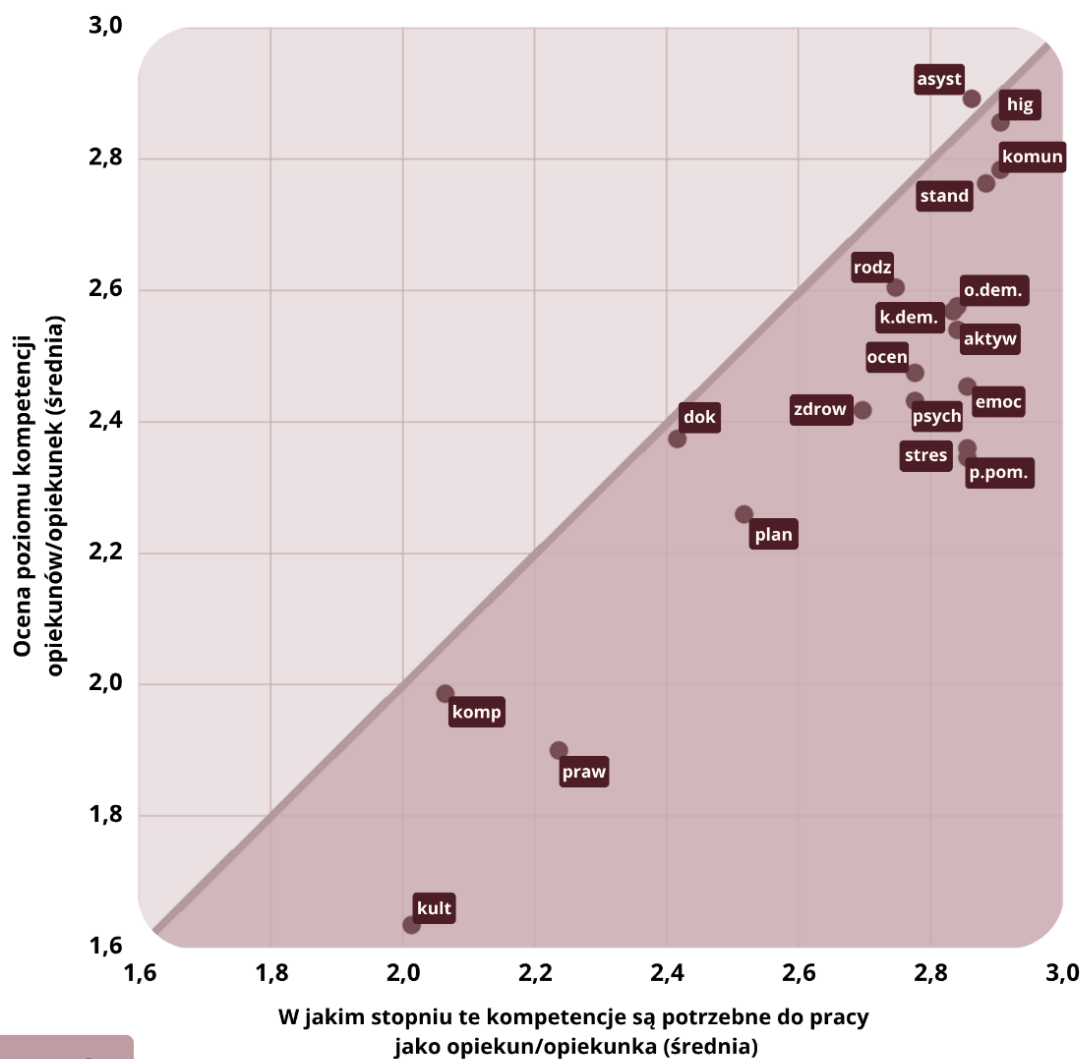
Grafiki uzupełniające

Infografika 22. Ocena poziomu kompetencji opiekunów formalnych przez OPS/CUS, DPS oraz podmioty realizujące usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS potrzebne do pracy jako opiekun



Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zleceńbiorky) = 16.

Infografika 23. Zależność między średnim poziomem kompetencji opiekunów/opiekunek formalnych przez OPS/CUS, a zapotrzebowaniem na poszczególne kompetencje wymagane w zawodzie opiekuna

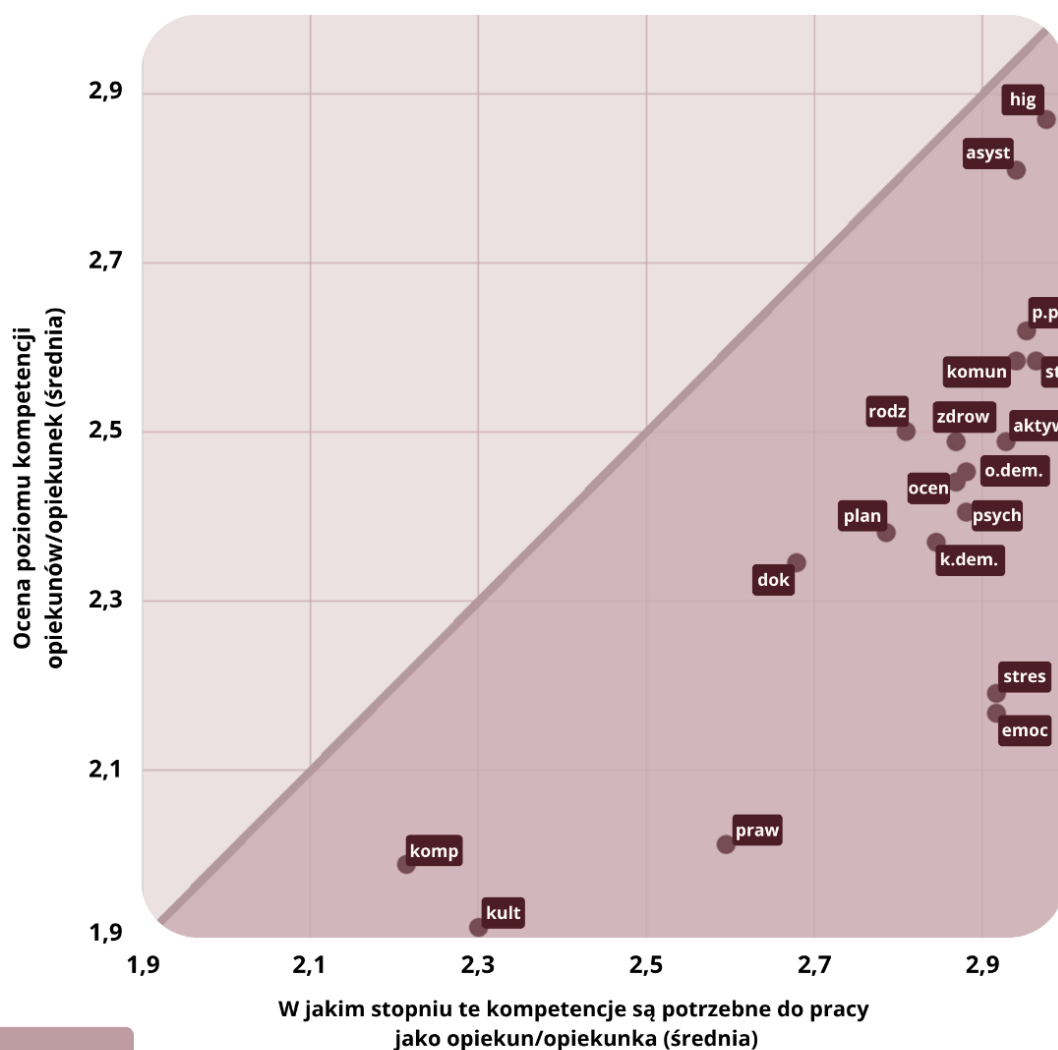


Legenda

aktyw	wspieranie sprawności i aktywizowanie do samodzielności	komp	obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych
asyst	asystowanie w czynnościach dnia codziennego	k.dem.	komunikacja z osobami z demencją
dok	przewodzenie dokumentacji	o.dem.	opieka nad osobami z demencją
emoc	radzenie sobie z własnymi emocjami	ocen	ocenianie stanu i możliwości funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego klienta
hig	higiena i pielęgnacja osób niesamodzielnych	plan	opracowywanie planu pomocy i opieki dla klienta uwzględniając poziom jego możliwości psychofizycznych
komun	nawiązywanie kontaktu i skuteczna komunikacja z klientami	psych	wsparcie psychiczne klientów
kult	komunikacja międzykulturowa, współpraca z cudzoziemcami	praw	podstawowa znajomość odpowiednich przepisów prawnych (np. ustawy o pomocy społecznej)
stand	znajomość zasad i standardów opieki nad osobą starszą, niesamodzielną, z niepełnosprawnościami	p.pom.	udzielanie pierwszej pomocy
stres	radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami	rodz	komunikowanie się z rodzinami klientów
zdrow	wykonywanie zabiegów prozdrowotnych		

Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zleceniobiorcy) = 16.

Infografika 24. Zależność między średnim poziomem kompetencji opiekunów/opiekunek formalnych przez DPS, a zapotrzebowaniem na poszczególne kompetencje wymagane w zawodzie opiekuna

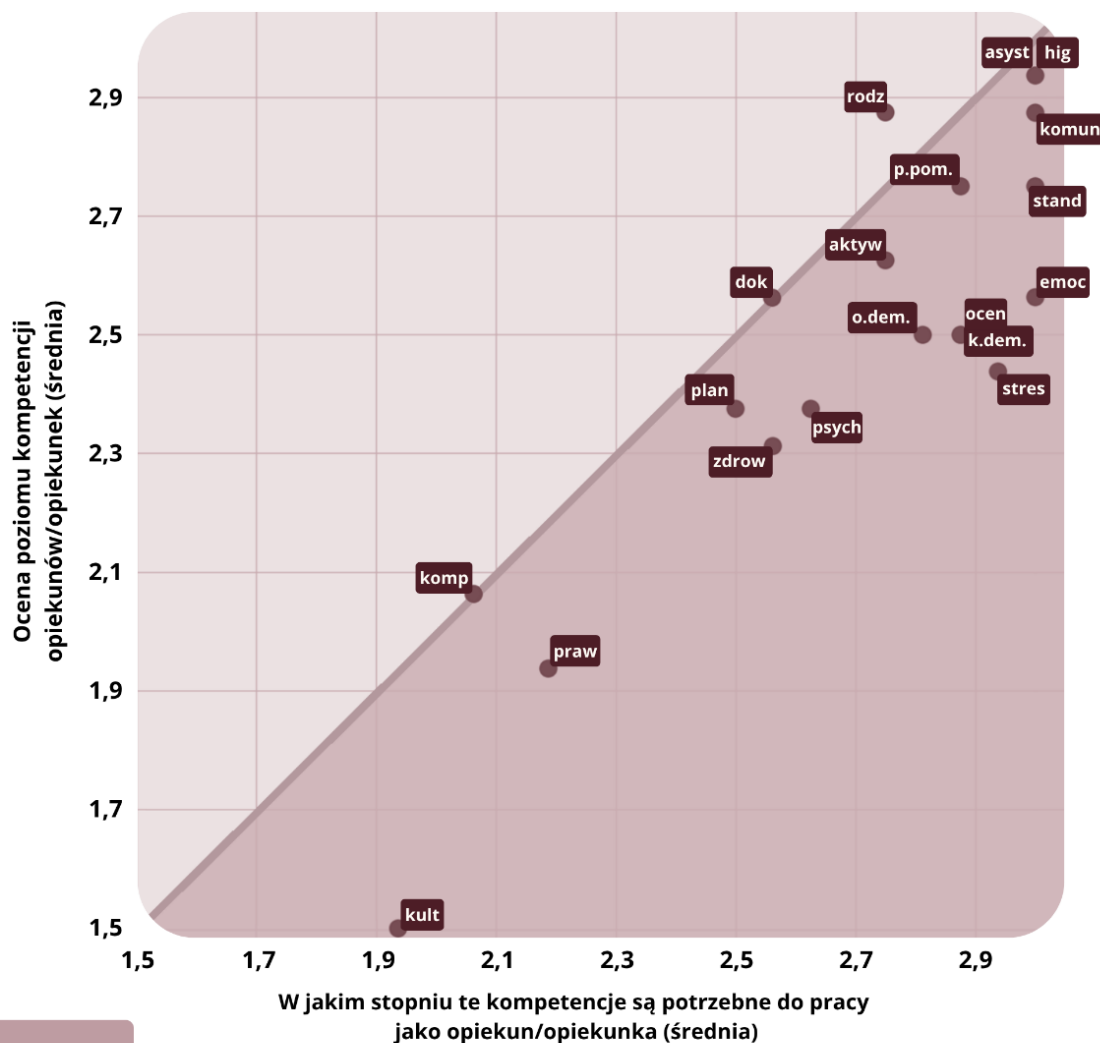


Legenda

aktyw	wspieranie sprawności i aktywizowanie do samodzielności	komp	obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych
asyst	asystowanie w czynnościach dnia codziennego	k.dem.	komunikacja z osobami z demencją
dok	przewodzenie dokumentacji	o.dem.	opieka nad osobami z demencją
emoc	radzenie sobie z własnymi emocjami	ocen	ocenianie stanu i możliwości funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego klienta
hig	higiena i pielęgnacja osób niesamodzielnych	plan	opracowywanie planu pomocy i opieki dla klienta uwzględniając poziom jego możliwości psychofizycznych
komun	nawiązywanie kontaktu i skuteczna komunikacja z klientami	psych	wsparcie psychiczne klientów
kult	komunikacja międzykulturowa, współpraca z cudzoziemcami	praw	podstawowa znajomość odpowiednich przepisów prawnych (np. ustawy o pomocy społecznej)
stand	znajomość zasad i standardów opieki nad osobą starszą, niesamodzielną, z niepełnosprawnościami	p.pom.	udzielanie pierwszej pomocy
stres	radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami	rodz	komunikowanie się z rodzinami klientów
zdrow	wykonywanie zabiegów prozdrowotnych		

Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zleceniobiorcy) = 16.

Infografika 25. Zależność między średnim poziomem kompetencji opiekunów/opiekunek formalnych przez podmioty realizujące usługi opiekuńcze na zlecenie OPS/CUS, a znaczeniem tych kompetencji w zawodzie opiekuna

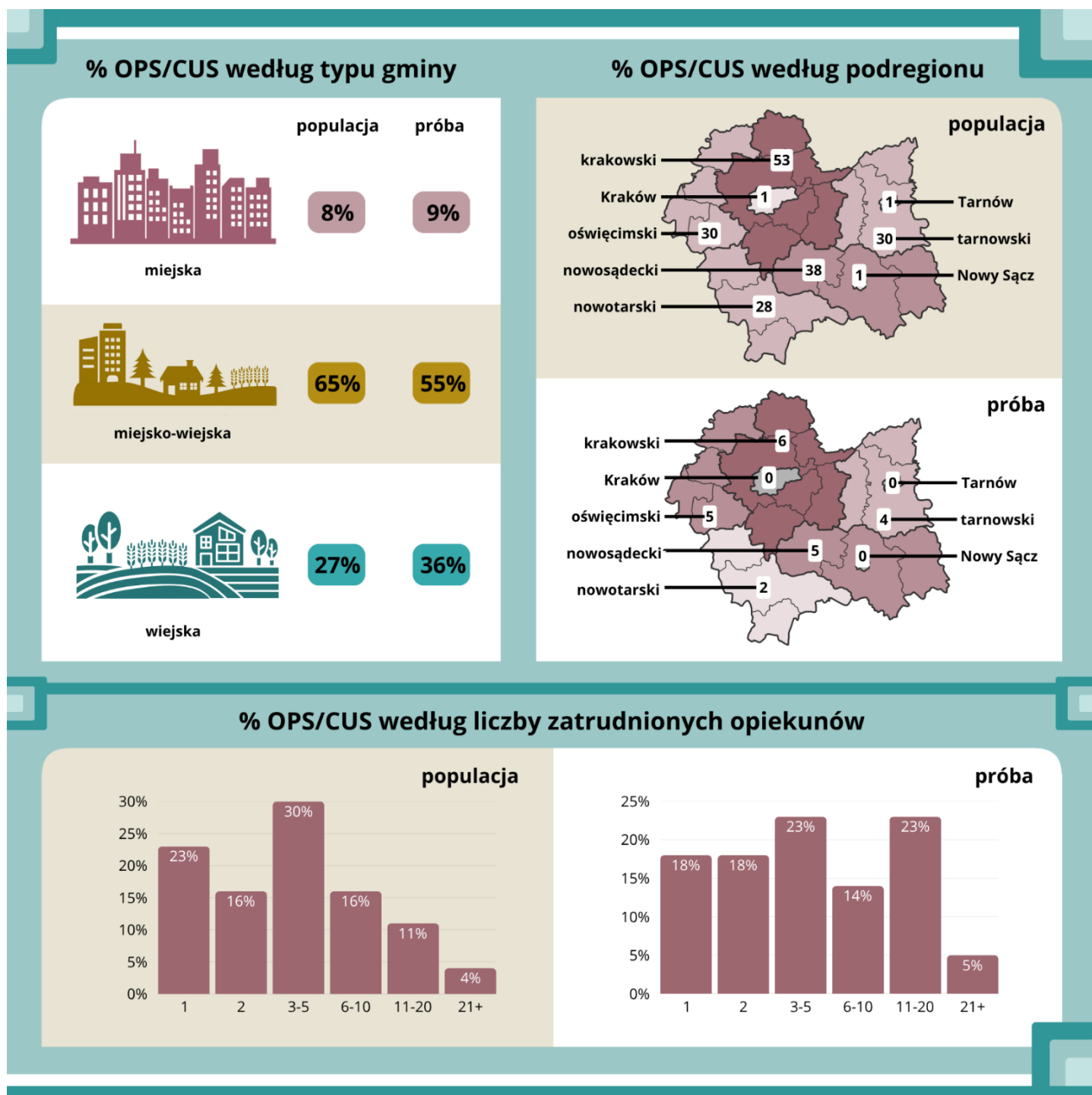


Legenda

aktyw	wspieranie sprawności i aktywizowanie do samodzielności	komp	obsługa komputera i innych urządzeń elektronicznych
asyst	asystowanie w czynnościach dnia codziennego	k.dem.	komunikacja z osobami z demencją
dok	prowadzenie dokumentacji	o.dem.	opieka nad osobami z demencją
emoc	radzenie sobie z własnymi emocjami	ocen	ocenianie stanu i możliwości funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego klienta
hig	higiena i pielęgnacja osób niesamodzielnych	plan	opracowywanie planu pomocy i opieki dla klienta uwzględniając poziom jego możliwości psychofizycznych
komun	nawiązywanie kontaktu i skuteczna komunikacja z klientami	psych	wsparcie psychiczne klientów
kult	komunikacja międzykulturowa, współpraca z cudzoziemcami	praw	podstawowa znajomość odpowiednich przepisów prawnych (np. ustawy o pomocy społecznej)
stand	znajomość zasad i standardów opieki nad osobą starszą, niesamodzielną, z niepełnosprawnościami	p.pom.	udzielanie pierwszej pomocy
stres	radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami	rodz	komunikowanie się z rodzinami klientów
zdrow	wykonywanie zabiegów prozdrowotnych		

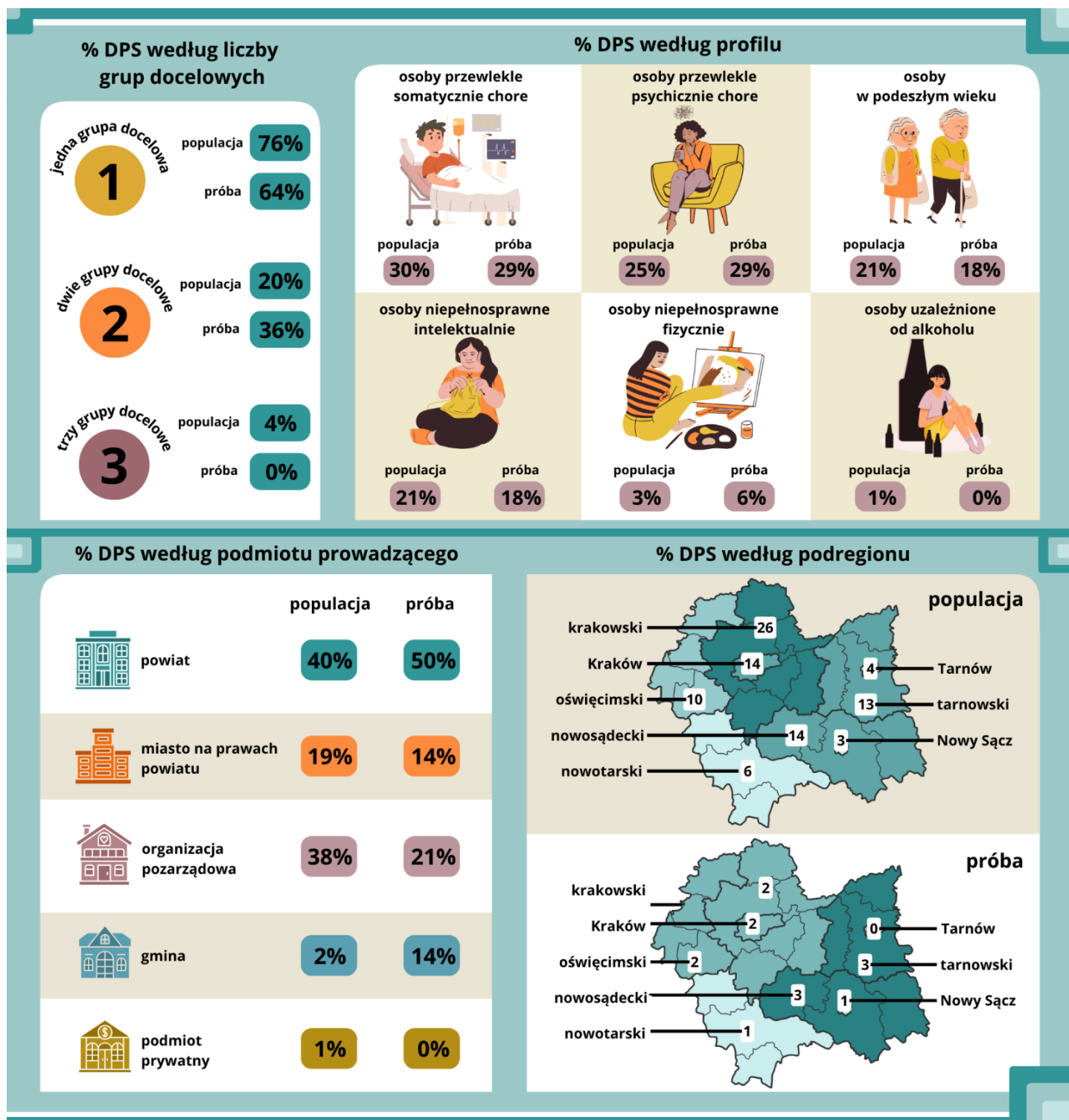
Źródło: ROPS w Krakowie - Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (OPS/CUS) = 160, N (DPS) = 84, N (Zlezeniobiorcy) = 16.

Infografika 26. Charakterystyka populacji i próby OPS/CUS do badania opiekunów formalnych (badanie wśród wszystkich opiekunów zatrudnionych w wybranych jednostkach)



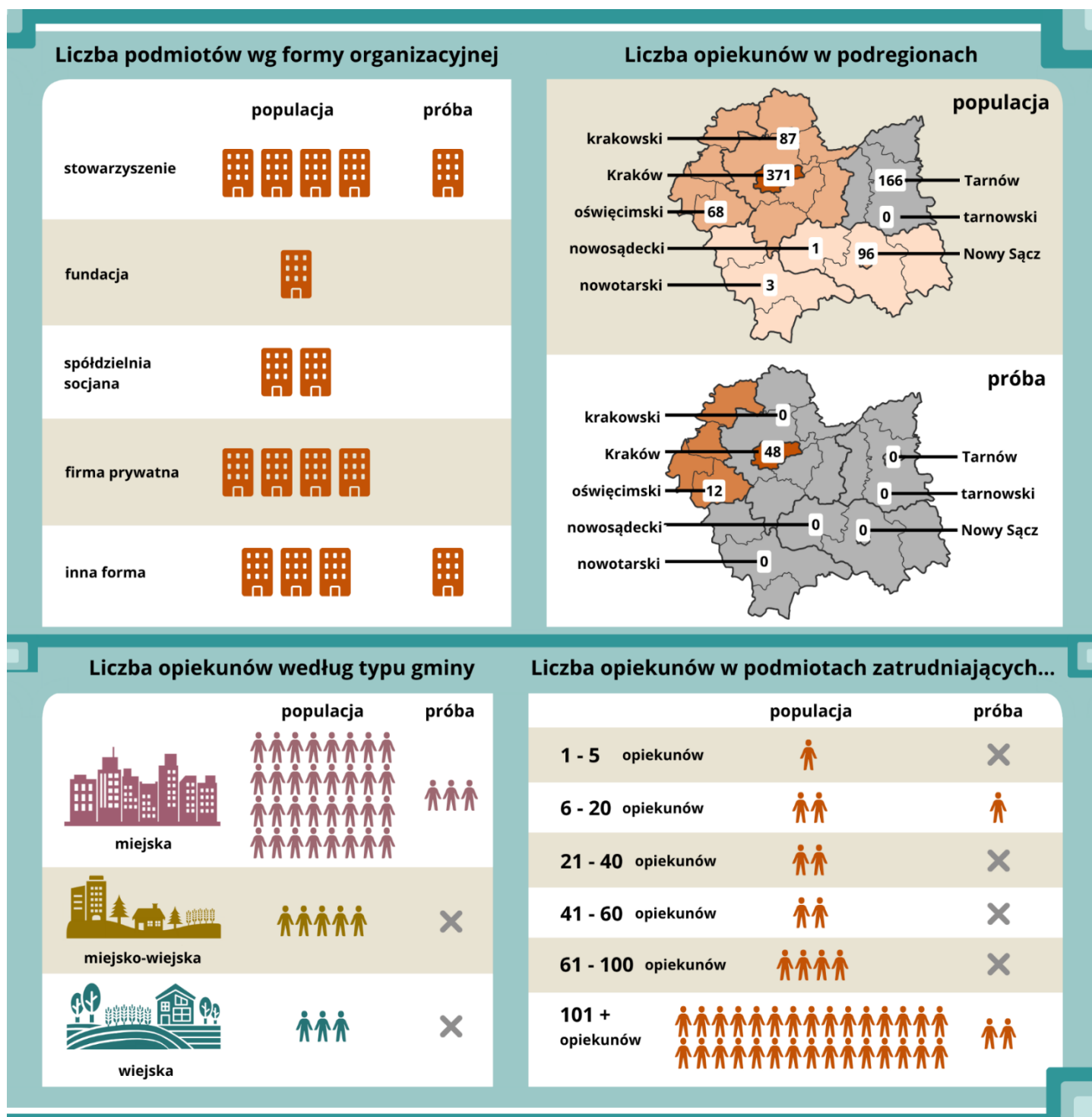
Źródło: Dane Głównego urzędu statystycznego za 2025 r., Badanie wśród osób zarządzających (etap I).

Infografika 27. Charakterystyka populacji i próby DPS do badania opiekunów formalnych (dobór próby mieszany)



Źródło: Rejestr Domów Pomocy Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, stan na 10.03.2025 r.

Infografika 28. Charakterystyka populacji i próby Zleceniobiorców oraz opiekunów w nich zatrudnionych do badania opiekunów formalnych (dobór próby mieszany)



Źródło: dane OZPS 2023, Badanie wśród osób zarządzających (etap I), N (Zleceniobiorcy) = 16.
 Legenda: jedna ikonka domu odpowiada 1 podmiotowi, jedna ikonka osoby – 20 opiekunom.



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie

ul. Piastowska 32
30-070 Kraków



+48 12 422 06 36



www.rops.krakow.pl



@ROPS.Krakow

